

肾病辨治

华北东北八所中医院校编写组



PDG

1337
G8
304
8

自学中医之路丛书

肾病辨治

河北中医学院 主编

审 阅

黑龙江中医学院

长春中医学院

辽宁中医学院

内蒙古医学院中医系

天津中医学院

北京中医学院

北京中医学院分校



天津科学技术出版社

1168933

2K71/03

执笔人(以姓氏笔画为序)

李 浩

李寿龄

赵玉唐

自学中医之路丛书

肾 病 辨 治

河北中医学院 主编

审 阅

黑龙江中医学院 长春中医学院

辽宁中医学院 内蒙古医学院中医系

天津中医学院 北京中医学院

北京中医学院分院

责任编辑: 王伯海

天津科学技术出版社出版

天津市东马路180号

山东省临沭县印刷厂印刷

新华书店天津发行所发行

开本787×1092毫米 1/32 印张6.5 字数134,000

1987年12月第1版

1987年12月第1次印刷

印数: 1—10,850

书号: 14212·244 定价: 1.25元

ISBN 7-5308-0116-3/R·41

编者的话

历史悠久的中国医药学，有着独特的理论体系和丰富的临床经验。在当今世界医学之林中愈发闪耀着夺目的光彩，国内外学者越来越看到中医学宝库的巨大蕴藏量及其对世界科学的深远影响。从而，形成学习、研究中医药学的热潮，并且呈现出日益国际化的发展趋势。

然而，中医古籍汗牛充栋，浩如烟海，且文理古奥，颇难索解。初学之人，常感无从入手，叹为观止。为了适应学习中医的需要，我们编写了这套《自学中医之路》丛书，以供初学中医人员及广大中医工作者和西医学习中医等同志们在教学、医疗工作中应用与参考。

本丛书的内容包括中医基础理论和临床辨证论治两部分，共十六个分册。计有阴阳五行学说、病因病机学说、脏腑经络学说、诊法概要、八纲与八法、六经辨证、卫气营血辨证、脏腑病证常用方药、心病辨治、肝病辨治、脾病辨治、肺病辨治、肾病辨治、中医病案分析、历代临证格言选萃、针灸与按摩。

编写中，我们本着：①理论联系实际的原则。对基础理论的阐述，力求概念准确，逻辑性强，思维清晰，切合实用；五脏辨治等分册，结合内、外、妇、儿等学科常见病证，详细介绍辨证论治的规律与方法。②保持中医理论的科学性，系统性和完整性。尽量避免某些教材中存在的不必要的

重复、冗繁和脱节。做到深入浅出，简明精练。各分册能够独立成章，又使全丛书统一、协调，成为有机的整体。③本书内容的深度和广度，以最近卫生部组织编写并审定的全国高等中医药教材为依据，并汲取各院校教学、医疗、科研的新成果、新经验。可以说，本丛书既是自学中医的普及读物，又可作中医院校的辅导教材。

本丛书是由天津科学技术出版社组稿，由天津中医学院、北京中医学院、北京中医学院分院、黑龙江中医学院、长春中医学院、辽宁中医学院、河北中医学院、内蒙古医学院等八所院校集体编写的。在全体编写人员的努力和天津科学技术出版社编辑同志的协助下，历时二年，几经修订，才得以奉献给广大读者。书中不足之处恳请批评指正，以便使本书进一步修改、完善，更好地为中医事业的发展发挥出应有的作用。

《自学中医之路》丛书编写组

1986年8月

目 录

一、肾阳虚	(2)
(一) 阳痿	(4)
(二) 遗精	(6)
(三) 早泄	(9)
(四) 不育	(11)
(五) 尿浊	(12)
(六) 淋证	(14)
(七) 癃闭	(15)
(八) 关格	(17)
(九) 遗尿、小便不禁	(20)
(十) 腰痛	(21)
(十一) 耳鸣、耳聋	(28)
(十二) 感冒	(25)
(十三) 内伤发热	(27)
(十四) 喘证	(29)
(十五) 哮证	(31)
(十六) 饮证	(32)
(十七) 泄泻	(35)
(十八) 痢疾	(37)
(十九) 便秘	(39)
(二十) 噎膈	(41)
(二十一) 头痛	(43)
(二十二) 眩晕	(45)

(二十三)崩漏	(47)
(二十四)绝经前后诸症	(48)
(二十五)妊娠肿胀	(50)
(二十六)妊娠小便不通	(51)
(二十七)不孕症	(52)
二、肾阴虚	(54)
(一)内伤发热	(55)
(二)咳嗽	(57)
(三)喘证	(59)
(四)哮证	(60)
(五)膏淋	(62)
(六)劳淋	(63)
(七)尿浊	(64)
(八)消渴	(65)
(九)遗精	(68)
(十)妊娠失音	(70)
三、肾虚水泛	(71)
(一)水肿	(72)
(二)心悸	(74)
四、肾不纳气	(76)
五、肾气不充	(78)
(一)癃闭	(79)
(二)带下	(80)
(三)胎漏	(81)
(四)产后排尿异常	(82)
(五)阴挺下脱	(83)
六、肾精不足	(84)
(一)眩晕	(86)

(二) 中风	(88)
(三) 耳鸣、耳聋	(89)
(四) 腰痛	(89)
(五) 头痛	(91)
(六) 阳痿	(92)
(七) 须发早白	(93)
(八) 虚劳	(94)
(九) 月经过少	(96)
(十) 崩漏	(97)
(十一) 绝经前后诸症	(97)
(十二) 不孕症	(98)
七、阴虚火旺	(98)
(一) 内伤发热	(100)
(二) 肺癆	(101)
(三) 咳血	(103)
(四) 齿衄	(105)
(五) 便血	(106)
(六) 尿血	(107)
(七) 消渴	(109)
(八) 遗精	(110)
(九) 淋证	(112)
(十) 眩晕	(113)
(十一) 不寐	(114)
(十二) 汗证	(116)
(十三) 阳强	(117)
(十四) 月经先期	(118)
(十五) 经期延长	(120)
(十六) 经行发热	(121)

(十七)崩漏	(122)
(十八)胎漏、胎动不安	(123)
(十九)妊娠小便淋痛	(124)
(二十)产后发热	(126)
(二十一)阴瘕	(127)
八、阴阳两虚	(129)
(一)肺癆	(130)
(二)水肿	(131)
(三)消渴	(132)
(四)遗精	(134)
(五)腰痛	(135)
(六)眩晕	(136)
(七)月经先后无定期	(137)
(八)崩漏	(138)
(九)绝经前后诸症	(139)
九、肝肾阴虚	(139)
(一)痛证	(140)
(二)痿证	(142)
(三)痹证	(143)
(四)痛经	(145)
(五)绝经前后诸症	(146)
十、肺肾阴虚	(147)
(一)经行吐衄	(148)
(二)妊娠咳嗽	(149)
十一、肾虚痰盛	(150)
十二、肾虚血瘀	(151)
十三、膀胱湿热	(152)
(一)淋证	(153)

(二) 癃闭	(153)
附篇：常见病证	(155)
一、遗精	(155)
二、阳痿	(156)
三、水肿	(157)
四、癃闭	(159)
五、内伤发热	(161)
六、痹证	(162)
七、消渴	(164)
八、淋证	(165)
九、虚劳	(167)
十、痿证	(170)
十一、耳鸣、耳聋	(171)
十二、尿血	(173)
十三、便血	(175)
十四、闭经	(177)
十五、绝经前后诸症	(178)
十六、胎漏、胎动不安	(179)
十七、妊娠失音	(180)
十八、妊娠肿胀	(181)
十九、妊娠小便不通	(182)
二十、妊娠小便淋痛	(182)
二十一、产后排尿异常	(184)
二十二、不孕症	(184)
二十三、小儿泌尿系感染	(185)
二十四、小儿急性肾炎	(187)
二十五、小儿肾病	(189)
二十六、小儿遗尿	(190)

二十七、新生儿不乳	(191)
二十八、新生儿大便不通	(192)
二十九、新生儿小便不通	(193)
三十、解颅	(193)
三十一、鸡胸、龟背	(194)
三十二、五迟、五软	(196)

肾是人体重要脏腑之一，位于腰部，左右各一，形如豇豆，附于脊之两旁。

肾为水火之脏，内藏元阴元阳，是人体生命之根。肾有藏精，生髓，主骨的作用，是人体生殖与发育的本源；肾之精髓上充于脑；肾之精气上通于耳；肾之精血滋养于毛发，使之成为肾之外华。肾还有主水，司二便的作用，不仅能主持和调节人体的水液代谢，同时对大便的正常排出也有重要的影响。肾的纳气作用可使吸入之气下纳归肾，并与“肺主吸气”相互配合，谐调有度，维持人体正常的呼吸。

肾藏真阴而寓元阳，只宜固藏，不宜泄露，所以肾病以虚证为多。常见病因病机主要为，禀赋不足，素体肾亏，劳倦过度，房室不节；久病及肾，肾失充养等。多引起肾阴亏虚，阴虚火旺；肾阳不足，肾虚水泛；肾不纳气，肾气不固等各种病理变化。

根据肾的生理功能与特性，因肾病多属虚证，故其治疗原则突出培补，慎于攻伐。具体治法，阴虚者当以滋阴补肾为法，不宜过用辛温燥烈及苦燥之品；阳虚者当以补肾助阳为主，不宜过用凉润与辛散；阴阳两虚者法当阴阳并补，以求阴平阳秘。至于兼见虚火、虚寒、阳亢、水停以及气失摄纳、封藏不固、脏腑兼病等，则应辨其标本缓急与主次加以治之。

肾与膀胱为表里之脏。膀胱者位于小腹，膀胱质薄柔韧，为藏贮津液之场所，在肾的气化作用下，维持正常开合，以使水液顺利排出。故膀胱有病多出现排尿失常，如不利、癃闭、频数、失禁等。膀胱之病有虚实之分。实热证多由湿热蕴结，或它脏移热而来；虚寒证多由肾气不化，失于温煦引发。二者治法迥异，前者治宜清利，后者治宜温补。

除膀胱以外，冲脉、任脉、女子胞等在人体生长发育，生殖机能以及病因病机，辨证治疗等方面亦常与肾有一定关联。

总之，肾是人体重要脏腑之一，在人体生命活动，生长发育以及生殖繁衍中均起着重要作用。一旦肾脏受损就往往会引起多种病证和多种证候的出现。作为一名中医工作者，对此必须熟知，否则就很难正确地分析疾病，认识疾病，治疗疾病。古人说：“不明脏腑经络，开口动手便错”。虽为经验之谈，但确实不失中医之真谛。

一、肾 阳 虚

肾阳虚是临床常见证候之一，即使在日常生活中也不乏所见。如天气稍寒就有厚衣重裘超出常人而触其手足仍觉不温者；有年尚未老却性欲已衰，甚至出现阳痿早泄者；也有夜尿频频，超逾白日，以致彻夜不得安眠者……凡此种种，一旦就医，无不首先考虑肾阳虚衰之证。当然这些人也常常会提出诸如什么是肾阳虚证，它是怎样造成的，可引起哪些病证以及如何治疗等一系列问题。而这些问题无论在防病，还是在治病上又都是极为重要，必需搞清的。

肾阳虚证是指肾中元阳不足，命门火衰，脏腑功能低下所引起的一种证候。这种证候引发的原因主要是：先天不足，肾阳素虚；或久病不愈，日久伤及肾阳；或恣情纵欲，斲伤太过，致使下元虚损；或年老体弱，阳气日见虚衰。由于肾阳不足，气化不利，不仅不能温养形体，维持正常的脏腑功能，甚至会出现阴寒相对过盛的情况，所以肾阳虚证的表现特点往往是既有虚，又有寒。《素问·逆调论》所谓“阳虚则外寒”的论述就多指于此。

肾阳虚证的临床表现比较复杂。其中主要症状是，腰膝酸软冷痛；性欲衰退，阳痿，早泄或时有滑精，男子不育，女子不孕；小便频数，夜尿增多，或小便失禁，或小便不利，肢体浮肿，或小便点滴难通；眩晕健忘，耳聋耳鸣；喘促日久，动则尤甚，呼多吸少，气不得续；大便秘结，或黎明即泻，泄前肠鸣等。兼有症状为，面色㿔白，形寒怯冷，四肢不温。舌脉之象多为舌淡胖嫩，舌苔白润；脉象沉细无力或沉迟等。

本证之所以出现上述脉症，总括病机概由肾阳受损，生理功能低下所致。因腰为肾之府，肾主骨，故肾阳虚衰，骨髓不充，腰膝失于温养，则会出现腰部发酸，甚至冷痛，膝肢软弱无力；肾寓元阳，内寄命火，主藏精，系二阴，为人类繁衍之本源，肾阳一旦衰惫，命门之火不足，阴精不足以生化，阳气不足以振奋，生殖机能随之低下，则会出现性欲减退，阳痿不举，男子不育，女子不孕；甚至肾阳一虚，封藏不固，阴精妄泄，还会出现早泄或滑精；肾阳虚衰，膀胱气化不利，开合失其常度，则见尿频，遗尿，尿少浮肿，或者癃闭；因头为诸阳之会，精明之府，赖人体清阳之气，精

华之血以养之，故肾虚阳衰，清阳不振，头脑失养，清窍失充，则见昏眩健忘，耳鸣不聪，肾阳已虚，肾气必衰，气失下纳，则致喘促吸少，动而加剧，气不接续；由于肾阳虚馁，命门火衰，脾失温煦以健运，肠失传导之常态，则见便秘不解，或黎明腹泄等。至于兼见症状的出现，则无不属于阳气虚衰，不能温煦形体而致了。舌淡胖嫩，苔白而润乃阳气虚衰，津液不伤，水温不化之象，脉沉细弱或沉迟为阳气虚衰，气血鼓动无力之征。

有关肾虚虚证的诊断，可根据以下三点进行判定。一为伤及肾阳的病史；二为能确定病位的症状；三为定性表现和体征。特别是第二与第三点，在实际临床判断中尤为重要。具体掌握，一般具有主要症状一项以上，同时兼有兼见症状及舌脉者即可确定肾虚虚证。

在治疗上，根据“肾无实证”的基本认识，本着“虚则补之”的基本原则，具体治法当温肾助阳。方剂可用右归丸，《金匱》肾气丸等加减。

肾虚虚证是临床中比较常见的证候，它可以出现于多种病证，如阳痿、遗精、早泄、不育、尿浊、淋证、水肿、癰闭、关格、遗尿、腰痛、耳鸣耳聋、感冒、发热、喘证、哮证、饮证、泄泻、痢疾、便秘、噎膈、头痛、眩晕、崩漏、绝经前后诸症、妊娠小便不利、不孕等。

（一）阳痿

阳痿在《灵枢》中也称为阴痿。它是指未到性欲衰退年龄，阴茎痿弱，不能勃起，或临房举而不坚，不能维持正常性生活而言。

阳痿发病原因，除极少数患者有器质性病变外，绝大多

数尚属机能障碍性病证。其中肾阳虚引起者尤为多见。所以《景岳全书·阳痿》在总结本病病因时亦说：“火衰者十居七八”。肾阳虚之所以能致成阳痿，概括机理主要在于素体虚弱，肾阳不足，或房劳过度，损伤肾气，或不知自惜，误犯手淫，大病久病伤及于肾，致使精气受损，命门火衰，阳气不能振奋发为本病。

阳痿的引发原因不同，形成的证候不一，故不能把肾阳虚证视为临床上的唯一证型，否则就会忽视和违背中医审因辨证的原则。另外，由于无论何种证候的阳痿，其主症均为阴茎不举，或举而不坚，所以了解患者的兼证与舌脉就显得特别重要，不然也会造成辨证上的困难。

肾阳虚阳痿的主要脉症是，阳痿不用，精液稀薄清冷，面色苍白，头脑昏眩，神疲乏力，腰膝酸软冷痛，四肢欠温等。舌淡胖，苔白润，脉象沉细，两尺尤弱。

总括本证病机，实不脱离肾阳虚衰，命火不足。肾主二阴，阳气一虚，难以振奋，宗筋无力，则阴茎痿弱不举；肾失温养，精气虚寒，则精液清稀而冷；阳气不足，清阳不振，难以上充头面，则面白头昏；肾阳已衰，精气不足，不能温养形体与腰府，则精神疲惫、乏力腰酸，四肢不温。舌脉之象，均为肾阳不足之征。

在本证诊断上，掌握伤肾的病史，抓住阳痿不用的主症，再加上一般阳虚的兼有症状与舌脉，判定本证并不困难。但辨证时尚需排除其它证候，如阳事不举而兼见夜寐不安，心悸气短，神疲肢倦，面色萎黄，饮食减少，舌淡苔白，脉细的心脾亏损证；或从惊恐得之，症兼胆怯多疑，易恐善惊，心悸不宁，夜寐欠安，舌淡苔薄，脉象弦细或舌脉如常的惊

恐伤肾证；以及兼见烦躁口苦，下肢酸重，小便短赤，舌苔黄腻，脉濡数的湿热下注证等。

本证治疗当以补肾壮阳，温养下元为法。主方可选赞育丹合五子衍宗丸加减。前方由熟地、白术、当归、枸杞子、炒杜仲、山萸肉、仙茅、仙灵脾、肉苁蓉、炒韭子组成；后方由复盆子、枸杞子、五味子、菟丝子、车前子组成。二方相合，其中以肉桂、仙茅、仙灵脾、炒杜仲壮阳强肾；以熟地、山萸肉、肉苁蓉、枸杞子、当归补养精血；以菟丝子，炒韭子，蛇床子，复盆子、五味子补肾固精；以白术，车前子顾后天以助生化。临床应用时一般可减当归，白术，车前子等，酌加阳起石、海狗肾、山药、党参等。此外，也可用右归丸加减，本方由熟地、山萸肉、山药、枸杞子、菟丝子、鹿角胶、杜仲、当归、肉桂、制附子组成。用之可使肾阳振奋，精气充足，阳痿得复，其病痊愈。

本证除药物治疗外，作好思想与调理工作也是非常必要的。因这类患者往往忧心忡忡，焦虑不安，或羞于启口，思想沉闷，不利于疾病的恢复。特别是那些初婚，或夫妇双方久离之后而又重聚，或存有某些不正确想法的人就更为重要。临床实践证明，有些患者一经消除顾虑，端正思想认识，思想一开朗，病情往往会得到好转。另外，有手淫毛病的患者，也应劝其改正不良习惯，戒除手淫，避免不良刺激。如果发现阳痿与全身衰弱，营养不良，用脑过度以及和胃病等因素有关，除治疗上常从先病入手，积极去除有关疾病外，还要适当加强营养，合理安排劳逸，这样把药物治疗与必要的调理结合起来，才能更快地治愈疾病。

（二）遗精

遗精是指不因性交而精液自动泄出的病证，包含梦遗、滑精两种。其中梦遗是指在梦幻中精液外泄，滑精是指不因梦交或性欲冲动而精自泄出。遗精并不完全属于病态。成年男子未婚或婚后夫妻分居，偶尔出现遗精，如一个月一二次，次日又无任何不适之感者，为生理现象，不属于病态。古代著名医家张景岳曾说：“壮年气盛，久节房欲而遗者，此满而溢者也。”（《景岳全书·遗精》）。对于这种情况无须进行药物治疗。相反，如果因为缺乏生理常识，产生恐惧焦虑，同时出现头晕，心悸，乏力等症；或遗精次数过多，每周在两次以上，甚至昼夜遗精，次数不定；或清醒之时精自外流，并伴有头昏失眠，神疲体倦，腰腿酸软，心悸气弱等，则属病态应予治疗。

《素问·六节脏象论》说：“肾者主蛰，封藏之本，精之处也。”说明肾脏本身不仅贮藏生殖之精，而且能封藏固守，不使精液妄泄于外。若先天不足。禀赋素弱，大病久病之后犯于房禁，或青年早婚，房室过度，年少无知，频犯手淫。前者常直接导致肾阳虚衰；后者多由肾精亏耗，阴气不足，日久由阴及阳而致肾阳不足。由于肾阳虚馁，肾气不化，固摄封藏之力日趋低下，精关不能固守，故可精液自遗而发为本病。但在病因病机认识上，需要注意的是：第一，不能把肾阳虚视为遗精的唯一致病因素。因为象用脑过度，劳心太过，暗耗心阴，或思欲不遂，神不内守，君相火动；或嗜酒无度，饮食不节，湿热下注等均可影响肾之封藏而发本病。第二，即便是肾虚，也要追寻究竟是阴虚还是阳虚。因为阴虚火动，扰于精室，也可造成精关不固。不注意这些，在临床上就很难达到审病求因的要求，从而影响辨证与治疗，甚

至疾病不仅不能去除，有的也会进一步加重。

肾阳虚遗精的临床表现，主要是遗精频作，无梦而遗，甚至心起欲念，或稍遇劳累，即发生，同时兼见头昏目眩，耳鸣，面白少泽，腰膝酸软，甚至冷痛，神疲倦卧，畏寒，手足清冷，舌淡，脉沉细。

上述脉症出现的机理在于，病久不愈，阴精已伤，由阴及阳，命火虚衰，精关失守，则遗精频作，欲念、劳累，扰于心肾，关门不固，则遗精遂发；肾阳虚馁，阳气不振，则神疲蜷卧，清阳不能上充，则头昏眩鸣，面白不华，肾阳不足，腰府失于温养，则腰膝酸软，甚至冷痛，阳虚不能温煦形体，则畏寒肢冷。舌淡，脉沉细均为阳虚之象。

总之，概括本证辨证要点，一是有久病的病史或阳气素虚的表现；二是无梦而滑泄，精气清冷，甚至心有所动，或劳累之后即发；三是兼有一般肾阳不足的症状；四是舌淡白，脉沉细无力。大凡具有上述遗精特点及主要脉症即可确定诊断。遗精辨证，貌似简单，实际比较复杂，临证之时，必须仔细审辨，并与相类证候作出区分，以免固证型辨识不清而发生错误治疗。如心火亢盛证，多由目有所睹，心有所思，用心过度，所欲不遂引起。其表现多为梦交遗精，同时伴有心悸不守，易惊健忘，烦躁溲黄，舌尖红，脉数等；相火妄动证，多由过欲伤阴，相火过亢引起。其表现多为有梦而遗，亦可无梦滑泄，同时伴有口干咽燥，心烦少寐，急躁易怒，腰膝酸软，小便短黄，舌红少苔，脉象细数；心脾两虚证，多由思虑不解，劳倦过度所致。其表现多为滑精频繁，面色苍白，气短乏力，自汗，纳少，形体消瘦，心悸失眠，唇舌淡白，脉象细弱等；湿熱下注证，多由嗜酒无度，恣食肥甘

所致。其表现多为遗精频繁，时或有梦，偶尔无梦，心烦口苦，渴不欲饮，小便黄赤，热涩不畅，苔黄腻，脉濡数等。以上诸证均与肾阳虚证病机不同，脉症有异，不难鉴别。

肾阳虚证遗精，在治疗上当以温肾固精为法。方剂可选金锁固精丸合右归丸加减。前方由沙苑蒺藜、龙骨、牡蛎、芡实、莲须组成；后方由熟地、山萸肉、山药、鹿角胶、枸杞子、菟丝子、当归、杜仲、附子、肉桂组成。两方相合，其中以沙苑蒺藜补肾益精止遗；以附子、肉桂、杜仲温肾助阳；以熟地、枸杞、鹿角胶、当归滋养精血；以莲肉、芡实、山萸肉、菟丝子、山药、龙骨、牡蛎、莲须补肾固精。如患者症兼大便干结，则加肉苁蓉以润肠。大便溏泄，则加补骨脂、五味子以止泻。腰痛甚者，则加续断以壮腰肾。兼见阳痿者，则加仙灵脾、仙茅、阳起石等以壮肾阳。

肾阳虚遗精的治疗，既不能使用泄火之药，也不能单用滋阴之品。因为单纯滋阴，甚至再加上降火药物，不仅有碍肾阳的恢复，进而还会抑制，损伤肾中阳气，使病情加重。本证除药物治疗外，精神调养，生活调理也非常重要，否则仍会影响治疗效果。其一，要正其心志，排除杂念。其二，要节制饮食，多食清淡，少用烟酒；肾阳虚所致者尚须避免生冷、寒凉。其三，起居要有规律，休息力求充足。同时睡前应尽量避免过度兴奋，或想入非非。睡时以侧卧为好，被子不宜过厚，衬裤不宜过紧。必要时还可以带为索，套在膝颈之上，使其踣卧。其四，适当参加体力劳动和身体锻炼，以利体质的恢复。最后，值得提及的是，节制房事，戒除手淫，尽量避免有关性的刺激。

（三）早泄

早泄是指性交时射精过早，且阴茎随即痿软，不能进行正常的性生活而言。著名古代医家沈金鳌所说的“未交即泄，或乍交即泄”，就是对本证的确切描述。

早泄和遗精不同，遗精是指不经性交而精液自泄，早泄则是性交之始或性交前精自外出。早泄与阳痿也有不同，早泄属性交之始，阴茎尚能坚挺，只是射精过早而后随即痿软；阳痿则属阴茎始终不能勃起，或举而不坚，难以进行性交。阳痿和早泄有着密切关系。早泄常常是阳痿的早期症状，阳痿则往往是早泄的进一步发展。

本证尽管可由心脾亏损、肝经湿热以及情志所伤等引起，但最常见者仍属肾阳虚衰。即房室不节，或频犯手淫，或素体肾虚，或遗精日久，累伤肾阳，封藏不固，摄纳不足而引起早泄。

肾阳虚证早泄的临床表现是临房早泄，精薄清冷，甚至阳痿。同时伴有腰膝酸软，神疲乏力，面色㿔白，畏寒肢冷，小便清长或频数。舌淡胖润，或边有齿痕，脉沉细无力。

盖房劳久病，斲伤太过，肾阳受损，封藏不固，肾失温养，精气虚衰则临房早泄，精薄清冷；阳气不振，宗筋无力，则见阳痿；腰为肾府，肾虚失养，则腰膝酸软；阳虚气馁，形神不得温养则面色㿔白，神疲乏力，畏寒肢冷；肾阳已虚，气化无力，则小便清长或频数。舌淡胖润或边有齿痕，脉沉细无力，均为肾阳虚衰之征。

本证治疗当以补肾助阳固涩为法。其中温补着重固本，固涩重在治标，二者兼顾，取效更捷。常用方剂可选济火延嗣丹加减。本方由人参、黄芪、巴戟天、五味子、肉桂、当归、白术、龙骨、山茱萸、山药、柏子仁、远志、牡蛎、金

樱子、芡实、鹿茸、黄连组成。方中以肉桂、鹿茸、山茱萸、巴戟天、当归、山药温补肾阳，补益精血；以人参、黄芪、白术、益气固摄；以龙骨、牡蛎、五味子、金樱子、芡实补肾固涩；以柏子仁、远志、黄连养心安神，清降心火。

肾阳虚早泄非一日之疾，虽阳气已虚，但阴精也多有亏损，故治疗之时最好取阴中求阳之法，既要填补肾精，又要温补肾阳，两相结合，阳得阴助，气化增强，封藏才能加固。否则过用燥热，更伤肾阴，再累肾阳，终难获得久效。阴柔之品，苦寒之药也不可单用、过用，不然抑遏或消伐肾阳，其病更难痊愈。除药物治疗外，由于此类患者常存有焦虑恐惧，思想负担沉重，所以还要注意劝慰患者，精除疑虑，增加治病信心。同时要节制房室，以免再伤肾气。这样逐渐获取功效，更好地消除病痛。

（四）不育

不育是指男子缺乏生育能力，婚后无子而言。可因先天性生殖器官发育不全；或后天病变引起，故古人有“五不男”之说。即男性天、漏、犍、怯、变五种不育之症。其中“天”指“天宦”，为男性先天性外生殖器或睾丸缺陷和第二性征发育不全。“漏”指精液不固，精自外遗。“犍”指阴茎或睾丸切除。“怯”指阴茎不举，或举而不坚。“变”指“人疴”，系两性畸型。肾阳虚所致男子不育就多属先天不足，后天病变。

肾阳虚馁之所以形成不育，概由禀赋不足，阳气素虚，或少时不知自惜，斲伤太过，以致肾阳伤损，温养不及，精气不化，阴精衰少所致。

本证临床表现常见精液稀薄清冷，精子稀少，活动减弱，

面色苍白，精神萎顿，腰酸怕冷，四肢不温，甚至滑精，早泄，阳痿不举，舌淡胖，苔白润，脉沉细无力。

上述脉症出现病机为先天不足，肾阳素弱或斲伤太过，损伤肾阳，肾失温养，阴精难以化生，则精液稀薄清冷，精子稀少，活动减弱；阳气虚衰，不能温煦形体，则见面色苍白，腰酸畏冷，四肢不温；精气即虚，精不生气，气不生神，则精神萎顿；阳气不振，宗筋无力，精关失守，封藏不严，则见阳痿不用，遗精早泄。舌淡胖，苔白润，脉沉细无力，均为肾阳亏虚，精气不足之象。

本证治疗当以温肾壮阳，填补精髓为法。前者意在恢复温煦生化之机；后者意在增补有形之物。如此功能振复，阴精充足，其病方可告愈。否则，仅助其阳，过用温燥之品，则难免再耗精血；单用滋补，过用阴柔，则恐妨碍生化之功，故两者相合，标本兼顾，方算万全之策。方剂可选赞育丹加减。本方由熟地、白术、当归、枸杞子、炒杜仲、仙茅、仙灵脾、巴戟天、肉苁蓉、山萸肉、炒韭子、蛇床子、肉桂组成。其中肉桂、仙灵脾、仙茅、巴戟天、炒杜仲温阳强肾；熟地、山萸肉、肉苁蓉、枸杞子、当归补血养精；炒韭子、蛇床子补肾固精；白术顾后天以助生化。如症兼见阳痿，滑精，则加阳起石、桑螵蛸、锁阳、苁实、金樱子等壮阳固肾。

（五）尿浊

尿浊是指小便混浊，白如泔浆，洩时无尿道疼痛为主要临床表现的病证。本证与遗精、淋证、精浊、白淫不同。遗精与排尿无关；淋证小便频急短涩，且伴有尿痛；精浊惟尿道口时见糊状浊物，而小便不混；白淫则为精浊日久，火衰寒胜，情欲触动则流精清稀。

尿浊的出现，与脾肾二脏功能失调密切相关。固脾为后天之本，生化之源，并有统摄精微之功；肾为先天之本，藏精之处，且有封藏固守之力，故脾肾失常，气化不足或受阻，封固不利，脂液精微下注，与尿相混而下，遂致本证。尿浊既可因虚而发，也可由实而得。肾阳虚衰即属因虚致病中常见病因之一。其致发原因与病机为：劳欲过度，年老肾虚，久病体弱，伤及于肾，以致下元亏虚，气化不利，封藏不固，脂液、精微下注，随尿而出，发为尿浊。

本证临床表现主要为，小便混浊，白如泔浆，面色苍白，精神萎靡，腰膝酸软，畏寒肢冷，舌淡胖大，苔白而滑，脉沉细尺弱。

上述脉症之所以出现，概由肾阳虚衰，下元不固所致。因肾阳不足，封藏失职，固摄无力，脂液下流，则小便混浊，白如泔浆；阳气衰微，形体失于温养，则面色苍白，腰膝酸软，形寒肢冷；肾虚阳衰，难以振奋，则精神萎靡；舌淡胖大，苔白而润，脉沉细尺弱，均为肾阳虚馁之象。

尿浊一病，在辨证上，证候虽各有不同，但主症差异，常不明显，故临床往往以兼症舌脉作为辨别证型的重要依据。在临证时如症兼小腹下坠，尿意不畅，面色不华，气短懒言，神疲乏力，食少便溏，劳倦或食油腻甘肥加重，舌淡脉软者，则可诊断为脾虚气陷之证；如症兼胸闷口渴，烦躁失眠，小便短黄，苔黄腻，脉濡数者，则可诊断为湿热下注之证；如症兼烦热口干，腰酸腿软，舌红少苔，脉细数者，则可诊断为肾阴亏虚之证。上述诸证均与肾阳虚证表现迥异，辨证之时，如能尽皆除外，就更有利于确定本证了。

肾阳虚证的尿浊，治疗当以温肾固涩为法。温肾以治其

本，固涩以治其标，如此以使肾阳得复，肾气得化，固摄加强，脂液、精微不得妄泄，则病可痊愈。方剂可选鹿茸补涩丸加减。该方由菟丝子、桑螵蛸、附子、鹿茸、人参、黄芪、莲肉、茯苓、肉桂、补骨脂、山药、桑皮、五味子、龙骨组成。其中以附子、肉桂、鹿茸、补骨脂、菟丝子温补肾阳；龙骨、五味子、桑螵蛸以补肾固涩；人参、黄芪、莲肉、山药、茯苓以健脾益气，增强固摄之力。若尿浊夹血，则加炮姜炭、藕节、三七等。本证治疗若误投滋阴或清化之药，一者阴柔太过，抑遏阳气；一者妄用寒凉，再折肾阳，这样阳气再伤，不唯病不得瘳，恐反加重。此外，在调护上也需注意，避免劳欲过度 and 过食辛燥。

(六) 淋证

淋证是以小便频数短涩，滴沥刺痛，欲出未尽，小腹拘急，或痛引腰腹为主要临床表现的病证。以其病因与症状特点的不同，可分为石淋、气淋、血淋、热淋、膏淋、劳淋诸种。淋证初起多由湿热蕴结下焦引发，日久尚可由实转虚，或虚中夹实。肾阳虚证不仅是淋久不愈，正气被伤所致的一种发展转归，而且是膏淋和劳淋的重要引发原因。

由于久淋不愈，伤及正气，或年老久病，身体渐虚，或房室不节，劳伤过度，以致肾虚阳伤，气化不利，封藏失守，脂液下流，尿混如脂，而为膏淋；下元不固，小便淋漓，遇劳即发，则为劳淋。

肾阳虚证的膏、劳二淋主要脉症，膏淋为病久不愈，或反复发作，淋出如脂，涩痛不著，形体消瘦；劳淋为病延日久，时轻时重，遇劳即发，尿痛赤涩不甚，淋漓不已，余沥难尽，不耐劳累。同时均可兼见面色苍白，头昏乏力，神疲

不振，腰膝酸软，手足冰冷，四肢不温，舌淡苔腻，脉沉细无力等。

纵观病机特点二者均属病久伤肾，肾阳虚衰，正虚突出，邪气衰少之征，但在病机上前者重在精关不固；后者重在小便失主。至于所兼脉症，则均属肾阳不足，形体失于温养之象。

在辨证中肾阳虚之膏淋须与湿热下注者进行鉴别。湿热之证，其病多属新发，邪实较重，尿道热涩疼痛明显，舌质红，苔黄腻，脉滑数。劳淋须与脾虚气弱者作出区分，二者虽俱以病久正虚为主，但脾虚者常见少气懒言，体倦乏力，小腹坠胀，胃纳欠佳，大便溏薄，或便意不尽，舌淡苔白，脉象细弱。

治疗之法，膏淋宜补肾固涩之法，劳淋治宜补肾通淋之法。方剂均可选《金匱》肾气丸加减。本方由附子、肉桂、熟地、山萸肉、山药、丹皮、泽泻、茯苓组成。其中以附子、肉桂，温肾阳，助气化，复摄纳之职，增主水之权；六味地黄丸滋阴补肾，以达阴中求阳，使阳得阴助，生化不息。运用时，治膏淋宜加固涩之品，如芡实、金樱子、菟丝子、莲须等。治劳淋宜加通淋之药，如牛膝、车前子等。如腰部酸痛，则加续断、狗脊、寄生等以壮腰肾，强筋骨。如兼脾阳不足，则加干姜、白术以健运中阳。

（七）癃闭

癃闭是以排尿困难，甚至小便闭塞不通为主要临床表现的病证。其中小便排出不利，点滴短少，病势较缓者为“癃”，小便闭塞，点滴不通，病势较急者为“闭”。因二者皆属排尿困难，故常合而称之。

癃闭病位虽在膀胱，但与肺、脾、肾、三焦功能正常与否密切相关。在生理情况下，人体水液的排泄，须经肾之受纳，脾之转输，肺之肃降，然后下达于肾，化而为尿，贮之膀胱，在肾的气化作用下，排出体外。如果肺脾肾功能失常，三焦不利，甚至有形之邪，阻塞尿路，则均可造成排尿不利，发为癃闭。尽管癃闭的发生涉及脏腑较多，但其中只有肾与膀胱相表里，并主持水液，执司气化，控制开合，开窍于二阴，故在其癃闭发病中独居重要地位。肾阳虚衰之所以可致癃闭，其机理主要为：年老体弱，真阳不足，或病久不愈，伤及肾阳，或失治误治，肾气再伤，以上皆致肾阳衰微，命门火不足，膀胱气化无权，合而不开，溺不能出，发为本病。

肾阳虚证癃闭的脉症表现是，小便不通，或点滴不爽，排出无力，面色苍白，神气怯弱，畏寒肢冷，腰膝冷酸无力，舌淡胖，苔白滑，脉沉细而尺弱。

脉症出现病机为，肾阳虚馁，命火衰微，气化不及洲都，膀胱合而不开，则排尿无力，点滴不爽，或小便闭塞，点滴皆无，元气衰惫，阳气不振，则神气怯弱，形体失于温养则面色苍白，畏寒肢冷，腰膝冷酸。舌淡苔白，脉沉细尺弱，均为肾阳不足之象。

本证的确定，首先要根据癃闭含义确定病证，然后分析病机，确定证候，并除外相类证型。如证见小便欲出不得，或量少不畅，同时兼有气短声低，乏力懒言，神疲纳呆，小腹坠胀，且无肾阳虚衰之象者，属中气下陷之证；如证见时欲小便不得尿，咽干心烦，手足心烦，腰酸腿软，舌红少苔，脉细数者，则属肾阴亏耗之证。此三者皆属癃闭之虚

证，故辨证时应予区分。

癃闭治疗，应根据“腑以通为用”的原则，着眼于“通”。但通之之法，须因证候虚实与病机不同而异，不可概以利水为治。本证病机关键在于阳虚气弱。合而不开，故其治法当为温阳补肾，化气利水。方剂可选《济生》肾气丸加减。其中以附子、肉桂温补肾阳，鼓舞肾气；以熟地、山药、山茱萸滋阴补肾；以茯苓、泽泻、牛膝、车前子利水。若年老体弱，元气不足，肾阳不振，则加人参、仙茅、仙灵脾、鹿角片以补元气，助元阳。若兼感外寒，症见恶寒身痛等症，则用麻黄附子细辛汤加牛膝、车前子以温阳解表利水。若肾阳愈竭，三焦气化无权，尿量极少，甚至无尿，恶心呕吐，神衰嗜睡，甚至神志不清，则以实脾饮合吴茱萸汤加减，温补脾肾，和胃降逆。并可酌配大黄解毒通便。斯时病势危笃，临证之时必须详加审辨，慎重用药，必要时可行中西两法救治。

（八）关格

关格是指小便不通与呕吐不止同时并见的一种病证。其中“关”指溺闭；“格”指吐逆。关格属危重之症，多见于水肿、淋证、癃闭、肾痹等病的晚期。清代著名医家李用粹在其著作《证治汇补·癃闭附关格》中说：“既关且格，必小便不通，旦夕之间，陡增呕恶，此因浊邪壅塞三焦，正气不得升降，所以关应下而小便闭，格应上而生呕吐，阴阳闭绝，一日即死，最为危候。”

关格的发生，从其脏腑而言，主要责于脾肾，特别是肾更为突出。因脾主运化水湿，可以升清降浊；肾主气化开合，控制膀胱与二阴。二者在水湿代谢中均起着十分重要的

作用。倘若脾肾一虚，阳气衰惫，脏腑功能低下，以致水湿不化，浊邪内郁，邪毒内盛，甚至蕴积代热，进而影响于胃，上干于肺，蒙蔽于心，侵及于肝，造成膀胱不开，浊邪壅盛，胃气不和，肺气逆上，心神迷蒙，甚至阳损及阴，虚风内动，邪毒入血，血液妄行，最后陷入命火衰竭，阳气欲脱之境。由此引起面色萎黄，或苍白灰暗，面目甚至全身浮肿，小便不通，倦怠乏力，恶心厌食，呕吐时作，呃声频频，头痛眩晕，大便秘结，或为腹泄，睡眠颠倒，烦躁不安，或神疲嗜睡，甚者抽搐、昏迷、出血、贫血等诸症出现，形成关格之病。

肾阳虚证关格是该病临床常见证候之一。其发生主要在于，水肿、淋证、癃闭、肾癆等病日久不愈，累及于肾，肾气日渐匮乏，甚或复受外邪等因素诱发，病势骤然恶化，以致肾阳衰惫，阳不化气，膀胱合而不开，水湿内停，浊邪日盛，壅塞三焦，升降之机逆乱乖异，其它脏腑皆受其累，功能亦见紊乱，发为本病。

肾阳虚证关格的临床表现为，面色苍白晦滞，腰以下肿甚，或全身浮肿，腰膝酸软，神疲倦怠，畏寒怯冷，四肢不温，不思饮食，泛恶呕吐，口中尿臭，少尿或无尿，或小便清长，夜尿增多，尿中多沫，舌淡苔白，脉象沉细。

以上脉症出现之机理，总括起来主要为肾阳衰惫，水浊上逆。由于下元亏损，命门火衰，阳不化水，水液内停，泛滥肌肤，则全身浮肿；水湿下润，则腰以下肿甚；气化失司，开合不利，则少尿或无尿；肾阳虚衰，失于固摄，则小便清长，夜间多尿，甚至尿中多沫；水湿内盛，浊邪上收，则不思饮食，泛恶呕吐，口中尿臭肾虚阳微，形神失于温

养，则面色苍白晦滞，神疲倦怠，腰膝酸软，畏寒肢冷，四肢不温，舌淡苔白，脉沉细均为肾阳虚衰之象。

关格是一种比较复杂的疾病。从其病性而言，早期虽以阳虚为主，但亦兼杂浊毒之邪，而且有着肾虚、脾虚为主以及脾肾两虚的不同，当予辨别。病属脾阳虚衰，浊邪犯胃者，常见呕吐较频，面白神疲，形寒少气，倦怠乏力，纳呆腹胀等症；胃阳虚衰，浊毒壅滞者，常见尿少，尿闭，口中尿臭，腰膝酸软，形寒肢厥等症。二者病位不同，治法有异。

肾阳虚证关格的治疗，当以温阳益肾，化浊利水为法。否则，一味温补，浊邪不去，病难缓解；或单纯祛邪降浊，阳气不复，甚至更伤，窍道不通，浊毒也难排出。另外，本证虽属阳气衰惫，治宜温阳为主，但在浊邪不盛，正虚突出，病势较缓的情况下，也应注意刚柔相济，求取补阴配阳，使阳从阴复，功能日渐增强。因肾阳虚衰，作为关格之病本，常贯穿于各个不同阶段，故用药之时宜谨遵病机，分清主次缓急。一般正虚为主，病势较缓者，可用《金匱》肾气丸加减。本方由附子、肉桂、熟地、山药、山茱萸、丹皮、茯苓、泽泻组成。其中附子、肉桂温肾助阳；熟地、山药、山茱萸滋阴补肾；丹皮、茯苓、泽泻利水泄浊。小便不利，水肿较轻者，则加牛膝、车前子以增强利水之功。若脾阳也虚，则加人参、白术、干姜等以温补脾阳。若属肾阳虚衰，水湿冷滞，水肿较重者，则改用真武汤加减，甚至还可舍入五苓散。^①若属浊毒壅盛，肾阳虚衰，邪实突出者，则用附子泻心汤加减。该方由附子、黄连、黄芩、大黄组成。其中附子温肾助阳，黄连、黄芩、大黄解毒降浊。总之以上诸

方应视其病机，灵活运用之。

（九）遗尿、小便不禁

遗尿俗称尿床。是指睡眠中小便自遗，醒后方知为表现的病证；小便不禁是指清醒时不能控制排尿，尿液自行排出的一种病证。前者多见于儿童；后者常见于老年、妇女和病后患者。

遗尿和小便不禁引发原因较多，既可由五脏虚损引起，又可由湿热下注造成；还可由下焦蓄血致使，但最常见的病因仍属五脏虚损中的肾阳不足。因肾为水脏，司气化，执开合，其气下通于阴，与膀胱共主水液的排泄，故患者禀赋不足，肾阳素亏；或年老体弱，肾阳已衰；或产后久病，伤及肾阳，致使命门火衰，气化不及，膀胱约束无力，尿液自遗，发为本病。

肾阳虚证遗尿、小便不禁的临床表现为，小便自遗，头脑昏晕，腰膝酸痛，畏寒肢冷，或阳痿遗精等，舌淡苔白，脉沉细无力。

以上脉症出现的病机，总括起来，皆在肾阳虚馁，肾气不固。因肾阳衰微，不能温化水液，约束膀胱，则小便自遗；清阳不振，脑失充养，则头脑昏晕；阳气虚衰，不能温养形体、腰府，则畏寒肢冷，腰膝酸痛；阳虚气弱，宗筋无力，封藏不固，则阳痿遗精，舌淡苔白，脉沉细无力为肾虚阳衰之征。

本证在辨证时须与肺脾气虚，心肾阴虚，湿热下注，下焦蓄血等证作出区分。肺脾气虚者，多见尿意频急，时有小便自遗，甚至咳嗽、谈笑也易出现，同时伴有面色苍白，气短懒言，体倦乏力，小腹坠胀等，舌淡苔白，脉象虚软无

力；心肾阴虚者，多见小便频数淋漓，时有梦中遗尿或小便不禁，并伴有面色潮红，心烦失眠，口干咽燥，腰酸腿软，形体消瘦等，舌尖红，苔薄或少，脉弦细而数；湿热下注者，多见溲频尿热，或淋漓短涩，溺黄而臭，时有小便自遗，口干少饮，口苦纳差等，苔黄腻，脉滑数；下焦蓄血者，多见小便滴淋，溺时自遗，小腹胀满疼痛，甚至可以触及症块等，舌暗或有紫斑，苔薄，脉涩。

肾虚虚证遗尿及小便不禁的治疗，应以温肾固涩为法。温肾重在治本，恢复肾阳，增强固摄之力；固涩意在治标，减轻小便自遗之症。方剂可选菟丝子丸或缩泉丸加减。前方由菟丝子、肉苁蓉、附子、牡蛎、五味子、桑螵蛸、鹿茸、益智仁、乌药、山药、鸡内金组成。其中以菟丝子、肉苁蓉、附子、鹿茸温补肾阳；以牡蛎、五味子、桑螵蛸、益智仁、山药、乌药、鸡内金固脬缩溺。后方由乌药、山药、益智仁组成。其中以益智仁温补脾肾，固精气，涩小便；以乌药温膀胱之气化，固小便之自遗；以山药健脾补肾。二方相较，后者不如前方温补之力强大，故一般每多用于小便不禁，或遗尿之轻者。如属阴阳两虚，则宜采用并补之法，配入六味地黄丸治疗。

（十）腰痛

腰痛是指腰部一侧或两侧疼痛为主要临床表现的病证。以其病因不同，分为外感腰痛与内伤腰痛两类。肾阳虚弱者即属内伤腰痛。

腰为肾之府，肾主骨。素体禀赋不足，或久病体衰，或年老精血亏虚，或房室不节，遗泄过度，日久则精气衰耗，肾阳不足，腰府失于温养，形成腰痛。故《素问·脉要精微

轮》云：“腰者，肾之府，转摇不能，肾将惫矣。”

肾阳虚腰痛的主要表现为：腰痛以酸痛为主，喜按喜揉，腿膝无力，遇劳加重，卧则减轻，常反复发作；同时兼见少腹拘急，面色㿔白，神疲怯冷，四肢不温，遗精滑泄，小便频数，或夜尿增多，舌淋胖，苔白润，脉沉细无力。

上述脉症出现病机，因肾居腰脊，经脉相连，主骨生髓，故肾之精气不充，元阳虚衰，腰府失于温养，骨髓不能充实，则腰部酸痛，腿膝无力，喜温喜按；劳则气耗，则遇劳加重，卧则减轻；因阳气者精则养神，柔则养筋，故精气并损，肾阳衰微，神气失充，筋脉失营，形体失于温煦，则少腹拘急，面色㿔白，神疲怯冷，四肢不温；肾主藏精，为封藏之本，肾阳不足，命门火衰，封藏不固，精关失守，则遗精滑泄；肾为水藏，职司二便，气化不及州都，膀胱开合失常，则小便频数，或夜尿增多，舌淡而胖，苔白而润，脉象沉细无力，均为肾阳虚衰之征。

本证确诊时须与肾阴虚证作出区分。二者在主症表现上虽常相类似，但阴虚者常兼面色潮红，口干咽燥，心烦失眠，手足心热，舌红苔少，脉象弦细而数等。阴虚内热之象比较明显，故区分起来并不困难。

肾阴虚腰痛的治疗，当以补肾助阳为法。方剂可选用右归丸加减。该方由熟地、山药、山茱萸、枸杞子、当归、杜仲、附子、肉桂、菟丝子、鹿角胶组成。其中以附子、肉桂、鹿角胶、菟丝子以温阳补肾；熟地、山药、山茱萸、枸杞子培补肾阴；当归养血和血；杜仲补肾壮腰。若腰痛较重，尚可加狗脊、补骨脂、续断以增强补肾、壮筋骨之作用。若滑精时作，则加金樱子、芡实、桑螵蛸、益智仁、乌

药等以缩泉。若兼气短乏力，大便溏薄，则加党参、白术健脾益气。

（十一）耳鸣、耳聋

耳鸣、耳聋是临床比较常见的病证。前者是以耳内自觉鸣响，宛如蝉鸣或声如潮涌为特征；后者是以听力减退，甚至不闻其声为主症。二者病机常相类似，同时关系也颇为密切，如耳鸣可伴不同程度之耳聋；耳聋也可由耳鸣发展而成，故中医医籍常将二证联合并称。

耳位居头侧，与脑通连，为肾之外窍，宗筋所聚，赖人体气血、精气以养之。特别是肾之精气外通于耳，内荣于脑尤为重要。故《灵枢·五阅五使》篇说：“耳者肾之官也。”

《脉度》篇也说：“肾气通于耳，肾和则耳能闻五音矣。”

耳鸣、耳聋引发原因较多，虚、火、风、痰、瘀皆可致成。但诸因之中，为其病本者仍属于虚。“虚”有气、血、阴、阳之别。肾阳不足即属“虚”中之一。肾阳虚衰，所以引起本病，究其病机概由年老体弱，命火渐衰；或房室久病，阴损及阳，以使肾中精气并耗，肾阳虚馁，阴精不能上充，清阳难以上达，耳失濡养，发为本病。

肾阳虚证耳鸣、耳聋的主要脉症是，耳鸣耳聋，鸣声较弱，长久不愈，头晕目眩，腰膝酸冷，四肢不温，怯冷畏寒，精神萎靡，阳痿早泄，舌淡而胖，苔白而润，脉沉细无力。

概括本证病机，良由肾虚阳衰，清阳不充使然。因精气已虚，肾阳衰惫，难以上充于耳，耳失濡养，则耳鸣耳聋，鸣声较弱；肾虚之发，非朝夕而成，故病程较长，日久不愈；肾阳虚衰，清阳不振，脑失充养，则头晕目眩；阳气虚

弱，形体失于温养，则腰膝酸冷，四肢不温，怯冷畏寒，阳虚不能养神，则精神萎顿，肾阳虚馁，宗筋无力，封藏不固，则阳痿早泄。舌淡而胖，苔白而润。脉沉细无力为肾阳不足之象。

耳鸣、耳聋的临床辨证，一般要在首辨虚实的基础上，进而辨明所病脏腑，深入探寻病机，明确病性，最后确定证型。实证耳鸣耳聋，多由风、火、痰、瘀致成，起病急，病程短，其症多见耳内鸣响，状如潮声，或如雷鸣，甚则闭塞如聋，同时可伴面色潮红，头晕目眩，甚至头痛，或耳内作痒，作痛等，脉多有力；虚证耳鸣耳聋，多由气、血、肝、肾之虚引起，起病缓，病程长，其症多见鸣响较弱，其声嘈嘈，甚至渐成耳聋，同时可兼面色萎黄或㿗白，倦怠神疲，头脑昏眩等，脉多无力。虚证之中除耳鸣耳聋外，中气不足者，多兼面色萎黄，气短乏力，倦怠神疲，饮食减少，大便易溏，舌淡苔薄，脉象细弱或大而无力等；阴血亏虚者，多兼面色无华，唇甲淡白，时有心悸，舌淡苔薄，脉细无力等；肝阴不足者，多兼头部胀痛，眩晕雀盲，肢体麻木，舌红少苔，脉细而弦等。以上诸证，皆与肾虚者表现不同，临床之中应予详辨。在确定其病在肾之后，尚须辨别阴虚与阳虚。肾阴亏虚者与肾阳不足证虽然均见耳鸣耳聋，日久不愈，头晕目眩，腰膝酸软等症，但前者，常兼口干咽燥，五心烦热，舌红少苔，脉象细数等，而且决无腰部觉冷，手足不温，怯冷畏寒，精神不振，舌淡而润，脉沉无力等。总之掌握好辨证步骤，抓住本型特点，除外相类证候，判定本证是不困难的。

肾阳不足耳鸣耳聋的治疗，当以补肾温阳为主。方用补

肾丸加减。本方由山茱萸、干姜、远志、巴戟天、乌药、泽泻、菟丝子、桂心、黄芪、人参、石斛、干地黄、细辛、附子、当归、丹皮、蛇床子、甘草、肉苁蓉、菖蒲、防风、茯苓、羊肾组成。方中以肉苁蓉、菟丝子、巴戟天、蛇床子、乌药、羊肾、附子、桂心补肾助阳；干地黄、山茱萸、石斛、当归、白芍滋阴养血；人参、黄芪、干姜益气暖中；细辛、防风祛风散寒，升发清阳；菖蒲、远志、开窍宁神；泽泻、丹皮、茯苓使滋补而不碍邪，降泄而不伤正。在运用中，如阳虚不化，痰浊内生，则去附子，加半夏、陈皮以化痰。如阳虚不运，瘀血内阻，则加桃仁、红花以化瘀。本型除药物治疗，在调理上还应避免过劳，节制房事，以促进肾中阳气的恢复，疾病的早日康复。

（十二）感冒

感冒是由风邪侵袭肺卫所引起的，以头痛、鼻塞、流涕、喷嚏、甚至恶寒，发热等为主要临床表现的，常见外感疾病。感冒一般分为虚实两类。阳虚感冒就属虚证感冒的一种。其发生多由肾阳素虚，阳不卫外，腠理疏懈，风寒外袭，侵及肺卫而引起。

阳虚感冒的临床表现，一般既具有风寒感冒的基本表现，同时又有肾阳虚衰的形症可察。其脉症常见为恶寒较重，身热反轻，头身疼痛，无汗或自汗，面色晄白，语声低微，四肢不温，舌淡胖苔白，脉沉细无力。

脉症出现病机为，素体阳虚，失于温煦，再加风寒外束，卫气不固，正不胜邪，则恶寒较重，发热反轻；阳气已虚，无力驱邪于表，表气为寒邪所郁闭，或阳气不足，卫气不能固守于外，营阴外泄，则见无汗或汗出；风寒外袭，寒

气凝滞，营卫不和，则见头痛身痛；素体阳虚，不能温养形体则面色㿔白，语声低微，四肢不温，舌淡苔白，脉不浮，反见沉而无力，是阳虚不能驱邪外出，鼓脉于表的征象。

阳虚感冒的辨证，除根据脉证直接作出判断外，排除其它相类证候亦属必要。风寒感冒与阳虚感冒均有感受外邪的病史，及恶寒发热，头痛身痛等表证存在，但风寒证平素没有阳虚的征象，感冒后一般也不会急骤出现阳虚表现；另外，恶寒不如阳虚感冒明显、突出；一般脉见浮紧而不会出现沉脉，依据上述三点作出鉴别并不困难。气虚感冒也属于体虚感冒的一种，在临床表现上也有寒热，有汗等外症及虚证的症状，但该证毕竟仅属气虚，尚未到达阳虚的程度。故在兼证上，一般只见气短懒言，倦怠乏力等，但平素无形寒怯冷，手足不温等阳虚表现；而且，本证恶寒较阳虚感冒为轻；脉象多为浮而无力。至于血虚感冒与阴虚感冒，在鉴别上就比较容易了。因为这两种感冒虽然均属于虚人外感，但阴血不足的兼证常常是非常明显，寒热的特点与舌脉的表现也截然不同，区分起来多无困难。

阳虚感冒的治疗是需要慎重的。它既不可以单纯辛散，也不可以单纯补益。因为过于辛散，容易伤及阳气，使卫外之力更为不足，甚至汗液大量外泄，阳气随汗而脱，造成亡阳，陷入危重之境；反之，一味补虚，不顾散邪，使得外邪留滞于内，不能发散疏解于外，则会造成闭门留寇，变生它证，促使病情复杂化，陡增救治的困难。治疗阴虚感冒，应该标本兼顾，法宜助阳解表。方剂可用麻黄附子细辛汤，或参附再造丸加减。前方以麻黄、附子、细辛组成，其中以麻黄、细辛散寒解表，以附子振奋阳气；后方以羌活、防风、

细辛、桂枝、人参、黄芪、附子组成，其中附子、桂枝、人参、黄芪助阳益气；以羌活、防风、细辛温散风寒。两方相较，后者比前者药味更多，药力更强，所主证候也更重。

（十三）内伤发热

发热依其引发原因不同，分为外感发热与内伤发热两类。外感发热是指六淫之邪，侵袭肌表，营卫不和，正邪相争所引起的，以体温升高，超逾正常为主要临床表现的疾病；而内伤发热则是指脏腑气血虚损或失调所引起的，或体温升高，或自觉发热为特点的疾病。二者相较，除病因不同外，前者发病较快，病程较短，并有外感表证存在；后者发病缓慢，病程较长，无表证存在，发热虽以低热较多，但也可见高热或自觉发热、五心烦热。肾阳虚发热属内伤发热的一种。临床常称为阳虚发热。

阳虚发热的引发原因，主要为平素阳气不足；或寒证日久不愈，消伐阳气；或误用过用寒凉药物等，致使阳气虚衰，阴寒内盛，虚阳受到阴寒的排斥，浮越于肌表，引起发热。《景岳全书·火证》对阳虚发热的病机就曾提出“元阳败竭，火不归源”之说。

阳虚发热是比较少见的一种证候，其表现为发热而欲增衣被，面色㿔白或浮红，形寒畏冷，手足不温，或下肢发冷，腰膝酸痛，神疲嗜卧，头目昏眩，阳痿早泄等。舌淡胖嫩边有齿痕，苔白而润，脉沉细弱或浮大无力。

阳气已虚，虚阳外浮，集于肌表，故见体温升高，而毫无热感，甚至反要增厚衣被；阳气已衰或虚阳上浮，形神失其温养，故同时出现面色㿔白或浮红，形寒畏冷，手足不

温，或下肢发冷，腰膝酸痛，神疲嗜卧，头目昏眩，阳痿早泄等症。舌淡胖嫩，或边有齿痕，苔白而润，脉沉细弱，或浮大无力均属阳气虚衰之象。

阳虚发热在辨证时虽然根据典型表现可以确定，但也要注意除外相类证候，其中气虚发热就是其中的^①种。气虚发热与阳虚发热的区别主要为：第一，气虚发热多由饮食劳倦，损伤中气而得；第二，发热虽然可高可低，甚至不觉有热，且在劳累后容易发作或加重，但气虚者尚少达到反欲盖衣被的程度；第三，在兼证与舌脉上，仅表现有气虚现象，如气短懒言，头晕乏力，自汗，易于感冒，食少便溏，舌淡苔薄白，脉细弱等，而未到阳气虚衰的程度。

对阳虚发热的治疗，必须遵从中医谨守病机、治病从本的原则，切勿一见发热即投解表发汗之剂，或寒凉清热之药。否则妄用汗法，耗气伤阳，或误用清泄，损伤阳气，不惟病情毫无转机，甚至还会加速虚阳之脱绝，以致病陷危殆。具体治疗当以温补肾阳，引火归元为法，使其肾中阳气振复，浮起之阳收潜，发热自然而愈。方剂可选《金匱》肾气丸或右归丸加减。前方由附子、肉桂、熟地、山茱萸、山药、茯苓、丹皮、泽泻组成；后方由附子、肉桂、熟地、山药、山茱萸、当归、鹿角胶，枸杞子，菟丝子，杜仲组成。在药物作用上，《金匱》肾气丸是以熟地赋补肾水，泽泻宣泄肾浊；山茱萸温涩益肝；丹皮清泄肝火；山药收摄补脾；茯苓淡渗脾湿；附子、肉桂补水中之火，摄纳浮阳；右归丸以熟地、山茱萸、枸杞培补肾阴；杜仲、菟丝子强壮益精；当归、鹿角胶养血填精；附子、肉桂温肾助阳，导龙归海。此即《证治汇补·发热》所云：“……肾虚水冷，火不归经，

游行于外而发热者，……宜用八味丸导龙入海，所谓踞其窟宅而招之，即益火之源，以消阴翳也？”若阳衰气弱，症见气乏力，或汗，或昏则加人参、白术大补元气。若火不生土，症见大便溏薄，则加干姜、白术温中健脾。若黎明即泄，欲便急迫，则加补骨脂、五味子、肉豆蔻固肾止泻。若精关失控，症见遗精腰酸，则加芡实、金樱子、狗脊、续断强肾固精。若宗筋弛纵，症见阳痿不用，则加巴戟天、肉苁蓉、海狗肾补肾壮阳。若火不制水，症见腰重足肿，小便不利，则加车前子、牛膝利水退肿。若气失摄纳，症见气喘短促，动则尤甚，则加胡桃肉、五味子纳气平喘。

（十四）喘证

喘证俗称气喘，又称喘息。是以呼吸短促，甚至张口抬肩，鼻翼煽张为特征的病证。喘有虚实之分。实喘多由外邪、痰浊、气郁等引起，起病急骤，呼吸气粗声高，深长有余，以呼出为快，脉多浮滑、数、弦；虚喘多由脏腑功能低下造成，病势缓慢，气怯声低，呼吸短促，似难接续，以深吸为快，动即加剧，脉多虚弱或浮大无力。肾阳虚喘即属虚喘中之一种。

肾居下焦，为气之根本，职司纳气以归元。若房室不节，久喘不愈，或它病迁延，日久及肾，精气内夺，肾阳渐虚，根本不固，气纳无权，气逆上奔，难以归元而为喘证。

本证临床表现多为喘促日久，呼多吸少，自觉气不深纳，难以接续，动则喘息加重，同时兼见面色晄白甚至带青，精神萎靡，畏寒肢冷，或有汗出，腰酸腿软，溲清或频，夜尿增多，舌淡体胖，苔白而润，脉沉细无力。

综观脉证，阳气虚衰，气失摄纳实为肾阳虚喘之基本病机。因本证多由劳欲、它病，或肺病久延，穷后及肾而得，故病程多长；而阳虚气弱，气失下纳，则呼多吸少，气难续接；动则气耗，故喘息加重；肾阳衰惫，形体失于温养，则面白带青，精神萎怯，畏寒肢冷，腰酸腿软，阳气不固，腠理疏泄，则可出汗；气化不利，开合失常，则溲清或频，夜尿陡增。舌淡体胖，苔白而润，脉沉细无力均属肾阳虚衰之象。

总之，临床诊断本证，需要注意以下几点：其一，病程较长；其二，呼多吸少，气不接续，动则尤甚；其三，因病属纯虚，外无邪闭，内无痰雍，故多无咳嗽痰鸣；其四，伴有阳虚失荣，气化不利之脉证；最后尚须除外肺虚、脾虚、阴虚作喘诸证。其中肺脾气虚之喘也见气短喘促，语气低弱，动则尤甚，²但肺气虚者常兼见咳声无力，自汗畏风，脾气虚者常兼见痰多食少，食后腹胀，大便清薄，形体瘦弱等症。且二者既无肾病定位症状可见，又无阳虚定性症状可察，故从此鉴别当无困难。至于肺、肾阴虚所致者，则多见喘促气短，动则喘甚，面赤口干，潮热盗汗，手足心热，心烦，尿黄，舌红，脉细数等。因病性迥异，见症不同，就更易鉴别了。详见有关章节。

根据“实喘治肺，虚喘治肾”的原则，肾阳虚喘的治疗，当以温阳补肾，纳气定喘为法。方剂可选《金匱》肾气丸加减。方中以附子、肉桂温肾阳，以扶纳气之功，³熟地、山茱萸、山药、茯苓、丹皮、泽泻滋肾阴，以助气化之用。二者相合，肾气得化，下纳增强，喘促自平。如症兼咳嗽，痰多胸闷，舌苔白膩，脉带滑象者，则属肾不纳气，痰浊上

壅之上实下虚，虚实夹杂之候，斯时治疗不仅要温肾纳气，更要祛痰止咳，降气平喘。方用苏子降气汤更宜。若兼见喘咳不得平卧，痰液清稀，心悸不宁，面浮足肿，小便短少，苔白滑，脉沉细者，则属阳虚水泛，上凌心肺之证。治宜温肾行水之法，既复肾阳，又蠲水饮。方用真武汤合五苓散加减；如心阳受累，血行不畅，症兼唇、舌、指甲青紫，则加党参、丹参、赤芍等。若喘促持续不解，以致心阳欲脱，证见喘促较剧，抬肩凹腹，躁扰，肢冷，汗出如珠，脉象浮大无根，则急须回阳固脱，镇摄肾气。宜用参附龙牡汤加桂心、蛤蚧、紫石英、麦冬、五味子等，并吞服黑锡丹治疗。

（十五）哮证

哮证是以呼吸急促，喉间哮鸣为特征的发作性痰鸣气喘疾患。本病虽一年四季均可发病，但最多者仍属秋冬季节。

哮证发作多由内伏之痰，为新邪所触，痰气相搏，阻塞气道，肺气出入不利，上逆而冲击停积之痰致发。故其病性有初发属实，发则邪实的特点。肾阳虚候在哮证中出现，往往是属疾病发展过程中，随病机演变而出现的累发之证，且常见于缓解之期，以其邪少虚多而本虚上升为主要矛盾之时。其出现主要病机为，喘哮日久，反复发作，肺气日耗，累伤于肾，肾虚阳衰，气失摄纳，甚至水泛为痰，上干于肺，以致平日喘哮难以尽失，且一旦发作更易持续不解。

肾阳虚型哮证主要见于缓解期。其表现为平素短气，动则气促，面色㿔白，腰膝酸软，怯寒神疲，小便频数，舌淡胖，苔薄白，脉沉细无力。上述脉症之所以并见，其机理概

由肾虚阳衰，气化不利，肾失纳气，阳失温煦而成。

本证治疗，依据“急则治标，缓则治本”及既发以攻邪为先，未发以扶正为主的原则，拟用温肾纳气之法。方剂可选用《金匮》肾气丸加减。若兼咳嗽气喘，则加川贝、前胡、苏子等。若既见阳虚，又兼痰盛，证见喘咳气短，痰盛胸闷，咽喉不利，面白汗出，四肢不温，神疲乏力，舌淡胖，苔白腻，脉沉弱等。则宜改用苏子降气汤以兼顾标本。若喘咳较甚，则加沉香、陈皮以温肾降气祛痰；若肾阳虚甚，则加熟地、附子以温补肾气。

总之，在哮证治疗中温补肾阳之法，《金匮》肾气之方，只适宜缓解之期，肾阳虚衰，且无痰浊者。若病属发作之期，则是方、是法必须慎重使用，否则误用温补，闭聚邪气，痰热胶固，阻塞气道，肺气出入愈发不利，必然徒增喘急，以使病陷危境。另外，桂附之药，性本温燥，且阳虚之体，亦非朝夕可复，意欲长期服用而缓图功效者，则可改服丸剂，或以仙灵脾、仙茅、补骨脂等代之，并于发作前一月连续服用，以冀调整肾之功能，减轻发作期病情。

（十六）饮证

饮证是指水液输运失常，停积人体某部，诸如胃肠、胸胁、胸肺、四肢，甚至波及五脏而引起相应症状出现的一类病证。其形成，外因多为寒湿浸渍，水饮所伤；内因则属阳气不足，输运无力；且二者相合，肺脾肾功能失常，三焦水道不利，水饮之邪停聚某部而发。肾阳虚衰即属饮证发生重要因素之一。

因肾为水脏，主身之津液，执气化，司开合，对水液的输化、排泄起着重要作用，故久病体虚，劳伤太过，年高体

弱，肾阳虚馁，不能蒸化水液，气化开合失常，饮不外泄反聚于内，停于某部；另外饮为阴邪，其病本属阳虚阴盛之疾，故尔，饮证经治以后，邪去大半，正虚饮微，阳气虚衰，愈发昭著，则均可出现饮证肾阳虚候。

肾阳虚饮证的临床表现是，小腹拘急不仁，小便不利，脐下悸动，时吐涎沫，心悸气短，畏寒肢冷，腰膝酸软，舌淡胖大，边有齿痕，苔白腻，脉细弱。

分析病机，上述脉症，实由肾失温化，饮积于下所致。盖饮为阴邪，必赖阳气以转输蒸发。若饮发日久，脾虚及肾；或房室不节，日久肾伤；或年老体弱。下元衰惫，肾中阳气由是不足。阳虚于下，下焦失于温养，则小腹拘急不仁；气化不利，开合失司，则小便不利；阳气不化，饮邪内蓄，水性下润，冲击而动，则脐下动悸；饮逆于上，则时吐涎沫；水乘火位，神不自安，则心悸；阳不化气，气纳不足，则气短；肾阳虚馁，形体失于温煦，腰府失于荣养，则畏寒肢冷，腰膝酸软；舌淡胖大边有齿痕，苔白腻，脉细弱为阳虚饮聚之象。

本证表现非同一般，似腹痛而仅见拘急不仁；似喘息而未至呼吸急促；似淋而无尿频尿急，滴沥刺痛；似癃又无点滴短少，溺难排出，故临证确诊，必须综合分析，深究病机，抓住实质，作出判断。否则，仅依主症而定名，势必导入歧路，甚至自觉无从着手，难定其名。饮有实证、虚证之分，留于胃肠，停于胸胁，犯于胸肺，溢于四肢之别，临床辨治也需注意，不然证性不明，治法仍难确定。据此可见，本型辨证，需要抓住三个环节，即：①定饮，饮属有形，其性下润，易于流动，故脐下动悸，小便不利，时吐涎沫，是属

饮蓄于下之征；②定位，肾居下焦，位于腰府，主气化，司开合，故小腹拘急，脐下动悸，腰膝酸软，小便不利，反映病位低下，其藏在肾；③定性，阳主温煦，功于气化，故小腹拘急不仁，畏寒肢冷，气短少用，小便不利均为阳虚气馁之象。总之，明确此三点并予综合分析，确定本型当无困难。

痰饮肾阳虚证是虚证中的一种，此外尚有脾胃阳虚者，应予鉴别，以免鱼龙不清，导致错误诊断与治疗。因脾胃居于中焦，其失调，饮发于中，留于脘腹，则脉症常见，胸胁支满，胃中有振水之声，阳气被遏，失于温养则背部寒凉，脘腹喜温；阴凝饮聚，饮邪上逆，则不欲饮水，或热饮不多，或饮入易吐，时有恶心，呕吐清水痰涎；清阳受阻，饮凌于心，则头目昏眩，心悸气短；苔白滑，脉细软而滑，亦为阳虚饮阻之象。可见病因病机不同，饮停部位不一，症状表现迥异，区分自无难处。

本证总属阳虚阴盛，本虚标实，以虚为主，夹杂邪实之证，治疗当遵“温药和之”之大旨，标本兼顾之原则，拟用温肾化饮之法。前者意在振奋肾阳，恢复气化；后者意在畅通水道，祛除邪实。方剂选用，饮邪偏重者，可用真武汤合五苓散加减。前方由附子、茯苓、白术、生姜、芍药组成；后方由茯苓、猪苓、白术、泽泻、桂枝组成。二方相合，其中附子、桂枝温肾化气；茯苓、猪苓、泽泻、白术利水除饮；白芍敛阴护阴；生姜温散水气。若脾阳也虚，则易生姜为干姜以温运脾阳。若饮邪不重，阳虚为主，或上方治后，饮邪渐消，则宜改用《金匱》肾气丸加减，且宜常服久服，以缓图攻效。

（十七）泄泻

泄泻俗称腹泄。是指大便次数增多，粪便稀薄，甚至呈水样或完谷不化而言。其中“泄”为大便稀薄，时作时止，“泻”为大便直下，如水倾注。

鉴于胃主受纳，为水谷之海；脾主运化，司布散精微；小肠主受盛，能泌别清浊；大肠主传导，能推送粪便，故病变脏腑主要在于脾、胃、大、小肠，且以脾失健运为其关键。引发之因涉及感受外邪，饮食所伤，情志失调及脏腑虚弱。其中脾虚、湿盛就是本病发生的基本因素。但脾虚既可由饮食、外邪直接损伤而致；也可由它脏不足影响而来。肾阳虚衰作为泄泻引发原因之一，就属于它脏虚弱影响脾胃者。盖肾为胃关，开窍二阴。在正常生理情况下，肾中阳热可温煦于脾胃，以助脾胃之腐熟消谷、运化吸收，并维护二便正常排出。若久病之后，或年老体弱，肾阳日虚，命火不足，不能温煦脾土，脾失健运，水湿蕴聚，下走肠间；甚至肾阳虚衰，胃关不固，关门失利，发为腹泄。因其病发于肾，故亦称为“肾泄”。

肾虚作泻的主要脉症为，黎明之前，肠中鸣响，泻前迫切，随即而泻，泻后遂安，腹部畏寒，腰膝酸软，形寒肢冷等，舌淡体胖，苔白而润，脉沉细，两尺尤弱。

盖肾阳虚衰，火不生土，加之黎明之际，阳气未振，阴寒较盛，脾失温运，胃关不固，故肠鸣即泻，泻后而安；阳气虚衰，不能温养形体，故腹部畏寒，腰膝酸软，形寒肢冷等。舌淡体胖，苔白而润，脉沉细，两尺弱，均为肾阳虚衰，失于温运之象。

本证表现颇具特点，概括起来要点有三。其一起病较缓，

病程较长；其二每于黎明，肠中鸣响，急迫作泻，便泻清稀，不粘不臭，排出爽利，泻后即安，故肾泻也常称为“五更泄”，其三兼见肾阳虚衰之一般脉症。可以认为，临证之时明鉴于此，辨证要点即可把握。此外，晨起即欲排便，便前腹中时痛，而后或于餐后或于情志失调再欲登厕者，则需考虑肝气乘脾之证，切勿与本证相互混淆。清代医家张聿青就曾指出，肾泄每至黎明辄暴迫而注，然肝病也有至晨而泄者。盖肾泄是命火衰微，而无抑郁之气，故暴注而不痛；肝病而木旺克土，则木气抑郁，多痛而不暴注，以此为辨可了然矣。因此说常被医者所忽视，故临证之时颇须注意。至于肾阳虚衰之泻与脾虚作泻的鉴别，就比较容易了。第一，脾虚作泻，随时可发，多无此准确的时间性；第二，脾虚泄泻，多与饮食有关，稍进油腻，或难以消化之物即易发作或加重；第三，常兼有脾虚气弱，化源不足之证，如面色萎黄，神疲倦怠，气短乏力，饮食减少，食后脘闷，舌淡苔白，脉象细弱等，而无肾虚之表现。

肾阳虚之泄泻，在治疗上当以温肾暖脾，固涩止泻为法。方剂可选四神丸加减。该方由补骨脂、肉豆蔻、吴茱萸、五味子、生姜、大枣组成。其中以补骨脂温补命火，以助脾阳；肉豆蔻温肾暖脾，涩肠止泻；吴茱萸温中散寒；五味子酸敛固涩；生姜、大枣补脾散寒。诸药相合可使肾得温补，脾得健运，大肠得以固涩，遂令五更泄泻痊愈。本方临证使用，多在内无邪实的情况下用之。如症见四肢不温，则酌加附子、炮姜以增强温肾煖土之力。若症见脱肛，则加黄芪、升麻、枳壳以升阳益气；如见小腹痛甚，则去五味子加小茴香、木香以理气止痛；如脾虚症著，则加党参、白术、山药、

茯苓、扁豆等以健脾益气，若滑脱不禁，则加赤石脂、诃子、罂粟壳以收涩止泻。

（十八）痢疾

痢疾是以大便秘数增多，下利赤白脓血，里急后重，腹部疼痛为主要临床表现的病证。其发生多由外受湿热、疫毒，内伤生冷，不洁，损伤脾胃，下及于肠，邪气留滞，气血不畅，化为脓血，随粪便杂下而成。初起多为实证、热证；日久可见虚证、寒证。本病以其病因和发作情况的不同常分为湿热痢、疫毒痢、寒湿痢、虚寒痢和休息痢等。肾阳虚证就多见于久痢不愈乃至虚寒下痢者。

痢疾何以出现肾阳虚衰？盖由久痢不愈，反复发作，脾胃受损，渐及于肾，肾阳匮乏；或寒湿下痢，耗伤中阳，先天无补，肾阳日衰；或脾肾素虚，又感寒湿，痢下不止，阳气受损，甚至因痢而过用寒凉通下之剂，肾阳更加虚馁，从而形成痢疾肾阳虚证。可见肾阳虚衰不仅是虚寒下痢形成的重要因素，也是痢疾病久深入，迁延不愈，正气耗伤中的一种发展转归，而且这种转归常与年龄、体质、病因、病程、治疗等因素有关。

本证常见脉证为久痢不愈，痢下稀薄，带有白冻，便下或欠爽，甚至滑泄不禁，腹部隐痛，喜温喜按，口淡不渴，腰酸畏冷，四肢不温，精神萎靡，舌淡胖，苔白润，脉虚细。

综合病机，本证实属肾阳虚衰，寒湿留滞而成。盖痢久不愈，伤及中阳，累及于肾，肾阳亦衰，寒湿滞留肠中，则痢下稀薄，带有白冻；气机不畅，则便下欠爽；肾为胃关，命门火衰，胃关不固，则滑泄不禁；肾阳已虚，脾失火助，

阴寒内盛，则腹部隐痛，喜温喜按，口淡不渴，命火不足，阳失温养，则腰酸畏冷，四肢不温，精神萎靡。舌淡胖，苔白润，脉虚细，均为阳虚之征。

在痢疾辨证中，确定肾阳虚候颇需慎重，不然一旦错判，后果不堪设想。其辨证要点①久痢不愈，病程较长；②便下稀薄，甚至便无知觉，自动排出；③身体虚弱，呈现阳虚生内寒之象；④舌必淡，脉必虚，无实证之征象。总之证候诊断需综合分析，探明病机，进而作出正确判断。此外尚必与寒湿痢、休息痢以及虚寒痢中脾胃虚寒、脾虚下陷等证作出区分。寒湿痢系寒湿客于肠胃，气血滞涩，津液凝聚，传导失司而成。属邪实为主，且病程较短，症见痢下赤白，以白为多，甚至便下纯白粘冻，里急后重与腹部拘急明显，同时伴有寒湿困脾，脾阳不运之征，如中脘满闷，饮食无味，头重身困等，苔白腻，脉濡缓。休息痢乃痢疾初发，治不彻底，正气已虚，湿热留恋，传导失司而发，属正虚邪恋。表现特点为下痢时作时止，经年不已，常因饮食不当，感受外邪，劳倦过度而诱发，发则症见便带脓血，里急后重，腹痛少食，倦怠乏力等，但无肾虚之表现。至于虚寒痢中脾胃虚寒、脾虚气陷者，则皆属久痢不愈，正虚为主之证。虽二者也见便下稀薄，带有白冻，腹部绵绵作痛，且多无里急后重之症；但前者常兼口淡食少，气短乏力，神疲畏冷，四肢不温等；后者则兼气短乏力，腹坠脱肛等。且二者均未达滑泄不禁之程度，也无肾虚之表现，故以上诸证不难鉴别。

因泄痢之中命门火衰，常可导致火不生土，故治疗虚寒痢之肾阳虚衰者，常以温肾健脾，收涩固脱为法。方剂可选桃花汤合真人养脏汤加减。前方由干姜、赤石脂、粳米组成，

后方由当归、白芍、人参、白术、肉豆蔻、肉桂、木香、诃子、罂粟壳、甘草组成。二方相合，其中以肉桂、肉豆蔻，干姜温肾暖脾；党参、白术健脾益气；诃子、罂粟壳、赤石脂涩肠止泻；当归、白芍养血和营；木香理气行滞；粳米、甘草养胃和中。若肾阳虚衰较重，则加附子以温肾。若兼脱肛，则加黄芪、升麻以益气举陷。若痢下无度，饮食不进，阳气衰惫欲脱，病陷危笃，则用参附汤加减，以益气回阳固脱。以上诸方临证使用颇需慎重，凡痢疾初起，积滞未去，或无脾肾阳虚之症象者，切勿使用，以免闭门留寇，邪闭于内，变证蜂起。此证治疗也不可妄投苦寒清泄之药，以防再度伤阳，洞泄不止，渐进脱绝。

（十九）便秘

便秘是指排便间隔时间延长，难以排出，或虽不延长而排便困难者。

在正常情况下，饮食入胃，经脾胃之消磨、腐熟，吸收精微，所余糟粕大肠推运传送，排出体外，而为粪便。故脾胃健运，大肠传导正常，粪便排出畅通，自无便秘之谈。故《儒门事亲·斥浪分支派》云：“胃为水谷之海，日受其新以易其陈，一日一便，乃常度也。”然肠胃一旦受病，运化传导失职，粪便难以排出，便秘则自然面发。纵观便秘成因，虽有因肠胃积热，津液耗伤而发者；有因情志不舒，气机郁滞而致者；有因劳倦、产后、年老、病后，气血不足引起者，但肾阳虚衰，阴寒凝滞使然亦决不可忽视。只是不如热秘，气秘以及气虚便秘、血虚便秘更为多见罢了。

肾阳衰微所致便秘，简称阳虚便秘。以其发病责于阳虚阴盛，寒气凝滞，亦称冷秘或阴结。本证形成病因病机为，

体虚久病，年老体弱，真阳不足，或久食生冷之物，过服苦寒之药，克伐阳气，以使肾阳虚衰，命火不足，温煦无权，寒自内生，既不能助脾以运化，又不能蒸化津液，温润肠道，反致阴寒固结，阳气不运，传导无力，糟粕不行，结于大肠，难以排出，引发是病。正如《景岳全书·秘结》篇云：“凡下焦阳虚，则阳气不行，阳气不行则不能传送而阴凝于下，此阳虚而阴结也。”

常见脉症，大便干或不干，排出困难，面色㿔白，四肢不温，腹中冷痛，喜温怕冷，或腰脊酸冷，神疲乏力，小便清长，舌淡，苔白，脉象沉迟。

所见脉症病机为，肾阳虚衰，气无以化，阴寒内生，传导无力，则排便困难；阳虚阴盛，失于温煦，则面色㿔白，四肢不温，腰脊酸冷；阴寒内盛，气机阻滞，则腹中冷痛，喜温怕冷；阳气不振，则神疲乏力；内无里热，则小便清长；舌淡，苔白，脉象沉迟均为阳虚内寒之象。

本证属虚秘之一种，辨证时须与气虚、血虚、阴虚所致者作出鉴别。气虚便秘是由脾肺气虚，传导无力而成。其特点为有便意而登厕无力努责，同时兼有气短自汗，懒言声低，周身乏力等气虚症状，而无阳虚寒盛之表现，如腰脊酸冷，腹中冷痛，手足不温，脉迟等。血虚便秘乃由血虚津少，肠失濡润而发。其特点为大便干结，并伴有明显血虚之象，如面白无华，心悸健忘，头晕目眩，唇甲色淡等，绝无阳虚之见症。至于阴虚者，虽病位在肾，但属阴虚不润，虚热内生引起。与本证病性不同，表现迥然，区分当无难点（详见肾阴虚条）。

便秘病因不同，治法各异。切勿一见排便困难，概用通

下之法。不加审辨势必会犯虚虚实实之戒。阳虚便秘依其病机当予温阳通便之法。方剂可选济川煎、《金匱》肾气丸、半硫丸等。济川煎由肉苁蓉、当归、牛膝、泽泻、枳壳、升麻组成。其中以肉苁蓉、牛膝温肾润肠，强壮腰脊；当归养血润便；泽泻、枳壳、升麻升清降浊。《金匱》肾气丸由附子、肉桂、熟地、山药、山茱萸、丹皮、茯苓、泽泻组成。其中以附子、肉桂温补肾阳；六味地黄丸滋补肾阴。半硫丸由半夏，硫黄组成。方中以硫黄补火助阳，疏利大肠；半夏和胃降浊。三方相较，前者温润通便，而温肾驱寒不足；次者温阳补肾而润肠通便欠缺；后方温肾通便，但只宜用制成药内服，且硫黄须用极精之品。应用时济川煎可加肉桂以温阳散寒，兼气虚者，可加黄芪以补气。《金匱》肾气丸可加肉苁蓉、锁阳、当归等以温润通便。属脾肾俱虚者，尚可配用理中丸。

（二十）噎膈

噎膈俗称“噎食”。属中医内科四大难治证之一。是指饮食咽下受阻，或食入即吐为主要表现的病证。其中噎为吞咽时梗塞不顺，膈为饮食格拒不入，或食入即吐。因噎既可单独为病，也可为膈之前驱，故二者经常相并而称。

噎膈病发于食道，乃食管狭隘使然。其病机特点总属于本虚标实。本虚是谓津血亏损，标实系指瘀血、顽痰、逆气阻塞于食道。在病变发生发展过程中，除胃系所主外，尚与肝、脾、肾密切相关。肾阳虚衰证即为病理演变的结果。其具体发病机理，从肾虚为病而言，主要为房劳过度，精血亏耗，食道干涩，饮食难下，日久则阴损及阳，命门火衰，不能温煦脾胃，以致气虚不运，痰瘀互结，阻于食道，

而为本证。从噎膈整个发展过程而言，本病早期病情较轻，病理多为肝脾气结，痰气交阻，或胃津亏虚，食道滞涩，迁延发展，病情加重，则影响血运，以致痰瘀互结，阻隔胃气；或病延日久胃津亏耗，肾失所补，伤及肾阴。倘若再度发展，肾阴亏虚，累伤肾阳，肾阳日见衰惫，则可出现肾阳虚衰之征。由于脾肾密切相关，所以，命火不足，还会导致脾土失于温煦，脾气随之告竭，以致最后形成气虚阳微之证。

本证主要临床表现为，吞咽受阻，饮食不下，面色㿔白，精神衰惫，形寒肢冷，气短声低，泛吐涎沫，腹胀不适，甚至面浮足肿，舌淡胖，苔白润，脉细弱或沉细。

上述脉症出现病机是，病延日久，肾阳虚衰，命火不足，脾失温煦，纳运失常，痰湿内生，阻于食道，则吞咽受阻，饮食不下；脾肾阳微，精气并耗，形体失养，则面色㿔白，精神衰惫，形寒肢冷，气短声低；阳虚不运，水湿不化，停聚于内，甚至逆之于上，则泛吐涎沫，腹部胀满，面浮足肿。舌淡胖，苔白润，脉细弱或沉细，均为阳虚气弱之象。

总之，本证表现特点可概括为四。其一，具有吞咽受阻，饮食不下的基本症状；其二，病程较长，常于噎膈晚期出现；其三，伴有形体衰惫，脾肾阳虚之表现；其四，具有阳虚不化之舌象、脉象。临床辨证，据此常可直接作出判断。当然，如能除外其它证候，将会进一步提高本证候的诊断可靠性。如痰气交阻证、津亏热结证和瘀血内结证等，此三者在上虽均有吞咽梗阻，食饮难下之症，但前者多见于噎膈早期，且症状较重，常受情绪波动影响，同时兼见胸膈痞满，口干咽燥等症，舌偏红，苔薄腻，脉弦细而滑；次者吞咽不仅梗阻，而且伴有食道涩痛，汤水咽下犹可，固体食物难以下行，

口干咽燥，五心烦热，大便干结，形体消瘦，舌红而干，脉常细数；再次者咽下更难，常为食不得下而复吐出，甚至水饮不入，胸膈疼痛，大便干结，坚如羊屎，形瘦更甚，肌肤枯燥，舌红少津，或常青紫，脉细而涩。

阳微气虚型治疗，以其脾肾俱备，阳气虚馁，而以温补脾肾为法，并宜视其所病之脏的主次着重治之。肾阳虚衰为主者，重在温补肾阳，同时兼养精血。因噎膈晚期之阳衰，多由阴损及阳而来，精血不足多急于先，故治之之法，只宜分清主次，予以兼顾，不宜过于偏颇，失于病机。具体方剂可用右归丸加减。该方由附子、肉桂、菟丝子、杜仲、熟地、山茱萸、山药、枸杞、鹿角胶、当归组成。其中不仅以附子、肉桂、杜仲、菟丝子、鹿角胶温阳补肾；又以熟地、山茱萸、枸杞子、当归、山药补肾滋阴。如此既不失噎膈津血亏损之基本病机，也不失晚期阳气衰微之具体状况，同时还体现了阴阳互根的学说。否则不顾阴损及阳之病机改变，仅着眼于温补之药，以致温燥太过，对极度衰竭，神气俱败之人恐非相宜之策。如属脾肾俱虚，则非本方所宜，可改为六君子汤加黄芪、砂仁、附子、肉桂以兼顾之。

（二十一）头痛

头痛是临床常见病证之一。引发原因甚多，既可由感受外邪，如风寒湿热等，自表侵袭，循径上犯，入中于巅，气血受阻，清阳被抑，脑失充养引起；也可由内在脏腑，特别是肝脾肾功能失调，或邪气上犯，或髓海不足引发。肾阳亏虚所致者，即是内伤头痛中的一种证候。其病机为禀赋不足，或年老体弱，肾阳日怠，肾阳渐虚，或房劳过度，病久不愈，耗伤肾精，阴损及阳，肾阳衰微，均致清阳不振，不能上充。

于脑，脑失所养，引发本病。

肾阳虚头痛的主要表现为，头痛绵绵，或为空痛、冷痛、每兼头脑昏晕，遇劳加重，面色晄白，腰酸腿软，精神不振，畏寒肢冷，遗精带下，舌质淡胖，舌苔白润，脉象沉细两尺尤弱。

概括上述脉症出现之机理，实由肾阳亏虚，清阳不振所致。因头为“诸阳之会”、“精明之府”，赖五脏六腑精华之血，清阳之气，上注于头而养之。故肾阳虚衰，精气不足，清阳不充，脑失所养，则头痛绵绵，或为空痛。冷痛，头脑昏晕；劳则气耗，则遇劳加重；精气两虚，阳气不足，形神失养，则面色晄白，精神不振，畏寒肢冷；肾府失养，则腰膝酸软；肾阳虚衰，精关不固，则遗精；带脉失束，则带下。舌淡而胖，苔白而润，脉沉细尺弱，均为肾阳虚衰之象。

在辨证上，为了更好地确定本型，首先要除外外感头痛。因外感头痛，一般发病较急，病程较短，病势较剧，发无休止，并伴有外邪束表或犯肺的症状，而本型则病程较长，起病较缓，无外感病史及表证存在，故可排出之。其次，要分析病情，探求病机，确定证型，同时要除外相类证候。如气血不足头痛，肾阴亏虚头痛，痰浊头痛等。其中气血不足型，虽可出现头部绵绵作痛或空痛，伴有头脑昏晕，且遇劳加重，但病因不同，兼证不一，该型必兼面色苍白，唇甲色淡，气短乏力，心悸不寐，纳食欠佳，舌淡白，脉细弱等症。痰浊型虽见头昏不清，但常见头痛沉重，以及胸脘满闷，恶呕痰涎，纳呆少食，苔腻，脉滑等，而且引发病因也有不同。至于肾阴亏虚者，虽其病位也在于肾，但阴虚内热之象有之，

阳虚失煦之症缺如。总之，以上诸证，或从病因，或从病史，或从脉证，均不难区分。

肾阳虚头痛的治疗，既不能妄用辛散、清解之药，又不能过用阴柔寒凉之品。因辛散则耗伤阳气；清凉则消伐阳气；阴柔太过，则抑遏阳气。不仅与证无补，甚至反使病情加重。本证当以温阳补肾为法。使肾阳得复，清阳振奋，上充于脑，诸证祛除。方剂可选用右归丸或《金匱》肾气丸加减。前方以附子、肉桂、菟丝子、杜仲温肾助阳，强肾壮骨；鹿角胶、熟地、山药、山萸肉、枸杞子、当归滋养精血。后方以附子、肉桂温补肾阳；以六味地黄丸滋养肾阴。二方均含阴中求阳之意，不过前方药力雄厚，峻补之力胜于后者，若头痛较著，方中则加川芎、细辛温经止痛。若兼气短乏力，则加入参大补元气。若大便溏薄，则加干姜、白术温运脾阳。若见腰酸遗精，则加续断、狗脊、金樱子、芡实、桑螵蛸以强腰肾，固精气。

（二十二）眩晕

眩晕是指眼前发花，头感旋转而言。其轻者，可为头脑昏晕，闭目静养，片刻即止；重者则如坐舟车，感觉自身或周围物体旋转不定，不能站立，恶心呕吐，汗出身凉，甚至猝然晕倒。

本病病因病机较为复杂。概括之，基本病机主要为“风”、“火”、“痰”、“瘀”、“虚”诸端。其中肾阳不足，即属虚中之一斑。发病机理主要为：素体阳虚，久病及肾，年老肾亏，以及阴损及阳。以上皆致肾阳虚衰，清阳不振，难以上充于脑，脑失所养，引发眩晕。

肾阳虚衰眩晕常见脉症为，头脑昏晕，用脑尤甚，耳鸣

健忘，神疲乏力，腰酸遗精，面色㿗白，形寒肢冷，小便频数，或夜尿增多，舌淡胖，苔白润，脉沉细无力。

综合脉症，探寻病机，实由肾阳衰微，精气不足，失于温养所致。因肾阳一败，清阳不振，精气俱虚，不能上养于脑，则头脑皆晕，不耐用脑，耳鸣健忘；因腰为肾之府，肾主骨，腰府失养，则腰膝酸软无力；因精生气，气生神，精气并惫，阳气消馁，则神疲乏力；因肾藏精，为封藏之本，肾阳已衰，精关不固，则遗精滑泄；因阳主煦之，肾阳不足，温养无力，则面色㿗白，形寒肢冷；因肾主二阴，肾虚阳微，气化不利，膀胱失于约束，则小便频数，或夜尿增多。舌淡胖，苔白润，脉沉细无力，为肾阳虚衰之征。

本证辨证需与肾阴亏虚证和气血亏虚证作出鉴别。肾阴亏虚证，虽然亦见头脑昏晕，用脑尤甚，耳鸣健忘，腰膝酸软以及遗精等症，但该证是由肾阴不足，髓海空虚引起，其兼证舌脉与本证截然不同，所见为阴虚生内热之症。如面色潮红，口干咽燥，五心烦热，舌红少苔，脉弦细或带数等。气血亏虚证，在主症表现上，尽管也见眩晕，活动后加重，以及面色苍白，神疲乏力等，但毕竟有气虚、血虚或气血两虚之征象，如气短懒言，周身乏力，饮食减少，大便溏薄，或唇甲色淡，心悸不宁，失眠多梦，舌淡苔薄，脉象细弱等。没有肾虚之定位症状和阳虚之定性征象。

肾阳虚眩晕的治疗，应以补肾助阳为法。借以恢复肾中阳气，使得清阳振奋上达，气化功能进一步增强，诸症消除，病告霍然。斯时苦寒之品，辛散之药，均应慎用，以免再伤阳气。方剂可选右归丸或《金匱》肾气丸等加减。药物组成及方解见头痛一节。两者应用之时，尚可加用龙骨、牡蛎等

以潜摄浮阳。若症见滑精，则加芡实、沙苑子、金樱子、莲须等固涩肾精。气短乏力者，则加人参大补元气。

（二十三）崩漏

崩漏是指妇女不在行经期间阴道出血的一种病证。其中发病急骤，出血量多者为“崩”；起病较缓，出血量少，淋漓不净者为“漏”。

崩漏发生之机理，主要为冲任损伤，不能制约经血。但冲任受损原因较多，除热伤冲任，迫血妄行；瘀血内阻，新血离经；脾虚气陷，失于统血；阴虚火旺，精血失守外，肾阳虚衰亦属常见原因之一。此种肾阳之虚，可由素体不足，早婚多育，房劳过度，久病虚衰等伤肾而来。因肾阳一虚，命门火衰，不能蒸腾肾阴，化生肾气，冲任虚馁，约制之力不足，精血不能固守而引起崩漏。

肾阳虚证崩漏常见脉症为，出血量多，或淋漓不断，血色淡红，面色晦黯，精神萎靡，头目昏眩，腰膝酸软，畏寒肢冷，尿频而长，大便溏薄，舌暗淡，苔薄白，脉沉细或微弱，两尺尤甚。

脉症病机主要为，肾阳不足，冲任不固，难以制约经血，则出血量多，或淋漓不断，血色淡红；阳气虚衰，清阳不振，气血受损，则面色晦黯，精神萎靡，头目昏眩；阳气衰微，失于温煦，则畏寒肢冷；腰府失养，则腰酸腿软；肾阳不足，气化不利，开合失常，则尿频而长；火不生土，则大便溏薄；舌暗淡，苔薄白，脉沉细或微弱，两尺尤甚，为肾阳虚衰之象。

本证与肾阴虚证表现不同。后者，①下血鲜红；②兼有阴虚生内热之表现，如头晕耳鸣，五心烦热，夜寐不宁，盗汗。

等；③舌红少苔或无苔，脉象细数。肾阳虚衰之证与脾虚之证，虽均见暴崩下血，血量较多，或淋漓不净，质薄色淡以及面色晄白等，但脾虚者仅兼气短懒言，体倦乏力，胸脘满闷，饮食欠佳，大便溏薄等气虚表现，而无肾虚、阳衰之定位，定性症征。至于血热与血瘀所致者以其病性皆属实证，与肾阳虚者截然不同，区分一般比较容易。血热者其色深红，热证明显，如症中常见口干喜饮，头晕面红，心烦失眠等，舌红苔黄，脉象滑数；血瘀者则下血常挟血块，色深暗，小腹疼痛、拒按，瘀块排出疼痛减轻，舌黯红或边尖有瘀点、瘀斑，脉沉涩或弦紧。

肾阳虚崩漏在治疗上当以温肾止血为法。方剂可选右归丸加减。该方由熟地、山药、山茱萸、附子、肉桂、当归、枸杞、菟丝子、杜仲、鹿角胶组成。因肉桂、当归另有通经行血之功，故临证时使用可去之；同时加用黄芪、赤石脂、禹余粮益气温肾，固涩止血。如脾阳亦虚，则加入参、黑姜温健中阳。如兼血瘀，则加乳香、没药、蒲黄、五灵脂活血化瘀。

（二十四）绝经前后诸症

绝经前后诸症，又称经断前后诸症。是指妇女在四十九岁左右，月经断绝前后，所出现的经行紊乱，头晕耳鸣，心悸失眠，烦躁易怒，烘热汗出，五心烦热，或腰膝骨楚，体倦乏力，下肢浮肿，大便溏薄，甚或精神异常等症。以上诸症虽不至同时俱见，但常轻重不一，数者并发。其甚者竟可延续二三年之久。

妇女绝经前后诸症的出现究其所因，主要在于肾虚。因妇女临近五旬，肾气渐衰，冲任日亏，天癸源于衰竭，精血

益发不足，随之阴阳相对平衡遭受破坏，致使阴阳偏盛偏衰，甚至波及它脏，引起绝经前后诸症出现。在发病中肾阴虚衰者固然多见，但肾阳虚者亦常有之。其引发原因主要为素体虚弱，久病劳伤，肾阳虚衰，命火不足，经脉失于温养，脏腑功能失常，发为本证。

绝经前后诸症临床表现为，经断前后，经行紊乱，面色晦黯，或面部虚浮，肢体浮肿，精神萎靡，纳食欠佳，腹胀不舒，畏寒肢冷，尿意频数，甚或小便失禁，大便溏薄，舌质暗淡，苔白而润，脉沉细无力。

所见脉症病机，概括起来，主要为肾虚阳衰，命火不足，脾土失煦，冲任亏损。因妇女年近五旬，肾气衰惫，命火不足，冲任亏虚，月经失调，则经行紊乱；阳气已虚，形神失于温养，则面色晦黯，精神萎靡，畏寒肢冷，得衣被而减；肾阳虚衰，不能温煦脾阳，脾运失健，则纳食欠佳，腹胀不舒，大便溏薄，膀胱气化不利，开合失司，水液内停，泛滥肌肤；则面部虚浮，肢体浮肿，尿意频数，甚或小便失禁，肾阳虚微，无力温养与鼓动，则舌质暗淡，苔白而润，脉沉细无力。

本证与肾阳虚证表现不同。因肾阴不足，虚热内生，机体失于濡润滋养，故其症常见经行紊乱，头晕耳鸣，失眠多梦，心烦易怒，时觉烘热，伴有汗出，手足心热，腰膝酸软，口干咽燥，小便短黄，大便干结等。舌红苔少，脉细数。

绝经前后诸症肾阳虚候的治疗，仍以补肾温阳为法。使肾中阳气恢复，肾气充实，冲任之脉得以温煦，阴阳气血平调，诸证消除。因阴阳之间，相互资生，相互为用，所以方

药运用必须遵从阴中求阳之旨，不可单纯使用温热燥烈之品以耗散之。方剂仍可選用右归丸加減。如便溏軟重，則去當歸以免滑腸，另加茯苓、白朮、五味子、肉豆蔻健脾止瀉。如屬陰陽兩虛，則改用二仙湯加減治療。

（二十五）妊娠腫脹

妊娠腫脹是臨床比較常見的婦科疾病。它是指婦女妊娠後出現肢體面目腫脹而言。古人以其腫脹部位和程度的不同，又稱為子腫、子滿、子氣、皺腳等。但妊娠七八月後，出現單純足部浮腫，且無其它不適者，產後常可自消，故一般無須治療。

妊娠腫脹的發生，從臟腑失常而言，主要責于脾腎。因脾主運化，能斡旋中氣；腎為水臟，主氣化開合，所以二臟之陽氣對水液的輸運，氣機的升降，均起着重要作用。足見腎陽虛衰確為致發妊娠腫脹的重要原因之一。其引發機理主要在于，素體腎虛，又逢妊子，陰血多聚于下，影響腎陽敷布，既碍于化氣行水，又不能溫脾制水，水液內停，泛濫肌膚，引發為腫脹。

妊娠腫脹腎陽虛證常見脈症主要為，孕後數月，面浮肢腫，下肢尤甚，按之沒指，不易恢復，心悸時作，氣短乏力，腰膝酸軟，手足不溫，形寒怯冷，舌淡胖，苔白潤，脈沉細無力。

上述脈症出現機理為，素體腎虛，又逢妊娠數月，陰血下聚，腎陽失布，氣化不利，不能主水，水液停聚，且水濕滲下，則症見面浮肢腫，下肢較甚，按之沒指，不易恢復；水氣上凌于心，心神不寧，則心悸時作；腎陽不足以溫養形體，則氣短乏力，腰膝酸軟，手足不溫，形寒怯冷，舌淡

胖，苔白润，脉沉细无力均为阳虚水盛之象。

本证辨证之时，须与脾虚、气滞之证作出鉴别。脾虚者是由脾阳虚弱，不能制水而成，其表现除浮肿外，必兼脾虚不运的症状，如面色萎黄，气短乏力，纳少便溏，食入腹胀，手足不温等；气滞者是由肝郁气阻所致，其表现为，肿胀多从足部开始，涉及于腿，皮色不变，随按随起，同时伴有气机升降失调的症状，如头晕胀痛，胸闷胁胀，善太息等。

妊娠肾阳虚肿胀之治疗，当以温肾化气行水为法。方剂可选真武汤加减。该方由茯苓、白术、附子、白芍、生姜组成。其中以附子温助肾阳，茯苓、白术、生姜运脾行水；白芍开阴结，制约温燥。因附子终属有毒之品，宜以桂枝易之。水肿严重，小便短少者，也可合五苓散加减。

（二十六）妊娠小便不通

妊娠小便不通，又称“转胞”或“胞转”。是指妊娠期间，小便闭塞，难以排出尿液，甚至小腹胀急疼痛而言。病机主要为胎气下坠，影响膀胱，水道不通。具体引发原因有二，除中气不足，升举无力，胎重压迫膀胱所致者外，因胞脉系于肾，而与肾虚也密切相关。如素体肾虚，阳虚气馁，受孕之后，肾气愈亏，以致无力系胞，胎压膀胱，以及肾阳虚衰，气化不及州都，膀胱开合失司，而引发本病。

肾阳虚候妊娠小便不通，脉症可见妊娠小便频数不畅，甚至闭而不通，小腹胀满疼痛，坐卧不宁，面色晄白，腰膝酸软，畏寒肢冷，舌淡，苔白润，脉沉滑无力等。

本证脉症出现的病机为，肾虚阳衰，气化无力，不能系胞，水液停聚，膀胱过于充盈，故症见妊娠期间，小便频

数，排出不畅，甚至闭而不通，小腹胀满疼痛，坐卧不宁，肾阳虚惫，不能温煦形体，则面色㿔白，腰膝酸软，畏寒肢冷，舌淡，苔白润，脉沉滑无力等。

辨证时本证须与气虚之证相鉴别。后者主症虽与前者相同，但所兼脉症却有差别。气虚者兼见面色㿔白，倦怠乏力，饮食减少，气短懒言，头重眩晕，大便溏薄，舌淡，苔薄白，脉虚缓而滑。绝无肾虚、阳衰之征象。

在治疗上，本证当以温肾助阳，化气行水为法。方剂仍可选用《金匱》肾气丸加减。斯时因属妊娠期间，故应用本方当去附子，丹皮以免有碍胎气，并加入菟丝子、巴戟天以助温肾行水。

（二十七）不孕症

不孕症为妇科常见病之一。系指婚后夫妇双方同居三年以上，未经避孕而不受孕，或虽曾生育或流产，但三年以上未避孕而不能再孕者。中医文献中常将前者称为“无子”或“全不产”；后者称为“断绪”。

妇女受孕是在肾气充实，精血充沛，冲任旺盛，胞脉畅通，月事以时的情况下，两精相抟而成。大凡肾气不充，精血不足，冲任失调，胞系受阻或失养，则难以成孕。引起以上病理变化的原因可概括有三，即肾虚、肝郁、痰湿。其中尤以肾虚最为突出。肾阳虚衰之所以致成不孕，其机理主要为：冲为血海，任主胞胎。肾阳既虚，精血不足，以致冲任空涸，胞脉失于温养，不能摄精成孕，引发是证。

本证临床表现主要为，婚久不孕，月经后期，量少色淡，面色晦黯，腰酸觉冷，小腹发凉，腿膝无力，性欲减退，小便清长，大便不实，舌淡苔白，脉沉细或沉迟。

肾阳虚证不孕脉症出现的机理是：肾阳虚衰，冲任失于温养，血海不足，则月经后期，量少色淡，小腹发凉，婚久不孕；阳气不振，失于温煦，则面色晦黯，腰酸觉冷，腿膝无力，性欲减退；火不生土，膀胱气化不利，则小便清长，大便不实。舌淡，苔白，脉沉细或沉迟，均为肾阳虚衰之象。

本证辨证之时须与肝郁、痰湿证进行鉴别。肝郁不孕证除也见多年不孕外，尚见经期先后不定，经来腹痛，行而不畅，量少色黯，夹有血块，以及经来乳房胀痛；同时常兼肝郁不舒之脉症，如精神抑郁，烦躁易怒，胸胁胀满，舌质正常或暗红，苔薄白，脉弦等。痰湿不孕证，则多见于形体肥胖之人，并有月经后期，甚或经闭，白带量多，质地粘稠，以及痰湿内阻，升降失常之症象，如面色苍白，胸脘满闷，食少泛恶，苔腻，脉滑等。

肾阳虚证不孕的治疗，根据肾阳不足，冲任失养的基本病机，当以温养肝肾，调补冲任为法。方剂常选毓麟珠加减。该方由菟丝子、杜仲、鹿角霜、川椒、当归、熟地、白芍、川芎、人参、白术、茯苓、甘草组成。其中以菟丝子、杜仲、鹿角霜、川椒温肾助阳；熟地、当归、白芍、川芎养血和血；人参、白术、茯苓、甘草益气健脾。本方具有温养先天，兼顾后天，并调血脉之功，用之可使精血充盛，冲任调和，促成受孕。临证用时尚可加紫河车温养肝肾，补益精血；丹参、香附理气调血。若肾阳虚衰较著，症见少腹发凉，腰酸冷痛，四肢不温，则加仙茅、仙灵脾、巴戟天、补骨脂以增强温肾助阳之力。

二、肾 阴 虚

肾阴，又有元阴、真阴、肾水、真水之称，是指本脏所藏阴液而言（包括肾精），为人体阴气之根，它与肾阳依附为用，是肾阳功能活动的基础。所谓肾阴虚，就是肾中寓藏潜纳的阴液虚少亏乏的病理变化。肾中所藏的阴阳应保持相对平衡，如因各种原因致使平衡失调，则可形成肾阴不足的各种证候。

肾阴不足的引发原因，或因房室不节，劳欲伤肾；或因早婚多育，伤精耗液；或因过服温燥辛热之药，劫夺肾阴；或患急性热病，耗伤真阴；或因久病之后，元阴亏损等等。上述种种病因，均可导致肾中阴液损伤不足，从而引起许多病证。相火妄动，也能灼耗肾阴。由于肾阴不足是肾虚的一个方面，因此，多将肾虚而有热象者称为肾阴虚。

肾阴虚的症候临床极为常见，主要表现为精神疲乏，面容憔悴，头晕目眩，耳鸣耳聋，腰酸膝软，少寐健忘，发脱齿摇，或伴见遗精早泄，口干咽痛，两颧潮红，五心烦热，或午后潮热，舌红少苔，脉细。

肾阴亏虚出现上述脉症，与其生理特点和病理改变直接相关。因肾藏阴精，其华在发，充养精神，由于本脏阴虚不足，不能华面养神，故精神疲乏，面容憔悴，失眠少寐，毛发脱落；脑为髓海，耳为肾窍，肾阴亏乏，髓海不足，脑窍失养，故头晕目眩，耳鸣耳聋，记忆减退；腰为肾之府，肾且主骨，齿为骨之余，肾脏真阴不足，外府失荣，骨失滋养，故腰酸膝软，牙齿动摇；肾阴亏乏，虚火易动，封藏固

摄无权，故遗精早泄；心肾阴虚，虚火上炎，故口干咽痛，两颧潮红，五心烦热；阴虚不能恋阳，浮阳外越，而见午后潮热，舌红少苔脉细，均为真阴不足之象。

肾阴亏乏之证，非为短暂时日所形成，故诊断肾阴不足，应具备以下各项内容，即首当察寻房室不节，劳欲伤肾等耗损肾阴的某种病因及损伤肾阴的病史。其次当有头晕耳鸣，腰酸膝软等肾脏阴虚的主要特点。再次不仅见到肾虚的表现，同时也应见到口干颧红，心烦潮热的症状。这些条件齐备，确诊肾脏阴液亏虚并不困难。

治疗肾阴虚，常用滋补肾阴之法，每以六味地黄丸之类为代表方剂。

肾阴虚常见的病证有内伤发热、咳嗽、喘证、哮证、淋证（膏淋、劳淋）、尿浊、消渴、遗精、妊娠失音等。

（一）内伤发热

肾阴虚所致发热是内伤发热的一种，这种发热多由素体阴虚，或热证日久伤阴，或误用、过用温燥药物，导致阴液亏损，火不受制，阳气亢奋乘阴，阴虚而生内热。《景岳全书·火证》所说“阴虚者能发热，此以真阴亏损，水不制火也”，恰当地描述了阴虚发热的病机。

肾脏阴虚发热的主要脉证是，午后或夜晚发热，手足心热，或骨蒸潮热，发热不欲近衣被，两颧红赤，心烦盗汗，失眠多梦，腰酸膝软，口干咽痛，遗精早泄，舌红少津或有裂纹，苔少或无苔，脉细而数。

本证所以出现上述脉证，总的说是因阴精亏虚，虚热内盛而成。阴虚则生内热，其病又在阴分，故见午后或夜晚发热，手足心热，或骨蒸潮热，发热不欲近衣被；阴虚而火炎

于上，扰动心神，故颧红咽痛，心烦失眠，内热迫津外泄，故盗汗；阴精不足，肾之外府失养，故腰酸膝软，虚火扰动精室，或肾虚失于固藏，故有遗泄之证；口干，舌红少津，或有裂纹，少苔或无苔，脉细而数，均属阴虚有热之象。

由于阴与血皆为有形，性同属阴。若阴血亏损，不能摄敛阳气，向外浮越，由是引起发热，故阴虚发热当与血虚发热作出精细鉴别：血虚所致发热，热势或高或低，主因损伤血分，血虚不能濡养头部和心主，也难荣华面唇，故在发热的同时，必见头晕眼花，身倦乏力，心悸少寐，面色无华，唇甲色淡，舌淡脉细等血虚之证。而阴虚发热则是午后发热或骨蒸潮热的同时，并见心烦失眠，舌红少津，脉象细数等阴虚有热之证。把握住二者特点，鉴别并非难事。至于气虚、阳虚、肝郁等证型的发热，与阴虚发热迥然有别，自易分清，兹不累述。

肾阴虚之所以导致发热，关键在于本脏所藏真阴亏损虚少，阳气不能与其相配，形成相对偏盛而见热象。因此治疗此证必须谨守病机，令其阴液复原，阴液得复，虚火自然潜敛而发热自止，万不能一见热象，辄投苦寒妄泄其火，若以此法施之，不仅无益，反生祸害；或伤其中阳致使病情变得复杂；或化燥伤阴，致令证候进一步加重。恰当的治疗，宜用滋养肾阴，退其虚热之法，代表方剂为六味地黄丸合清骨散加减。前方由生地、山药、山茱萸、茯苓、丹皮、泽泻组成，后方原有地骨皮、青蒿、银柴胡、胡黄连、秦艽、鳖甲、知母、甘草等味。方中六味地黄丸合鳖甲可滋阴养液，银柴胡、青蒿、地骨皮、胡黄连、知母、秦艽以退热除蒸。若阴虚较甚者，可加玄参、龟版、首乌、女贞子，以增强滋

养阴液之力。心烦不安，失眠多梦者，加枣仁、柏子仁、夜交藤等养心安神。盗汗明显者，可加煅牡蛎、浮小麦、糯稻根，以固表止汗。本证主方为何选用六味地黄丸合清骨散，而不施以大补阴丸之类？从方剂组成来看，大补阴丸用熟地、龟版、知母、黄柏滋肾水，填真阴，以制相火，是为阴精不足相火偏旺之证而设。而本证是属肾水亏虚，兼而有热之证型，并未达到火旺的程度，故选用六味地黄丸滋养肾阴、清骨散清退虚热，即可达到治疗目的。

肾阴虚发热，多因各种原因损伤肾中元阴所致，所以尽早去除病因是最积极的治法，特别是急性热病因耗伤阴液最速，故应给予及时治疗。由于情志不遂每易化火伤阴，患者平时应保持精神愉快，避免情志刺激。阴虚发热多属慢性疾病，病程较长，罹患此病后要适当休息，减轻思想负担，树立战胜疾病信心，与医者密切配合，这样定能消除疾病，使身体恢复健康。

（二）咳嗽

咳嗽是肺系疾患之一，多因外邪犯肺，肺气不宣所引起，或由脏腑功能失调，累于肺脏，气失肃降而发生。肾阴不足咳嗽是脏腑功能失调所致咳嗽的一个证型。

肺主气，以宣降为顺；肾藏精，不能够外泄。若久病伤肾，或内伤咳嗽不愈，肾脏受累，致肾阴亏虚，不能助肺吸气，因而出现呼吸短促而咳。由于在生理上肺阴与肾阴有着相互滋生、相互依存的关系，若肾阴下亏，不能上滋肺金，或虚火上灼于肺，也能出现少痰之干咳。

肾阴虚咳嗽是以咳声连连，夜间咳重为特点，兼有五心烦热，腰膝酸软，动则气促，梦遗滑精。舌红少苔，脉细而

滑。

本证由于肾水亏虚，不能上滋于肺，肺失润降，故咳嗽连连；夜为阴，病本又属肾阴不足，两阴相并，故以夜间咳嗽为重；虚火内扰，故五心烦热；肾虚不能荣养外府，且失于摄纳，故腰膝酸软，动则气促；肾阴亏损，虚火扰动精室，故梦中精液外遗；肾虚封藏失固，则无梦亦见精液滑泄。舌红少苔，脉细而滑是属肾阴不足兼有虚热的征象。

肾阴虚咳嗽属阴虚咳嗽范畴，由于肺阴虚或心阴偏虚也能引发咳嗽，故应予鉴别。肺阴虚咳嗽主因阴虚内燥，肺失滋润，肃降无权，气逆于上所致，多以干咳少痰或咳痰不爽，口干咽燥，或见咯血为主证。肾阴虚咳嗽是以夜间频频作咳为特点，并无口干咽燥等肺燥的症状。心阴虚咳嗽多因心阴不足，虚火上灼肺金，肺失清肃所致，是以咳嗽并见心烦口干，心悸不寐，口舌生疮等心经症状为特征，而腰膝酸软，梦遗滑精等肾咳兼证则少见。至于肝火犯肺咳嗽，多以咳呛气逆，烦躁易怒，胁肋疼痛为主。肺气虚咳嗽多是喘而兼咳。肾阳虚咳嗽每以咳嗽反复发作，兼见畏寒肢冷，面浮为重点。上述三个类型也各具特点，与肾阴虚咳嗽不难作出鉴别。

肾阴虚咳嗽的发生，是以肾脏阴亏为其根本。又因金水相生，肺肾相濡，所以肾阴虚咳嗽与肺脏密切相关。无肾阴不足，肺失濡润，有耐肃降，气上逆则成咳，故治疗肾阴亏虚之咳，不能舍弃肺金不顾，每于滋养肾阴固其根本的同时，加入少许润肺止咳之品，二者相得益彰，收效更为显著。临床上是以补益肾阴、润肺止咳为其治疗大法，代表方剂为七味都气丸或八仙长寿丸。前方由地黄、山药、山茱

萸、茯苓、丹皮、泽泻、五味子组成，后方有地黄、山药、山茱萸、茯苓、丹皮、泽泻、麦冬等药物。方中以六味地黄丸补肾益阴，五味子滋肾敛肺，麦冬滋阴润肺。上述两方之中均可加入沙参、天冬、川贝母等药，以增强滋肾润肺、敛肺止咳的作用。如系阴虚之体，或高年之人，证见咳嗽呕恶，喘逆痰多，且带咸味，此属肾肺阴虚，痰湿内盛之咳，当用功具滋养肺肾、祛湿化痰的金水六君煎进行治疗，临床实践证明，如确系肺肾亏虚致咳，尤以夜咳明显者，用本方治疗不仅相宜，也确能收到满意效果。若肾阴亏损甚重，咳嗽日久不愈而兼喘者，施以参蛤散加熟地、五味子等，可收益肺滋阴、补肾纳气、止咳定喘之功。

肾阴虚咳嗽属内伤咳嗽之一，多有反复发作过程，且逐渐加重，治疗本证难取速效，故预防调护显得十分重要：注意寒温调节，特别是严冬季节更要注意防寒，以减少外界因素诱发咳嗽；生活起居有常，房事不可过度，以防在原有肾虚的基础上，再度耗伤肾阴，致使病势加深，更难治愈；适当参加活动，如体力劳动和体育锻炼，以增强抗病能力；在病情缓解，应坚守“缓则治其本”的原则，从补肾固本着手，以冀达到根治的目的。

（三）喘证

肾阴虚作喘的主要脉症是，喘促气短难续，声音低微，呼多吸少，耳鸣腰酸，动则气喘加重，喘时面赤颧红，咽干口燥，手足心热，潮热盗汗，舌红脉细。

肾阴亏虚所以出现喘促，气短难续，呼多吸少，动则喘甚，是因肾阴受损之后，阳气亦虚，阴不敛阳，气不归根之故；耳为肾之外窍，肾之阴液不足，不能上濡外窍，故耳中

鸣响，肾虚外府失荣，故腰膝酸楚，阴虚火炎于上，故喘时面赤颧红，咽干口燥，手足心热，或午后潮热，肾阴不足，虚火内扰，故见盗汗，舌红，脉细均为肾脏阴虚之征。

阴虚作喘，以肺阴不足与肾阴亏虚为多见，且两者喘促主证相近，故应予辨别，肺阴不足之喘，在喘促短气，声音低微的同时，主要兼见咽喉不利，口干舌红，或干咳失音。肾阴虚之喘，虽亦证见喘促短气，声音低微，但主要兼证则是耳鸣，腰酸，潮热盗汗，或有遗精早泄，而很少兼见肺阴虚症状。至于肾阳虚衰，肺脾气虚也可作喘，但与肾阴虚之喘促有明显的区别。

肾中真阴不足喘证绝非短日所成，治疗时必须充分认识到这一点。由于人体阴阳之中，有阳易回而阴难复的特点，补益肾阴治疗喘证，只能令其逐渐滋生，而不可指望施于骤补而取效，如若妄补，所进阴柔之品有耐于胃，形成欲速则不达之势，病反难愈。此外，肾阴亏虚作喘，多因阴不敛阳，气失摄纳而成，故应施以补肾滋阴，纳气平喘之法，代表方剂为七味都气丸。本方由地黄、山药、山茱萸、茯苓、丹皮、泽泻、五味子组成，方中以六味地黄丸滋补肾阴，肾阴充足，虚热收敛，喘促可减；五味子功能敛肺滋肾，纳气定喘，故用本方治疗肾阴虚作喘疗效甚佳。

(四) 哮证

肾阴虚哮证多因恣情纵欲，房室不节，或病后体弱，失于调养，以致肾脏阴液亏损太过，阴虚火升，上累于肺而成。由于本证常反复发作，经久不已，不仅肾精亏虚，肺脏受累亦虚，故在哮证发作时，多以呼吸迫促，张口抬肩，喉间哮喘，痰粘难出，胸中烦闷等标实之证持续不解为主，肾虚之

本象往往被掩盖，或仅见舌红，苔黄，脉细而滑。一旦哮喘暂平，疾病处于缓解期，肾阴不足之虚证才上升为主要矛盾，证见气短少吸，动则喘促更甚，腰酸膝软，手足心热，咽干虚烦，或有盗汗，舌红少津，脉细而滑。即使在平时，比较轻微、持续不断的短气喘促，喉间鸣响之声也难于全部消失。

哮证与喘证虽均有气息喘急迫促的表现，且多并发于多种急慢性疾病过程中，但二者实有不同，喘证是以呼吸急促、喘息不得平卧为主要特点，而哮证在呼吸迫促的同时，喉间出现哮鸣声响，所以虞抟在《医学正传》里以“喘以气息言，哮以声响言”一语概括了哮与喘的区别，这对临床辨证十分有益。

肾阴虚与肾阳虚哮喘，其基本病机均属肾虚摄纳失常，临床表现也都有平素短气喘促，动则喘甚，腰酸膝软的症状，但二者的不同点必须辨别精细，方不致治疗生误。肾阳虚哮喘主要兼有怯寒畏冷，神疲倦怠等阳虚外寒之证，而肾阴虚哮喘是以盗汗失眠，手足心热等阴虚内热之证为主要兼证。至于肺脾气虚所致哮喘各有自己的特点，故与肾阳虚哮喘不难分辨。

肾阴虚哮喘是以缓解期为多见，有的兼见某些肾虚症状，有的并无明显不适，故其治疗应重在平时调理，意在去除病根，令其不再复发，此属治本。如果突然感受外邪，疾病急性发作，应尽早消除诱因，减轻病人痛苦，此属治标。有时也要标本兼治。因痰浊是本病之宿根，治标常用具有清肺宣肺、化痰平喘的炙桑皮、炙麻黄、葶苈子、杏仁、生石膏等药物；治本则应施用滋阴补肾纳气的生地黄、熟地黄、五味

子、紫河车、天门冬、麦门冬，常用方剂以七味都气丸为主方。

肾阴虚哮喘与其它类型的哮喘一样，宿根深固，难以根除。童幼患者可随年龄的增长，肾气日盛，肺气渐旺，若辅以药物治疗，并注意诱发因素，尚可有痊愈之希望。成年患者由于反复发作，日久肾虚，更属顽证。从临床实践看，哮喘以属寒者为多，阳虚是其根本。至于肾阴虚哮喘，往往不是初始即见，其阴虚多由阳损及阴所致，因而更为难治，故在缓解期要避免诱因，不仅要预防外邪侵袭，勿进生冷海腥，保持精神愉快，更要培养肾本，长期坚持治疗，此属救治本证的积极办法。

（五）膏淋

膏淋为五淋之一，是以小便混浊，或如米泔，或见膏脂，尿出不畅为特征的一种病证。本证有虚实之分，肾阴虚膏淋属虚证范畴。肾脏真阴不足所致膏淋的病机是，湿热膏淋经久不愈，或淋证反复发作伤及肾阴；素体阴虚，淋病日重；房劳多产，耗伤真阴。阴精不足，肾气亦亏，以致下元不固，脂液下泄，形成尿液混浊的膏淋。

肾阴虚所致膏淋的主要脉症是，患病日久，淋出如脂如膏，尿道热痛不甚明显，形体日渐消瘦，头昏乏力，腰膝酸软，舌淡苔腻，脉细数无力。上述各证是因淋证日久，反复不愈，肾虚不能制约脂液而成。

小便混浊如米泔水之膏淋，不仅肾阴亏虚可致，膀胱湿热，气化不利，清浊相混也可形成，然二者一虚一实，表现各异。湿热膏淋在小便排出混浊尿液或滑腻之物的同时，尿道热涩疼痛甚为明显；肾虚膏淋则以病久形瘦，头昏腰酸等

肾阴不足症状与淋出如脂并见。此外，肾阴亏虚也可引起劳淋，某些症状与膏淋相似，应作出鉴别：肾劳淋发生于房劳之后，且兼面色潮红，五心烦热，然绝无肾虚膏淋小便混浊如同膏脂的特点，这是二者最重要的区别。

形成肾阴虚膏淋的关键，在于肾虚下元不固而脂液下，故应予补肾固涩之法，代表方剂可选六味地黄丸合金锁固精丸。金锁固精丸由芡实、莲须、沙苑蒺藜、龙骨、牡蛎等药组成。方用六味地黄丸补肾滋阴，沙苑蒺藜、芡实、莲须、龙骨、牡蛎固护下元，以复其摄纳脂液之权。

（六）劳淋

劳淋亦为五淋之一，是因各种淋证发病日久未能痊愈，一遇劳累或入房太甚，即可发病或加重的病证。劳淋每有脾虚肾亏之别，肾虚又有阳衰阴损之异，此处仅讨论肾阴亏虚所致劳淋。肾虚劳淋的引发，与血淋、膏淋有某些共同之处，即初起多为湿热蕴结膀胱，由于失治误治，迁延日久，反复发作，损伤肾阴，由实转虚而成。

肾阴虚劳淋多是淋病日久，调治失宜；或体弱肾虚，本元不固，在此基础上，加之劳欲过度，房室不节，复损肾阴，遇劳即发为本证，由此可见，肾虚劳淋总与房劳有关。

肾脏真阴偏虚所致劳淋的主要脉症是，小便涩痛不甚，但淋漓不已，时作时止，每遇房劳即发，兼见腰痛酸楚，尿有热感，五心烦热，舌红少苔，脉细或数。

由于肾阴亏虚，下元不固，复因房劳所伤，小便失其所主，病属虚证，故见小便涩痛不甚，但淋漓不止；肾虚腰府失养，故腰痛酸楚；热注下焦，故尿有热感；虚热内炽则五心烦热；舌红少苔，脉细或数，均属肾阴不足之征。

《顾松园医镜·淋》曾提出，劳淋“宜辨其因心劳、脾劳、肾劳之不同”。那么三者有何不同，怎样区分？心劳多因思虑劳心而加重，伴见小便滞涩，尿意不尽，小腹微胀，心悸短气，困倦乏力，口干舌燥，失眠多梦等证。脾劳每因劳倦过度而复发，体见小腹坠胀，迫注肛门，便意不尽，小便点滴而出，精神困倦，少气懒言等证。而肾劳无论阴虚、阳虚，均与房劳有关。偏于阳虚者，兼见畏寒怯冷、四肢不温；偏于阴虚者，兼见尿有热感，五心烦热。

肾阴虚劳淋所以形成，其关键在于肾水不足，故当施以滋阴益肾，固摄下元之法，代表方剂为六味地黄丸（组成从略）。方中地黄、山茱萸、山药可滋阴补肾，固摄阴精；茯苓、丹皮、泽泻功能渗湿泻火，且可防止补药之滋腻，并可加入何首乌、败龟版、女贞子，以增强补益肾阴之力。以上各药合用，滋补而不留邪，降泄而不伤正，体现了补中有泻，泻中寓补，相辅相成的道理，因此本方是补肾益阴的理想方剂。如果肾阴不足兼有肾阳轻度亏损者，可合用《沈氏尊生书》所载菟丝子丸。本方由菟丝子、枸杞子、山药、茯苓、莲肉组成，方用菟丝子补肾助阳，枸杞子助六味丸滋养肾阴，莲肉补肾固精，故二方合用，疗效更佳。

肾虚劳淋多因房劳之后复发或加重，因而患淋证后应特别注意“远房帑”——节制房事，以养肾阴。并要避免心身过劳，积极治疗原有淋证，这样才有助于身体的康复。

（七）尿浊

肾阴不足尿浊的临床表现，除小便混浊，色如米泔外，每可兼见阴虚内热的烦热口干，舌质色红，脉细带数等脉证。治疗肾阴亏虚之尿浊，首当滋养肾阴；肾阴滋生则虚火潜降，

病当自愈。常以二至丸为主方，本方由女贞子、旱莲草二药组成，另可加入生地、山茱萸、枸杞子、知母等，助原方滋阴补肾。若因虚火内炽，灼伤血络，证见小便混浊而赤，于原方之中重用旱莲草，以滋阴止血，并可加入丹皮、龟版，以滋阴凉血止血。

尿浊与膏淋有相似之处，临证之时当详辨勿漏。膏淋虽见小便混浊如米泔，或有滑腻之物，但排尿之时必见尿道涩痛，而尿浊则无疼痛之感。此外，尿浊与白淫也有不同，白淫可因尿浊日久不愈，渐至火衰寒盛，每于情欲触动出现流精清稀而尿道不痛的症状；尿浊则尿液较白淫稠浊，且色白如米泔样，因此二者并不难作出鉴别。

根据肾虚尿浊形成的原因，本证罹患后，应注意避免劳欲过度。

（八）消渴

消渴是指因饮食不节，情志失调引起的以多饮，多食，多尿，身体消瘦或尿有甜味为特征的一种病证。依其发病机理的不同和“三多”症状的主次，又将本证分为上消、中消和下消。《医学心悟·三消》曾对此作出明确的阐述：“渴而多饮者为上消，消谷善饥者为中消，口渴、小水如膏者为下消”。肾阴不足所致消渴多属下消，又称肾消。

关于消渴的病机，总的说不外阴津亏损，燥热偏盛，且以阴虚为本，燥热为标。肾阴虚消渴的形成，或因先天禀赋不足，肾之脏阴素亏；或因壮盛之时，不自慎惜，房事频多，肾阴亏损。加之调摄失宜，阴亏益甚，虚火上蒸肺胃，损伤肺胃之阴。遂致肾虚肺燥胃热俱现，由此发为消渴。消渴虽与肺、胃、肾三脏腑均有关系，但肾阴亏虚则是其根本。

肾阴虚所致消渴的主要脉证是，小便频数量多，尿液混浊如膏脂，或有甜味，兼见烦躁失眠，多梦遗精，头晕耳鸣，腰酸膝软，口干舌燥，舌质偏红，脉沉细数。

肾阴虚所以出现上述脉证，是因肾之阴液亏损，下元不固，无以束约小便，故尿频量多；真阴不足，阴虚阳盛，肾之开阖失司，固摄无权，水谷精微下注，故小便混浊如膏如脂，或有甜味；肾阴亏虚，水不济火，虚火扰心，故烦躁失眠；相火扰动精室，故精液外遗；肾脏阴虚，头脑乏精滋养，故头晕耳鸣；肾虚外府失荣，故腰膝酸软；口干舌燥，舌质偏红，脉沉细数，均属肾阴不足，虚火偏盛之象。

口渴多饮，小便频数，尿液混浊如膏脂等肾消主证，在外感热病及淋证中也有所见，三者应予鉴别：古代文献中亦有将外感热病过程中出现的口渴饮水症状称为“消渴”者，但这类口渴却无多饮、多食、多尿并见的特点。湿热淋或石淋所见小便频数的同时，多兼见涩滞疼痛，淋漓不爽或尿频尿黄的症状，而消渴证仅是小便频数量多，并不伴有尿道疼痛。肾虚膏淋之证也见小便混浊如脂，但既属淋证，必兼尿道轻微涩痛，但尿无甜味，这与下消有明显区别。

肾为先天之本，主藏阴精而内寓元阳。脏阴不足，肾阳相对偏盛，不仅导致肺燥胃热，肾之虚火也随之上炎，因而出现肾消症状。治疗肾阴虚消渴，滋补肾之阴液实属关键所在，因为肾阴充足，肺胃得以濡润，燥热可以减轻，同时肾之虚火亦即敛藏潜降，由是三消之证自当逐渐好转。临证疏方时，滋阴固肾为治疗下消的定用之法，常用方剂为六味地黄丸加味。方用地黄、枸杞子、女贞子滋补肾阴；山药、山茱萸均宜重用，山药可用30克至60克，甚至更大剂量，山茱

藟可用20克至30克。此二药所以重用，是因山药性味甘平，不寒不燥，归经脾胃肺肾，其功能除滋补肺肾之外，尤擅长益脾阴而摄精微；山茱萸性味酸涩，归经肝肾，功能固肾益精，不使水谷精微下流。丹皮、地骨皮清其虚热；茯苓、泽泻泄肾中湿浊而不伤阴。若加入五味子、桑螵蛸、龙骨、牡蛎，更可增强固摄精微之力。此外，由于肾虚为消渴之本，因此不仅下消，即使上消、中消，其治疗在侧重滋阴润肺或清泻胃火为主的同时，每每加入生地、首乌、女贞子、五味子、山茱萸、桑螵蛸等补肾益阴，涩敛精气之品，收效较为理想。

下消一证本属阴虚，如果迁延日久，阴损及阳，可见肾之阴阳两虚症状，在小便频数，尿如膏脂，甚则饮一溲一的同时，由于精微下注，无以充身泽肤，则兼见面色黧黑，耳轮焦干等证，此时应当滋阴温阳并进，兼用固摄精微之品，选用无比山药丸为主方。本方由山药、熟地、山茱萸、泽泻、茯苓、牛膝、杜仲、菟丝子、巴戟天、肉苁蓉、五味子、赤石脂组成，方中山药、熟地、山茱萸、五味子滋阴补肾；菟丝子、巴戟天、肉苁蓉助阳而不伤阴；赤石脂涩精固液。若加入金樱子、复盆子、桑螵蛸等味，补肾固涩之力更强。

有些消渴病人，在就医诊治时，往往是属病患日久，辗转多处，易医数人而不愈的患者，此时不仅三多症状孰主孰次不甚明显，单纯肾阴亏虚或阴阳两虚也不典型，此时若执意按上、中、下三消辨治，实属胶柱鼓瑟，死板呆滞，疗效多不满意。若以病理分型作为辨证标准，却合临床实际。常见类型一般分为阴虚气弱，脾肾两虚，阴虚阳亢等，这几种类型虽不能概括全貌，但实为临床所常见。对上述分型如略

加分析，即不难看出，阴虚是消渴证的基本病理变化。当然，其阴虚又有在肝、在脾、在肺、在肾之不同，但以阴虚气弱、脾肾两虚尤为多见，因此养阴益气、滋肾健脾为多用之治法，养阴益气每选天冬、麦冬、玉竹、沙参、生地、人参、黄芪、黄精、山药、山茱萸、桑螵蛸等药，滋肾健脾则以生地、熟地、天冬、枸杞、首乌、女贞子、五味子、山药、於术、人参、太子参、山茱萸、桑螵蛸为主，由以上药物可见，治疗消渴一证，施以益肾补脾摄精之味疗效显著，故实属必用之品。

肾阴虚消渴，如患病日久不愈，往往伴发雀盲、耳聋、疮疡、痈疽、肺癆、中风、水肿等病证，在主要治疗消渴的同时，也要顾及兼证。雀盲、耳聋多属肝肾精气不足，不能上承耳目所致，故治疗时可用杞菊地黄丸合羊肝丸滋补肝肾。疮疡、痈疽初起是属热毒伤营，治宜解毒凉营，用五味消毒饮；病久气营两虚，蕴毒成脓，治宜益气解毒，用黄芪六一散加银花、公英。若伴发肺癆、中风、水肿等证，其治疗可参考有关病证。

肾阴虚消渴的发病，虽主要与素体阴虚、房劳伤肾有关，但情志不遂，饮食失节，过服温燥药物也能化燥伤阴，酿成本病。故除用药物治疗外，要喜怒有节，避免过度精神紧张；进食量不宜过多，也禁用辛辣刺激之品，并配以蔬菜、豆类、瘦肉、鸡蛋等为宜；同时要节制性欲。上述注意事项和禁忌，看来属于“小事”，但若认真做好，确对病愈十分重要。

（九）遗精

肾阴虚遗精的主要脉证是，遗精频作，甚至滑精，兼见头昏目眩，耳鸣如蝉，腰酸足痿，骨内酸痛，夜热自汗，阳事

易举，舌红少津，脉象弦细带数。

上述脉症的病理关键是属真阴耗伤。由于虚火偏亢，内扰精室，故见遗精频作，甚至滑精，精气亏虚，不能上荣头面，濡润肾窍，故头暈目眩，耳鳴如蝉，肾主骨，腰乃肾之府，肾虚外府失荣，骨也失于滋养，故腰酸足痿，骨内酸痛，阴虚则生内热，相火易动，故夜热自汗，阴事易举，舌红少津，脉象弦细带数，均属肾阴亏虚，内热偏盛之象。

遗精一证，又有梦遗与滑精之分，有梦而精液外泄者，名曰“梦遗”，无梦而遗精，或清醒之时精液自出者，称为“滑精”，二者名称虽异，其发病机理实属相近。至于梦遗属阴虚，滑精为阳虚之说，并不尽然，临证之时应脉症相参，辨证为要，不可胶滞一说。有些成年未婚男子，或婚后夫妻久居两地而偶有一月遗泄一二次，次日并无不适者，属于生理性溢精，并非病态。

遗精一证有虚实之分，肾阴不足遗精属虚证的一个类型，补肾益阴是治疗本证的大法，在滋补肾阴的同时，应加入固精之品方能取效。然又当详辨热象之轻重，阴虚而热象轻者，补其阴则虚热自然潜降收敛；热象重者，是属相火妄动，则当另按阴虚火旺处理。本证的具体治法当是滋养肾阴，佐以固精，常用方剂为六味地黄丸合水陆二仙丹。六味丸功能滋阴补肾；水陆二仙丹由芡实、金樱子组成，方中用此二药填精止遗。若遗精频作，日久不愈者，可用金锁固精丸固肾摄精。如果遗精日久，病势增重，已成阴虚精亏者，方剂当选左归丸加减。施用本方可以滋肾水填肾精，阴精充足，肾气旺盛，精微得以固摄，遗泄之证可愈。原方之内如果同时加入女贞子、鱼鳔胶、羊肾、猪脊髓、五味子等养阴固摄精关

之味，疗效定会增强。

依据本证发生的原因，应当注意以下事项：生活要有规律，并应晚婚晚育，节制性欲，戒除手淫。注意精神调养，清心寡欲，排除杂念。禀赋不足者，除摄入富于营养的饮食外，也应避免脑力过用。参加适当的体力劳动和体育锻炼，以增强抗病能力。

（十）妊娠失音

妊娠失音，古称“子喑”，也叫妊娠音哑。是指妊娠末期出现声音嘶哑，发声不扬，或不能出声的一种病证。由于肺脉通会厌，肾脉挟舌本。肺主气，声音由气而发；肾藏精，精足则能化气，因此发声是与肺肾二脏有关，若是二者相比，与肾的关系更为密切。发声的根本在于肾之精气充足，上承于会厌，荣养舌本，鼓动喉咙而出声，所以前人对于“肺为声音之门，肾为声音之根”的认识，是颇有道理的。

本证的发生，主要责之肾阴不足，而肾阴不足又何以导致妊娠失音？少阴之脉上贯肝膈，入肺中，循喉咙，挟舌本。如果平素肾阴亏虚，孕后又需要阴血养胎，所以肾阴更虚，精气亏虚既不能上行荣养舌本、会厌，也不能鼓动喉咙、声道发声，因而出现失音。

肾虚妊娠失音多发生在怀孕八九月间，证见声音嘶哑，甚至不能出声，兼见头晕耳鸣，掌心灼热，咽喉干燥，或有颧红，心悸心烦，小便短赤，大便干燥，舌质红，苔花剥，脉细稍数。

本证出现上述症状的机理在于：妊娠耗伤阴精，冲任受损，下元亏虚，无津上承，舌本、喉咙失润，故音哑咽干；水亏则虚火偏旺，虚火上扰，故头晕、耳鸣、颧红，掌心灼

热，水不济火，心火偏亢，心神失养，故心悸心烦，溲黄便干，舌红苔剥，脉细稍数，均属阴精不足，津液亏少，内热偏盛之象。

由于妊娠失音的病理关键是肾阴虚，故其治疗当用滋肾益阴之法，常用方剂为六味地黄丸加味。临床具体运用时，每以六味丸合枸杞子、女贞子并进，意在增强滋阴补肾之力，肾阴充足可上荣舌本，精气旺盛可鼓动喉咙，由此声音自出，各证亦减。原方可加沙参、麦冬以生津润肺，滋水之上源，助喉咙发音。若在临近分娩之时，突然发生失音，而又无其它症状者，此系胞脉受阻，肾脉不通，真阴不能上承所致，一般无需治疗，待其分娩后，胞脉通，肾水上济舌本，则声音自出。

三、肾虚水泛

何谓肾虚水泛？顾名思义，肾虚水泛就是肾虚水湿泛滥的病证。详细地说，是指肾阳虚衰，水湿不得温化，泛滥肌肤所引起的以水肿为主要特征的病变。

肾虚水泛的形成，其根本原因在于肾阳衰微。肾阳所以出现亏损虚衰，多因平素体质虚弱，或者久病失于调养，渐至肾中阳气亏耗，命门火衰。因为肾主水液，与膀胱相表里，由于阳虚不能主水，膀胱气化不利，导致水液温化过度失常，不能化成尿液排出体外，而泛溢于肌肤。或变成痰饮，阻遏脾运，上犯心肺，从而出现一系列肾虚或肾本为虚，心肺标实的证候。

肾虚水泛，临床上可见到患者周身水肿，两下肢浮肿较

重，按之凹陷没指，甚至按之如泥，腰腹胀满，或腰痛酸重，小便短少，怯寒神疲，兼见心悸气短，喘咳痰鸣，动则喘甚。舌淡胖，苔薄白，脉沉细。

由于肾主水液，与膀胱相表里，如若肾中阳气虚衰，膀胱气化不利，水湿不能变成尿液排出体外，而是泛溢于肌肤，故小便短少，周身水肿，按之没指，甚至按之如泥；又因水湿沉重，性属阴邪，容易在低位停留，故两下肢浮肿较重；腰为肾之所居，肾虚则腰痛酸重，水湿停聚腰腹则见胀满。命火为阳气之根，元阳不足，不能温煦形体，故见畏冷怯寒；阳虚气弱，则见精神疲倦，气短不足以吸；水气不化，上凌于心，故心悸不安；水气犯肺，则喘咳痰鸣，动则喘甚。舌淡体胖，舌苔薄白，脉象沉细，均属阳气不足之象。

诊断肾虚水泛，应具备下述几点：一般多有肾阳虚衰，命火不足，化气利水功能减低的慢性病史，或反复发作的病变过程。由于肾居腰脊，故其病位在腰部及与肾有关的体表部位。病变的根本是肾阳不足，进而化水不利，形成水湿泛溢，故其病性属虚，间有本虚标实之特点。

依照上述有关本病的病机分析，其治疗宜用温阳化气利水之法，常用方剂有济生肾气丸、真武汤等。阳虚水泛常见有水肿、心悸等病证。

（一）水肿

水肿，又称“水气”或“水病”，是指体内水液停留，面目、四肢、胸腹甚至全身浮肿的一种病证。水肿的发生与肺、脾、肾三脏关系甚为密切。体内水液的代谢，主要依靠肺气的通调下降，脾气的运化转输和肾气的开阖蒸化，如其中某一脏功能失常，都能导致水不化气，致水液停留发生水肿。

肾虚水泛所致的水肿，主要责之肾阳虚弱，兼及脾阳不足，这类水肿应归为《丹溪心法》所称“阴水”之列，或《金匱要略》所言“正水”、“石水”之属。

肾虚水泛所致水肿的主要脉症是，颜面虚浮，胸腹四肢皆肿，尤以腰以下为甚，按之凹陷不起，甚至如按烂泥，阴部湿冷，腰部冷痛酸重，尿量减少，兼见心悸气促，四肢逆冷，怯寒神疲，面色晦滞或晄白，舌体胖大，质淡苔白，脉沉细或沉迟。

肾虚所以形成水肿及一系列兼证，是因肾主化气利水，今肾之阳气虚衰，水湿不化，泛溢肌肤，故面浮，胸腹及四肢皆肿。腰膝以下肾气主之，肾阳衰微，阴盛于下，故腰以下水肿为甚，按之凹陷不起，甚至如按烂泥，阴部湿冷；腰为肾之府，肾虚水气内盛，故腰部冷痛酸重；州都之官功能化气利水，皆赖肾阳所主，肾气虚弱，膀胱气化不利，故尿量减少；水湿内停，气逆上犯心肺，故心悸气促；肾阳不足，命门火衰，不能温养肢体，四肢逆冷，怯寒神疲自然可见。阳虚不能温煦于上，故面色晦滞或晄白。舌体胖大，质淡苔白，脉沉细或沉迟，均属肾阳衰微，水湿内盛之象。

肾虚水泛所成水肿，应与脾阳虚水肿及臌胀水肿作出鉴别，脾阳虚多由脾气虚发展而来，除眼睑或全身浮肿外，是以面色萎黄、疲倦肢冷、食少便溏等脾阳虚弱症状为特点，而无阴部湿冷、腰部冷痛、面色晄白等阳虚水泛之证。臌胀一证是以腹部胀大、皮色苍黄、脉络显露为特征，其胀惟在腹部，而肢体无恙。肾阳虚水湿泛溢水肿，主要表现为面部、两足浮肿，甚则水肿遍及全身，少见单腹胀大、脉络显露之症状。

本证当以温肾助阳，化气行水为其治法，代表方剂为真武汤。本方由附子、生姜、白术、茯苓、芍药等味组成。附子为本方主药，功能温肾助阳，肾中阳气充盛，停留之寒水得化，故小便通利，水肿渐自消退；白术、茯苓健脾行水，生姜温散水气。三药且助附子利水消肿；白芍酸寒和调营阴，亦防附子温燥太过。如虚寒较甚，可于原方加入葫芦巴、巴戟天、肉桂温补肾阳，以助气化。如心悸，唇舌青紫，脉象虚数，则应重用附子，同时加入桂枝、甘草、红花、丹参，以温补心阳，化除瘀浊。如喘息自汗，不得宁卧，是属水邪犯肺，气不潜纳于肾，可加入人参、五味子、山茱萸、生牡蛎，以防喘脱之变，如水肿未消，而见神情呆顿，蹇卧嗜睡，恶心欲吐，甚则口有尿味，可在主方中加入大黄、黄连、半夏以解毒降浊，或合用温脾汤化浊降逆。如原病未愈，复感外邪，肿势增重，恶寒无汗，原方宜减白芍，暂加麻黄、细辛、甘草等药，以温经散寒，驱除外邪，客邪表解之后，再议治疗水肿。

水肿发病后，应注意忌盐，这一认识由来已久，早在唐代孙思邈《千金方》就有记载，此后历代相传，临床医家对此颇为重视。盐味咸，咸入肾，过咸则伤肾。今肾已虚，若再摄入咸味太过，则犯虚虚之禁，定会加重病情。此外，水肿往往损及脾胃，后天有伤，腐熟、运化水谷皆受影响。脾胃受损，气血化源不足，病变难愈，故应摄入既不伤脾胃，又富于营养的食物。同时也应注重精神调养和寒温适宜，这些都是治疗水肿不可缺少的辅助方法。

（二）心悸

心悸是指患者不因惊吓而自觉心中悸动不安的病证。本

症一般多呈阵发性，每因情绪波动或劳累过度而发作。本病的发生，除与精神因素、心经气血不足、水饮内停、瘀血痰火有关外，肾虚水泛，上凌于心，导致的心悸也属常见。

肾虚水泛所致心悸的主要脉症是，在心中悸动不安的同时，兼见咳喘，喘甚时则不能平卧，且小便不利，四肢及头面浮肿，舌胖质淡，苔薄白或水滑，脉象弦滑。

由于肾中阳气不足，命门相火虚衰，不能制化水液，水气上逆凌心而成。水气凌心的同时亦上犯于肺，肺失肃降，因此兼见咳嗽气喘，喘甚不能平卧；肾虚无力助膀胱化气利水，故小便不利；水湿不能通过小便排出体外，泛滥四肢、头面肌肤，因而发生水肿；舌脉均属肾阳虚衰，水湿不化之征。

肾阳衰微，水气凌心之心悸，当治以温阳利水。所谓温阳，是指用温热的药物补益肾阳，肾阳充足则能助膀胱化气利水，使水湿从小便排出，水气得出不再上凌辱心，则心悸可止。这种治法常形容为“如离照当空，则阴霾自散”。常用方剂以真武汤加减为宜，用此方之意在于以附子温壮肾阳，肾阳不虚，内停水湿之气自然得化，茯苓、白术健脾利湿，导水下行。生姜温散水气。芍药敛阴和阳。水气去除，无邪凌心犯肺，则由此所致的心悸、咳喘、浮肿等证亦可减轻。如果患病日久，肾阳久虚不复，心悸反复发作，且兼见头晕目眩，耳聋耳鸣，腰酸遗精，精神疲倦等证，此为阳损及阴，阴虚不能恋阳，虚阳扰动所致。此证在治疗时，当补阳滋阴并进，且应兼利小便，可选用济生肾气丸合大补元煎加减。前方由附子、肉桂、地黄、山药、山茱萸、茯苓、丹

度、泽泻、牛膝、车前子组成，后方原方有地黄、山药、山茱萸、枸杞子、人参、当归、甘草等药。方中地黄、山药、山茱萸、杜仲、枸杞、牛膝、附子、肉桂扶元阳，滋阴液，阴阳并补，两虚得复，阴能恋阳，虚阳内敛，病可遂愈。茯苓、泽泻、车前子等利小便除水气，可使头面、四肢水肿慢慢消退。

四、肾不纳气

祖国医学认为肾主“纳气”，所谓肾主纳气，是指肾有摄纳肺气以助肺司呼吸的功能。如果肾中阳气虚弱，不能摄纳肺气，则称为肾不纳气。

人体的呼吸虽然由肺所主，但吸入之气必须下纳于肾，才能保持气机升降如常和呼吸出入均匀。肾的纳气功能，主要是肾中阳气的作用。如果禀赋薄弱，肾气亏虚，劳欲过度，肾气不足，久病不复，损伤肾气，高年体弱之人，未作及时调补，肾中阳气亦虚。无阳不足，摄纳无权，气不得下纳而上浮，从而形成肾不纳气的病证。

肾不纳气可见短气喘逆，动则喘甚，咳逆汗出，小便常因咳嗽而失禁，面浮色白，舌淡苔薄，脉虚弱。上述脉症主要是因肾气被伤，虚衰不足，失其摄纳之职，气不下归所引起。

诊断肾不纳气，一般应有损伤肾气的病史，其病位虽在下焦肾脏，但上焦肺气不降的短气喘逆，动则汗出、气喘加重的症状，也属必见；本病证病性属虚，间或有实证也是本虚标实之证。

由于本病为肾虚，故应治以补肾纳气之法，代表方剂为人参胡桃汤或参蚬散之类。临床施治时，每于上方之内加入熟地、补骨脂、五味子等味，以助原方补肾纳气之功。

肾不纳气以短气喘促之证比较多见。

肾不纳气所致喘证，多见喘促日久的患者，临床表现为气短气喘，呼多吸少，动则喘息更甚，气不得续，肢冷汗出，兼见咳嗽气逆，咳甚小便失禁，神怯腰酸，夜尿频多，面浮色白。舌淡苔薄，脉沉细或虚浮无根。

由于喘促日久，病深及肾，肾虚下元不固，气失摄纳，不能归根，故气短气喘，呼多吸少，夜尿频多，“劳则气耗”，因此稍加活动，则喘息更甚，气不得续，肾阳虚衰，一则卫外之阳难固，另则不能温养肢体，故汗出肢冷；肾虚日久，肺气不足，故咳嗽气逆，咳久伤肾，小便失其约束，故咳甚小便失禁；阳虚不能温化水湿，水液蓄留，故面浮色白；舌淡苔薄，脉沉细或虚浮无根，均属肾阳虚衰之象。

治疗肾不纳气的喘证，当用补肾纳气之法，常用方剂为《济生方》人参胡桃汤与《验方》参蚬散合方加减。方中人参补益肺气，胡桃肉、蛤蚧可纳气归肾。另可加入补骨脂、五味子助阳以纳气。各药共投，肾气下纳归根，短气喘促之证可日渐平复。如果证见形瘦神疲，肢冷面青甚剧者，其治应以《金匱》肾气丸为主方。方中六味丸补益肾阴，桂附温肾助阳，令阳归于阴，肾气得以摄纳固藏，则喘息可平。若在肾虚喘促气短的同时，兼见咽干口渴，舌红脉细，此为阴不敛阳，气不摄纳之故，可施以七味都气丸合生脉散，以滋阴纳气平喘，而不宜选用辛燥劫阴之品。

五、肾气不充

肾气，即肾精化生之气，是指能够促进人体生长、发育及性机能活动的肾脏功能而言。肾气不充，就是肾脏这种功能虚弱不足的表现。肾气不充是怎样引起的呢？究其原委，起因不一，或系先天不足，禀赋薄弱；或因体弱年高，肾气素虚；或由精血不旺，无以化气；或是多产房劳，冲任受损。由于肾气是由肾精所化生，如果肾精不足，化气无源，即“阴虚阳无以化”，便可形成肾气不充。阴精化为肾气，其动力乃为下焦元阳。若肾阳不足，命火虚衰，化气无力，也可导致肾气不充。由上可见，肾精不足、肾阳虚衰与肾气不充均有密切关系，即肾精、肾阳任何一个方面出现亏虚衰弱，都可引起肾气不充。

肾气不充可见小便排出不畅或点滴不爽，月经周期紊乱、经来或先或后、量少色红，带下清冷稀薄、量多、淋漓不断，妊娠早期阴道下血、胎动不安、产后小便不通、尿意频数、甚至小便失禁，阴道有物脱出，小腹下坠等证，兼见腰酸膝软，头晕耳鸣，畏寒肢冷，小便频数。舌质偏淡，脉沉细无力。

上述脉症的形成，是因肾气不充，阳气不足，化气无力，故小便排出不畅或点滴不爽，肾气虚弱，闭藏失职，冲任逆乱，血海蓄溢失常，故月经周期紊乱，经来或先或后，量少色红；肾中阳气不充，带脉约束无力，任脉不得强固，故带下清冷，质稀量多；肾虚冲任不固，胎失所系，故妊娠早期阴道下血，甚则胎动不安；产后肾气虚衰，无力助膀胱气

化，故小便不通，尿意频数，甚至小便失禁；肾气不充，冲任不固，带脉失约，故阴道有物脱出，小腹下坠；腰为肾之府，肾气不充，故腰酸膝软；肾虚髓亏，耳窍失于充养，故头晕耳鸣；阳虚不能温煦于外，故畏寒肢冷；肾虚不固，则小便频数。舌淡，脉沉细，均系肾中精气不充之象。

诊断肾气不充，应以禀赋不足、高年体弱、多产劳伤等损伤肾气的病史，肾脏所居的部位和病性属虚为主要依据。治疗此类病证宜用补肾益气或温养肾气为大法，常用药物有附子、肉桂、巴戟天、补骨脂、鹿茸、熟地、杜仲、牛膝、枸杞子、菟丝子、当归、山药等，常用方剂为济生肾气丸、《金匱》肾气丸、内补丸、补肾固气丸、大补元煎等。

肾气不充常见有癃闭、带下、胎漏、产后排尿异常及阴挺下脱等病证。

（一）癃闭

肾气不充癃闭的主要脉症是，小便排出时不甚通畅，或排出无力，点滴不爽，兼见面色㿔白，神气怯弱，腰部有冷感，腿膝酸软无力。舌质偏淡，脉沉细无力，两尺脉尤弱。

肾主水液代谢，其基本过程是升清降浊，这一过程是依靠肾中阳气具有的“气化”作用来完成的。由于肾气不充，阳气不足，气化无力，故小便排出不畅或点滴不爽；肾气虚惫，故面色㿔白，神气怯弱，腰部有冷感，腿膝无力，脉细尺弱，均属命门火衰，阳气虚弱的表现。

小便排出不畅之癃闭，穷及本源在于肾中阳气不足，膀胱气化无力，故本证的治疗当施温补肾中阳气之法，方属恰中病机。肾气充盛，州都之官气化正常，膀胱所藏尿液顺利排出，癃闭之证可获痊愈。温补肾气常用代表方剂为济生肾

气丸加减，本方由桂附八味丸加牛膝、车前子组成。方中肉桂、附子可温壮下焦元阳、鼓舞肾气，故为本方的主药。六味丸功能补肾滋阴，与温肾助阳药同用，其意正如《景岳全书·新方八略》所说：“善补阳者，必于阴中求阳，则阳得阴助而生化无穷”。另有牛膝、车前子可利水泄浊。如属元气大虚，肾督不振之躯，亦可加入人参、鹿角片、仙茅、淫羊藿等大补元气以壮阳，更有助于治疗肾气不充的小便不利证。

（二）带下

“带下”之名首见《内经》，其含义有广义、狭义之分。广义带下，是泛指妇科的经、带、胎、产疾病而言，因这些疾病都发生在束带以下部位，《史记·扁鹊仓公列传》称妇科医生为带下医。狭义带下，是指妇女阴道内流出的一种粘稠液体，如涕如唾，绵绵不断，通常称为白带。在平时，女子的阴道有少量白带排出，是生理现象。在发育成熟后，或经期前后，或妊娠初期，白带量可较平时增加，也不属病态。如果带下量多、或色、质、气、味发生变化，或伴有全身症状者，则属病理改变，称为“带下病”。狭义带下是本证讨论的重点。

带下的产生，除脾虚、湿毒等原因外，由于肾气不充，下元亏损所致者临床上亦不少见。带脉在生理上能约束纵行的各条经脉，围腰一周，有如束带，与任脉共为肾经所主。如果肾虚下元亏损，或房劳伤及肾气，使带脉失去约束之力，任脉也不得强固，导致带下为患。

肾虚带下的主要脉症是，带下清冷，质稀薄，量多，终日淋漓不断，腰脊酸楚，小腹有冷感，兼见小便频数清长，夜晚尤甚，大便清薄。舌质淡，苔薄白，脉沉迟。

由于肾中阳气不充，下元虚冷，带脉失于温养，固摄无权，故带下清冷，质稀量多，淋漓不断；肾虚外府失荣，故腰脊酸楚；肾气亏损，命门火衰，气不化水，火不生土，故小腹有冷感，小便清长，大便溏薄。舌质淡，苔薄白，脉沉迟，均属肾中阳气不充之征。

治疗肾气不充的带下证，宜用温肾培元，固涩止带之法，代表方剂为《女科撮要》所载内补丸。本方由鹿茸、附子、肉桂、肉苁蓉、菟丝子、沙苑蒺藜、紫菀茸、桑螵蛸等药组成，方中鹿茸、肉苁蓉温肾阳，填精髓；附子、肉桂温命门，补真火；菟丝子、沙苑蒺藜补肝肾，固任脉；紫菀茸温肺益肾；桑螵蛸收涩固精。全方合施具有温肾壮阳，益精固涩之功，故治疗本证可获满意效果。

(三) 胎漏

胎漏，亦称“漏胎”或“胞漏”，又名胎前漏红。是指怀孕后阴道不时少量下血，或时下时止，或淋漓不断，但无腰酸、腹痛、小腹坠胀等症状。如果胎漏继续发展，孕妇先感胎动下坠，继而有轻微的腰酸腹胀，或阴道有少许出血者，则称为“胎动不安”。胎漏、胎动不安进一步发展，怀孕在三个月以内，胎儿尚未成形而坠者，称为“堕胎”；在三个月以后，胎儿已成形而坠者，则称“小产”。如果在堕胎或小产之后，下次受孕仍如期而坠，或屡孕屡坠达三次以上者，名为“滑胎”，今称“习惯性流产”。胎漏、胎动不安与堕胎、小产是同一疾病的不同发展阶段。就临床所见，如在本病初期的胎漏阶段，能得到及时正确的治疗，不仅胎漏可愈，也可有效地防止胎动不安、堕胎和小产的发生。

胎漏引发的原因，一般常见有气血虚弱，血分偏热，跌

仆损伤和肾气虚弱。由于冲为血海，任主胞胎，若肾气充盛，则冲任之气强固，胎有所载，血有所养，胎元便可正常生长发育。如果先天肾气不充，或孕后不节房事，或屡次坠胎、小产，数伤肾气，肾虚则冲任不固，胎失所系，形成胎漏，因此肾气不充是胎漏的重要原因。

肾气不充所致胎漏的主要脉症是：妊娠早期阴道下血，或时下时止，或淋漓不断，腰酸腹坠，头晕耳鸣，小便频数，甚至失禁，或见胎动不安。舌淡苔白，脉沉细弱。由于胞脉系于肾，肾虚则冲任不固，胎失所养，因而胎动不安，腰酸腹坠、阴道下血；肾虚髓海不足，脑失所养，故头晕耳鸣；肾与膀胱相表里，肾虚膀胱失约，因而小便频数，甚至失禁。

治疗肾虚胎漏，宜用固肾安胎之法，常用方剂为《医学衷中参西录》寿胎丸加味。本方由桑寄生、续断、菟丝子、阿胶等四味药物组成，方中菟丝子补益肾精，寄生、续断固肾强腰以系胎，阿胶养血固胎。通过上方治疗，肾气充盛，冲任固摄，胎元自安，则无漏血坠胎之虞。如果胎漏失治误治，形成滑胎者，宜在未孕之前，用验方补肾固冲丸进行调治。此方药味如下：菟丝子、续断、阿胶、鹿角霜、巴戟天、杜仲、枸杞、当归、党参、白术、砂仁、熟地、大枣，蜜制为丸，每丸6克。全方共成补肾固冲益气养血之功，每日服3次，每次服1丸，两月为一疗程，服用一至三个疗程，当见卓效。本丸剂在经期期间或患外感之时，应当停服。

（四）产后排尿异常

孕妇分娩后，出现小便不通，或尿意频数，甚至小便失禁的证候，称为“产后排尿异常”。尿液不能从膀胱顺利排出，其原因或因膀胱本身患病，如湿热壅积或砂石肿块阻塞尿路；

或因肺气不足，失于通调下降，或肾气不充，不能助膀胱气化。元气素虚之人，加之产时复伤气血，往往引起肾气不充。

肾虚膀胱气化功能不利所致产后排尿异常，临床实属常见。故此由于命门火衰，影响膀胱气化引起的产后小便不通，小腹胀满而痛是本证的主要临床表现，兼见的腰膝酸软，面色晦黯，畏寒肢冷，舌淡苔润，脉沉细而迟，亦均为肾阳不足之征象。

肾中阳气不充，化气行水不利的小便排出不畅，温补肾阳，化气行水为其治疗大法，常用方剂为《金匱》肾气丸。如果证以小便频数或失禁为主者，则应在肾气丸为主方的基础上，加入桑螵蛸、复盆子、补骨脂，以温肾固涩。肾气充盛，排尿异常之证可以治愈。

（五）阴挺下脱

阴挺下脱，也称“阴菌”、“阴脱”或“子肠不收”，是指妇女阴中有物下坠，或突出阴道口外的病证。因其多发生在产后，又叫“产肠不收”。阴挺下脱证，每因中气不足，气虚下陷所引起；或因孕育过多，房劳肾伤，肾气不充，冲任不固，带脉失约所导致。

肾气不充之阴挺下脱，以阴中有物脱出，小腹下坠为主要见证。因其肾亏精虚，膀胱气化失司，所以常常兼见腰酸腿软，头晕耳鸣，夜尿频多。舌淡红，脉沉弱。

治疗肾虚阴挺下脱，应用补肾益气之法，常用方药为大补元煎加鹿角胶、紫河车、升麻。大补元煎由地黄、山药、山茱萸、枸杞子、人参、杜仲、当归、甘草组成。方用杜仲、山茱萸、枸杞子补益肝肾，鹿角胶、紫河车温润填精，人参、

升麻补气升提，当归、熟地养血滋阴。如果元气不足，命门火衰而寒象明显者，可酌加附子、肉桂、炮姜等温肾助阳。肾气充盛，温暖脾土，脾气升举，阴挺下脱之证多可逐渐复原。除药物治疗外，针刺维胞穴（关元旁开6寸，进针后大幅度捻转，病人即有子宫收缩感），或子宫穴（脐前上脘与耻骨结节连接线中点向内一横指，进针后向耻骨联合方向斜刺，深度以病人感到阴部发酸上抽为止），或以三阴交为主穴，长强、百会、阴陵泉为配穴（同时用艾灸百会穴），也可获得疗效。此外，有些单方煎水熏洗也可取效。

六、肾 精 不 足

《灵枢·本神》篇说：“肾藏精”。肾脏所藏阴精即是肾精。它的基础是先天之精，又必须依靠后天之精不断充养，才能持久地发挥其濡润滋养的作用。精能化气，肾精所化之气，即为肾气。精气是人体生命活动的源泉，并有促进生长发育和繁衍生殖等重要功能。肾精所以能够发挥其功能是和肾气分不开的，因此对于“肾精”这一概念，常以“肾之精气”一词相互替用，这表明两者之间有着难以截然分开的密切关系，如果肾中纳藏寓寄的阴精亏损虚弱，即是肾精不足。

肾精不足多因禀赋薄弱，早婚多育，房室不节，劳欲伤肾，年高体弱，久病失养而成。又因肾开窍于耳，腰为肾府，齿为骨之所余等生理功能和特性，一旦肾精亏损，便能出现一系列病证。

肾之精气不足的主要脉症是，头晕耳鸣，听力减弱，甚

至耳聾，腰酸腰痛，膝軟足痿，健忘失眠，思維遲鈍，牙齒鬆動，牙根酸痛，語言不利，須髮早白，遺精帶下，經量過少，孕期失音，舌質嫩紅無苔，或淡紅，或有裂紋，脈沉細或細弱無力。

上述脈症主要是由腎精虧虛所引起。因腎藏精，生髓（髓居骨中，¹滋養骨骼），腦為髓海，腎虛藏精不足，無以生髓，髓海空虛，故頭暈目眩，記憶減退，思維遲鈍；耳為腎之外竅，腎精不足，竅失充養，故耳中鳴响，聽力減弱，甚至耳聾；腰為腎之府，腎精虛外府失榮，故腰酸腰痛，膝軟足痿；陰精虧虛不能與心相濟，虛火內生，心神被擾而失眠；精虛腎虧不能生骨，故牙齒鬆動，牙根酸痛；腎脈行舌下挾舌本，腎虛精失上承，故語言不利；精生胡須，髮為血之余，又精血相生，腎精不足，血亦虧虛，故經量過少，胡須乏精滋養而早白；腎為封藏之本，亦主帶脈，腎虧精關不固，帶脈失約，故遺精帶下；沖為血海，任主胞胎，沖任乃腎脈所系，胎元賴腎精滋養，腎精不足，加之胎元耗精，精虧無以上濡喉嚨，故孕期失音，舌質嫩紅無苔，或舌質偏淡而有裂紋，脈沉細，或細弱無力，均屬腎精虧虛之象。

腎精不足多是由于各種致病因素傷及腎臟陰精，逐漸耗損而成，故患者每有先天不足，久病不愈及慢性消耗性病史可尋，如虛勞、肺癆、眩暈、腰痛等。病因多與早婚多育，誤犯手淫，恣情縱欲，房室不節等直接耗傷腎精有關。病變部位多在腰脊膝足、頭顱耳齒、前陰以及腎臟所處之下焦，與其相關的体表器官。病性皆屬於虛，間或可見因陰虛引起的陽亢或虛火。

對於腎精不足之證，多用補腎填精之法，施以左歸丸、

左归饮、地黄饮子、首乌延寿丹、当归地黄饮、耳聋左慈丸等进行治疗。上述方剂可使肾精充盈，精气旺盛，精神体力逐渐恢复，因而各证可愈或减轻。

肾精不足常见有眩晕、中风后遗语言不利、耳鸣耳聋、腰痛、头痛、阳痿、须发早白、虚劳、月经过少、崩漏、绝经前后诸症、不孕证等。

(一) 眩晕

肾精不足所致眩晕的主要脉症是，头目眩晕，精神萎靡，腰膝酸软，记忆减退，两耳鸣响，发落齿摇，或遗精滑泄，舌瘦嫩或嫩红，少苔或无苔，脉弦细或细弱。或兼见咽干，头痛颧红，五心烦热，舌嫩红，苔少或光剥，脉细数。或兼见面色苍白或黧黑，形寒畏冷，四肢不温，小便频多，舌淡嫩，苔白或根部有浊腻苔，脉弱两尺尤甚。

上述脉症的出现总由肾精不足所致。精亏则无以生髓养脑，故头目眩晕，精神萎靡，记忆减退；肾主骨，腰为肾之府，齿为骨之余，肾虚骨失充养，故腰膝酸软，牙齿动摇；肾开窍于耳，肾精虚少，故两耳鸣响；肾之华在发，肾精亏虚，故发易脱落；肾虚封藏固摄失职，故遗精滑泄；肾精不足，阴不维阳，虚热内生，故咽干颧红，五心烦热，舌嫩红，苔少或光剥，脉细数；精虚无以化气，肾气不足，日久真阳亦衰，故见面色苍白或黧黑，形寒肢冷，舌淡嫩，苔白或根部有浊腻苔，脉弱尺甚。

肾虚精亏之眩晕应与下述病证或证型进行鉴别：气血亏虚所致眩晕也属虚性眩晕，其特点是动则眩晕加重，劳累即发，兼见神疲懒言，气短声低，面色少华或萎黄，或心悸失眠，腹胀便溏，舌淡等气血两虚症状。而本证眩晕则兼见精神

倦怠，腰膝酸软，善忘遗精，耳鸣等肾精不足，髓海空虚，不能化气生神等症状，二者有明显区别。中风证风邪入中经络，肝肾亏虚，风阳上扰者亦见眩晕。其特点是平时头晕、头痛并见，耳鸣目眩，腰酸软弱，并可突见一侧手足沉重麻木，口眼歪斜，半身不遂，语言不利等症状。而本证眩晕也偶见头痛，但以头晕为重，不伴见喎僻不遂、语言蹇涩等症状。

肾虚眩晕的关键是肾之精气不足，其治疗应本着“精不足者，补之以味”的原则，取滋填肾精为其大法。由于肾精不足又有阴虚阳亢、虚热内生与精虚无以化气、肾气亏虚两种病机。故在补益肾精为主的同时，又要视其偏于阴虚还是偏于阳虚，随证加入补肾滋阴或补肾助阳之品，以求阳得阴助，阴得阳升，精源不竭，生化无穷的最佳疗效。本证的具体治法是补益肾精，充填脑髓。常用方剂为河车大造丸或左归丸，前方由紫河车、龟版、杜仲、牛膝、熟地、天冬、麦冬、党参、茯苓等组成，后方原有熟地、山茱萸、山药、枸杞子、菟丝子、龟版胶、鹿角胶、牛膝、茯苓等味。方用紫河车、熟地、龟版胶、鹿角胶、枸杞子、菟丝子、山药、山茱萸补肾益精填髓，党参、茯苓、牛膝、杜仲、天冬、麦冬益气滋阴，补复真元。若偏于阴虚者，可在原方内加入女贞子、知母等药滋肾阴，清虚热；偏于阳虚者，可合施右归丸，用桂附益火助阳。然桂附二药毕竟辛热温燥，而病的本质又属精虚，故短期可用，久服不宜。如果改用巴戟天、肉苁蓉等温润之品，令其助阳而不伤阴，甚为恰当。如果眩晕甚重，在补肾治本的同时，可选加龙骨、牡蛎、磁石、珍珠母等潜镇浮阳，减轻症状。若遗精频作者，可另加莲须、芡实、桑

蛭、沙苑蒺藜、金樱子等，以固肾涩精。

肾精不足所致眩晕经治好转后，可根据辨证，选用六味地黄丸等药长期服用，以固其根本。并应调摄精神，避免过劳，节制房事，以防疾病复发。

(二) 中风

中风病在脏腑，由于风火阳动，气血上逆，挟痰挟瘀，流窜经络，蒙蔽清窍，出现卒然仆倒，不省人事的表现。经过救治多数患者神志虽可清醒，但往往留有半身不遂，口眼喎斜，语言不利等后遗症状。特别是失语或语言蹇涩等后遗症，虽不至危及生命，但由于短期内难以恢复，病人不仅因为不能对他人进行正常的语言交流深感不便，而且也会觉得有口难言或语音不清而感到极大痛苦。有些患者可由此出现性情急躁，悲怒不止等性格变化，从而可能导致中风的再次发病，所以积极治疗语言不利，有着极为重要的意义。

中风后所遗语言不利，有风痰阻络和肾精不足之分。后者是因肾虚精亏，精气不能上荣喉咙、滋养舌本而成。其临床表现除舌欠灵活，语言不清，或舌暗不濡，舌体偏斜等主证外，尚兼腰膝酸软，头晕耳鸣，心悸气短等肾虚精亏，虚火内扰之证。对于肾虚语言不利的治疗，宜用补肾填精，开音利窍之法，选《宣明论》地黄饮子为主方。本方由干地黄、山茱萸、石斛、麦冬、五味子、菖蒲、茯苓、远志、肉苁蓉、巴戟天、肉桂、附子等药组成。方中干地黄、山茱萸、巴戟天、肉苁蓉补益肾中精气，石斛、麦冬、五味子养液滋肾填精，菖蒲、远志、茯苓化痰利窍开音，原方减去桂附不用，以防辛热药物耗夺真阴。另可加入桔梗、杏仁、木蝴蝶等，以增强开音利窍之力。施用上方可滋养肾精，精气充盛能濡

润喉咙、舌本，故语言不利之证可逐渐恢复，辅用利窍开音之味，又可助主药使语音变清。

(三) 耳鸣、耳聋

肾虚耳鸣的特点，历代医籍都以声如蝉鸣来描绘，但从临床所见病例来看，这一自觉症状并不完全相同。有的将其比喻为蚊虫在耳边飞叫萦绕，也有的形容为酷似飞机尖叫掠过之声，当然更多的是以声如蝉鸣来形容。与此同时，兼见头晕目眩，失眠健忘，腰脊酸软，遗精滑舌质红，脉细弱。至于肾虚耳聋，其失聪程度也有轻有重，轻者听力减退，低声对话听不真切，声音略高即可听清；重者则听觉丧失，不能闻及外声。此外，耳鸣、耳聋也与起病新久有关，新病初起病情较轻，日久不愈可由轻变重。

耳鸣、耳聋由肾精亏虚失于滋养引起者，其治疗宜用滋阴潜阳，补肾益精之法，以耳聋左慈丸为主方。本方由地黄、山药、山茱萸、茯苓、丹皮、泽泻、五味子、磁石、菖蒲组成，前六味药物系六味丸的成分，功能滋补肾阴；加入五味子，名曰七味都气丸，更可滋肾固精；磁石、菖蒲功能益肾养阴，通窍聪耳。因此该方是治疗肾虚耳鸣、耳聋的理想方剂。不过应该指出，高年长者所患耳聋，多属年深日久，逐渐形成，究其病机亦由精血虚衰所致，虽施以填精补血之方，也难以恢复听力。

(四) 腰痛

肾精不足腰痛以酸软疼痛为特点，喜揉喜按，腿膝无力，卧则减轻，遇劳更甚，常反复发作，兼见心烦失眠，口燥咽干，手足心热，面色潮红。舌质红，脉弦细而数。

上述脉症的机理在于：腰为肾府，肾主骨生髓，肾精亏

虚，骨髓不充，故腰痛酸软，腿膝无力，病属虚证，故喜揉喜按；劳则气耗，故卧则减轻，遇劳更甚；阴虚则津液不足，虚火上炎，故心烦失眠，口燥咽干，手足心热。舌质红，脉弦细而数，均为阴虚有热之象。

肾精不足腰痛应与下述病证或证型作出鉴别：肾虚腰痛虽以痛而酸软、腰膝无力、过劳尤甚为特点，但有偏于阴虚、阳虚之不同。偏于阳虚者，兼见少腹拘急，手足不温，面色苍白，舌淡，脉沉细等阳虚有寒之脉证；偏于阴虚者，兼见心烦失眠，手足心热，口干咽燥，舌红，脉弦细而数等阴津不足，虚火内炽之脉症，二者症状迥然有异，易于辨别。

有些患者是以腰酸为主证来就诊，所谓腰酸，是指腰部酸楚不舒而言。在临床上腰痛常兼见腰酸，但腰酸并不一定兼见腰痛，二者的病机虽然均与肾虚有密切关系，但症状表现有差异。

《金匱要略》所载“肾着”一病也见腰痛，其特点是腰中冷，腰以下痛，身重，腹重，其病机是外感寒湿侵入腰部经脉，属肾之外府患病。而肾虚腰痛则以酸软为主，其病机是肾中精亏致外府失养，属肾之本脏不足。

外伤腰痛，多与瘀血有关，其痛犹如锥刺，痛处固定不移，这与肾虚腰痛不仅症状差别很大，而且有外伤病史可寻，故二者不难进行鉴别。

腰痛一证，可分外感、内伤两大类，其病位在腰部，病性则有虚实寒热之分。肾精亏虚腰痛，是属内伤虚证，其治疗当遵“虚者补之”之原则，以“精不足者，补之以味”为大法。具体治法是以滋肾益阴为主，常用方剂为当归地黄

饮加。原方由熟地、山茱萸、山药、杜仲、牛膝、当归组成，方用熟地、山茱萸、山药补肾益阴；杜仲、牛膝强健腰膝；配当归补血行血，以疏通肾气（张景岳补肾诸方中常加当归）。若肾精亏虚甚重，则可合用左归丸，即在前方基础上加枸杞子、龟版胶、鹿角胶、菟丝子，其中枸杞子、龟版胶可增强原方滋补肾阴之力。由于肾阴不足的同时常见肾阳也虚，故同时加入鹿角胶、菟丝子等温阳之味亦很相宜。此外，如系一般腰痛，其肾阴、肾阳亏虚均不明显者，可用补骨脂、杜仲、胡桃肉三味药物组成的青娥丸，达到治疗目的。

（五）头痛

肾精不足头痛属内伤头痛范畴，其所以发病，是因禀赋不足，房劳过度，耗损肾精，精不生髓，髓海空虚而成。

肾精亏虚头痛的主要脉症是，头脑空痛，兼见眩晕耳鸣，腰膝酸软，五心烦热，遗精带下，舌红，脉细。由于肾虚精髓不足，脑失充养，髓海空虚，故头脑空痛，且兼眩晕，耳者肾之外窍，肾精亏虚，耳失滋养，故耳中鸣响；肾虚外府失荣，故腰膝酸软，精关不固，故精液遗泄；女子带脉失于约束，故白带下注；五心烦热，舌红，脉细，均属肾精亏虚之象。

肾阳衰微与肾阴不足所致肝阳上扰均可出现头痛，因此须与本证作出鉴别：肾阳不足，命门火衰，进而寒从内生，清阳失运而头痛，其特点也可见头痛且空，腰膝酸软，但因其阳虚生外寒，故兼见畏寒肢冷，苔薄，脉沉细无力，而不兼见五心烦热，舌红等阴精不足的症状。肝肾同源，肾之阴精不足，水不涵木，致肝阳上扰清空之头痛，是以头痛而

眩，心烦易怒，面红耳赤等肝阳头痛的特点为主，然其脉象不呈弦而有力，而是阴虚阳亢的弦细带数。

肾精不足头痛是属虚证，一般表现为病程长，病势缓，时发时止，劳欲过度则疼痛加重。其治疗以补虚为主，可用补肾填精之法，常用方剂为大补元煎加减。本方由熟地、山茱萸、山药、枸杞、杜仲、人参、当归、甘草组成，方中熟地、山茱萸、山药、枸杞子补肾填精；人参、当归益气养血；杜仲益肾强腰，全方合施意在填补肾精，充盈脑髓，故所患头痛可愈。

（六）阳痿

阳痿的形成原因不一，或因心脾受损，或因湿热下注，或因命门火衰，或因恐惧伤肾。恐惧为何能使人阳事不举？经曰“恐伤肾”。其说是指青壮年在阳旺之时，突受惊恐，且不能释脱，进而肾精暗耗，精神内损，阴精亏少，无以濡养宗筋，以致阳道无力。

恐惧损伤肾精所成阳痿的主要脉症，除阳事不举或举而不坚外，尚可兼见胆怯多疑，心悸易惊，失眠多梦等证，舌苔薄或薄腻，脉象弦细。上述脉证的形成在于：恐则伤肾，恐则气下，肾精损伤，宗筋痿弱，故阳事不举或举而不坚；情志所伤，胆伤则不能决断，故见胆怯多疑；心伤则神不守舍，故见心悸易惊，失眠多梦。

在临床上除恐惧伤肾形成阳痿外，肾阳不足，命门火衰也可引发阳痿。二者均属肾虚，应作出鉴别：肾阳虚阳痿虽也以阴茎痿软为主要临床表现，但多以精薄清冷，面色苍白，畏寒肢冷为兼证，而难以见到胆怯易惊等恐惧伤肾之证。至于男子年逾六旬，精气已衰，出现阳痿不举，为生理

衰退现象而不属病态。

治疗恐惧损伤肾精所致阳痿，其原则一是补益损伤之肾精，另则应养心安神以去其恐惧之由，故具体治法以益肾宁神最为恰当，常用方剂为大补元煎合安神定志丸加减（大补元煎的组成见肾精不足头痛），安神定志丸由人参、茯苓、茯神、龙齿、远志、菖蒲组成，方用地黄、枸杞、山药、山茱萸、女贞子、杜仲、菟丝子、龟版胶补肾益阴填精；茯苓、茯神、龙齿、枣仁、柏子仁、远志等养心安神。以上两类药物合用，兼治病之标本；可获得较为满意的效果。

本证主因恐惧而得，而恐惧之根在于心身过劳，故除药物治疗外，还应注意劳逸结合，树立战胜疾病信心，适当进行体育锻炼，这些都对增强身体健裨益甚大。身体健壮，心气充足，精神内守，即使暂受惊恐，也不致伤肾而成此证。

（七）须发早白

须发早白是指年纪少壮即出现胡须头发花白或全白的病证。祖国医学基本理论认为，肾藏精，须属肾；心主血，发为血之余，又因精血同源，故二者与须发关系密切。

肾精不足为何能引起须发早白？或因忧虑伤心，心血亏虚；或因早婚多育，房室不节，久病伤肾，致肾精不足。另因肾之阴精不足，不能上济心火，火愈旺则肾精愈亏。由于精亏血虚，不能荣须濡发，从而导致须发早白。本证多兼见梦遗滑精，牙齿动摇，腰膝无力，心中烦热等阴精不足，虚热内生之证。

在临床上，有些青少年形体壮实，面色红润，脉象有力，并无精亏血虚之象而见发白者，俗称“少白头”。这种

白发的产生，一是血燥有热，发失营养，或与家族遗传有关，此不可单纯看作肾精不足。

治疗须发早白宜用滋补肾精，兼清心火之法，常用方剂为七宝美髯丹。本方由何首乌、熟地、枸杞、菟丝子、怀牛膝、当归、茯苓组成。本方以何首乌为主药，功能补肝肾，养气血，长期服用此药可使肾精充，血气旺，须发渐渐乌黑；另以熟地、枸杞、菟丝子、怀牛膝、补骨脂等补肾强腰坚骨；当归、茯苓养血益心。上述各药与何首乌同用，不仅能增强乌须黑发之功，也治疗梦遗滑精，腰膝无力等兼证。此外，《世补斋医书》所载延寿丹一方，也指出应重用何首乌，以乌须发。方中以杜仲、牛膝、女贞子、菟丝子、地黄、桑椹子、黑芝麻、金樱子、旱莲草与首乌共成一体，其补益肝肾，养血固精之力尤宏，因此服用该方，不仅精气充盛，须发渐黑，亦可益寿延年。

（八）虚劳

虚劳是虚损劳伤的简称，又称劳损。是指脏腑亏损，元气虚弱所致多种慢性疾病的总称。虚劳以气血阴阳为纲，五脏虚损为目，所以有气虚、血虚、阴虚、阳虚之不同。就阴虚而言，五脏皆可出现，而肾精亏虚形成的虚劳临床比较常见。

肾精不足所致虚劳的原因极为复杂，总的来说不外先天不足与后天失养两个方面。先天不足主要由于父母精血不旺，孕胎营养不良，或因禀赋薄弱，生后又未进行及时恰当的调养。后天因素有因脾肾损伤，精血化源不足，或因早婚多育，房室不节，肾精过度耗伤；或因各种慢性疾病日久不愈，精气不复，最终导致肾精亏损。

肾之阴精亏损劳伤的主要脉症是，两足痿弱，形体虚衰，少寐健忘，头晕目昏，耳鸣耳聋，腰脊酸软，发脱齿摇。或兼五心烦热，咽干咽痛，潮热颧红，或有梦遗，妇女经闭不孕，或月经先期，量多。舌质红少苔，脉细或细数。

上述脉症是因阴精亏损，精脱髓虚所成。肾精虚亏，无以充养形体耳目，故形体虚衰，耳聋，目昏；肾督失养，则腰脊酸软，两足痿弱；真阴不足，脑髓空虚，故头晕健忘，发脱齿摇；阴虚火动，扰于精室，故有梦遗；元精亏乏，则经闭不孕；肾阳不足，阴不配阳，虚热内生，故见五心烦热，咽干咽痛，潮红颧红，月经先期、量多。舌质红，少苔，脉细或细数，均为肾之阴精亏虚之象。

肾虚劳损并非精亏一日而成，其治疗也非短日所能取效，因此医患两方面都应树立信心，相互配合，从缓图治。一般应采用“虚则补之”、“损者益之”及“精不足者，补之以味”的基本原则。由于阴阳互根，精、气、血同源，故在补法的配合应用上，应本着阳中求阴，阴中求阳，精中生气，气中生精之法具体施用。补益肾精则宜用阴柔之味，参入少许温阳益气之品，取其阴得阳升，化源不竭。临证施治时，当施以滋补肾精，填髓充脑之法，常用方剂为河车大造丸或左归丸加减。前方的药物有紫河车、地黄、人参、龟版胶、杜仲、牛膝、天冬、麦冬；后方由地黄、山药、山茱萸、枸杞子、龟版胶、鹿角胶、菟丝子、牛膝等药组成。前方以紫河车大补精髓，人参、地黄、龟版胶、杜仲、牛膝益气滋阴，充填肾精；天冬、麦冬滋肺阴以生肾水。后方以熟地、山药、枸杞、山茱萸补肾阴；鹿角胶、菟丝子温补肾阳，以从阳引阴；龟版胶滋阴降火；牛膝强壮腰膝。从临床

实践看，此类疾病尤宜服用丸药，丸药药力虽然缓慢，但比较持久。慢性疾病，缓缓图之，日久必见功效。

（九）月经过少

月经过少，也称月经涩少或月经不爽，是指月经周期基本正常，而经量显著减少或行经时间过短，甚或经血点滴即净为特点的病证。

月经的来潮，是女子发育到一定年龄的正常生理现象，它标志着天癸已经产生，任脉通畅，太冲脉已充盛。天癸是月经正常来潮的物质基础，而天癸的产生，又必须以肾气的充盈为先决条件。若肾精亏虚，则天癸减少，天癸虚少，则影响月经应时而下，致经期紊乱，经量失常。冲脉起于胞中，与肾脉并而上行，有“血海”之称。任脉亦起于胞中，与肾脉交于曲骨、中极、关元等穴，为阴脉之海，是故冲任二脉与月经行止息息相关。妇人以血为本，经水由血所化生，血的生成与调节，除与心、肝、脾三脏有关外，也与肾脏密切相关。肾藏精，精血同源，精亏则血少，血少则经水不足。从以上所论月经的生成、经量的失常与肾的关系，说明肾虚可以导致月经过少。哪些因素能引起肾虚呢？主要是禀赋不足，早婚多育，房事太过等损伤于肾，致肾亏精伤。

肾精不足月经过少的主要脉症是，月经量少或点滴即无，经期缩短，经行不爽，色鲜红或淡红，兼见腰膝酸软，足跟疼痛，头晕耳鸣。舌淡少津，脉象沉细。上述各症均属肾虚精血亏少，髓海不足，腰脊失养之征象。因此，治疗原则当以滋补肾精与养血调经并施，常用方剂为当归地黄饮加减。此方为《景岳全书》所載，方中熟地、枸杞、龟版胶、山药、山茱萸滋补肾精；杜仲、菟丝子、牛膝补肾强腰，壮

筋骨，当归、川芎、白芍、鸡血藤配地黄养血通经，甘草配山药可健脾和中，以增强化血之源。本证施治以上方药，肾精充盛，血液有源，月经量可恢复正常。

(十) 崩漏

肾虚崩漏的主要脉症是，经血淋漓不断或下血量少，血色鲜红，兼见头晕耳鸣，腰膝酸软，五心烦热，失眠盗汗。舌红少苔或无苔，脉细数无力。上述脉证可施滋肾固阴之法，用左归丸减川牛膝，加枸杞子、龟版胶、女贞子、旱莲草等进行治疗。方中熟地、山药、枸杞、龟版胶、女贞子、旱莲草滋肾填精；山茱萸、菟丝子补肾摄精；鹿角胶补阳以求阴。川牛膝有行血之弊，故减去不用。

肾精亏虚所成崩漏，以漏下为多见。如日久不愈，病势加重，亦可转为下血量多、来势急骤的崩证。血崩一旦发生，因气随血脱，短时可见四肢厥逆，脉微欲绝，汗出如油等虚脱之证。此时虽然肾精亏虚尚未复原，因气虚欲脱为急，则当急则治标，应暂用独参汤或参附汤益气回阳固脱，以挽救生命为要务，待阳回脱逝，再议滋肾治本之法。

(十一) 绝经前后诸症

肾精不足所致绝经前后诸症的脉证是，头晕耳鸣，失眠多梦，心烦易怒，烘热汗出，五心烦热，腰膝酸软，口干便结，小便黄赤，舌红少苔，脉细而数。

治疗肾精亏虚为主的绝经前后诸症，原多以滋肾养肝，育阴潜阳为大法，常用方药为左归饮加味。左归饮由熟地、山药、枸杞子、炙甘草、茯苓、山茱萸组成，方用熟地、枸杞、山药、山茱萸及首乌、龟版、沙苑蒺藜，可补肝肾益精血，加龙骨、白蒺藜、钩藤，功能育阴潜阳。肾精充足，脑

髓充盛，肝阳潜纳，冲任和调则诸证自平。如心火无水相济，偏于上亢，不得下通，心肾不交，则证以心悸怔忡，失眠多梦为主，当用左归饮加生地、玄参、天冬、麦冬、茯神、枣仁、五味子等滋肾养心安神治疗为宜。

（十二）不孕症

受孕的机理，主要是肾精充沛，血气旺盛，任通冲盛，月事如期，两精相抟，方能成孕。而不孕证的发生，除肝郁气血不和、冲任不能相资及痰湿阻于胞脉外，肾精不足，冲任脉虚，胞脉失养，不能摄精成孕为常见的发病机理。

肾虚不孕的主要脉症是，婚久不孕，月经后期或经期延长，腰酸膝软，头目眩晕，形体消瘦，五心烦热，舌红脉细。肾精亏虚不孕之证，宜用养血益精之法进行治疗，常用方剂是种玉汤加味。本方由熟地、山茱萸、紫河车、枸杞子、女贞子、龟版胶、当归、白芍等组成，方中熟地、山茱萸、紫河车、枸杞、女贞子、龟版胶补肾益精；当归、白芍养肝和血，各药同用共奏滋肾养血之效。肾中精血旺盛，任脉通，太冲脉盛，胞脉得养，两精相抟，自能摄精成孕。

七、阴虚火旺

肾阴虚火旺证是在肾阴虚基础上进一步发展而来。肾主藏精，精气包括肾阴肾阳两部分，又称元阴元阳，分之则二，合之则一。若肾中元阴不足，阴精亏乏，阴不制阳，热由内生，虚火内扰，相火妄动，则产生阴虚火旺的症候。导致阴虚火旺的原因很多，凡引起肾阴虚的病因，多数能进一步发展为阴虚火旺。如先天不足，肾阴素虚；久病不愈，日久伤

及肾阴；热病日久，耗伤真阴，或恣情纵欲，房劳太过，使阴精耗竭；或其他脏腑之阴虚日久耗伤真阴等。阴虚火旺证的临床特点是既具有虚证，又具有热证。可以认为，《内经》所谓“阴虚生内热”的论述即属于此。

阴虚火旺证的临床表现比较复杂，其中主要症状是：两颧红赤，潮热盗汗，口干咽燥，头晕耳鸣，手足心热，虚烦不寐，腰膝酸软疼痛，阳强遗精，或见小便短赤，大便秘结，男子不育，女子经少，经闭，崩漏，或不孕。舌红少苔，脉细数等。

本证之所以出现上述脉症，无不由肾水衰少，元阴不足，水不济火，虚火妄动而致。虚火上浮则见两颧红赤，口干咽燥；虚火内炽，则见潮热，手足心热；迫液外泄，故见盗汗；虚热扰神，则见虚烦不寐；肾精亏虚，髓海不足，清窍失充，则见头晕、耳鸣；肾主骨，腰为肾之府，肾府失养，则腰膝酸软疼痛；相火妄动，则阳强；扰动精室，则遗精；肾阴虚精少，故男子不育、女子不孕；虚热迫血妄行，则崩漏；阴虚火旺，不能下润大肠，故大便秘结；肾与膀胱相表里，相火移于膀胱，则见小便短赤。舌红少津，脉细数为阴虚火旺典型的舌象与脉象。

本证的治疗，根据“培其不足”，“伐其有余”的原则，以滋养肾阴为主，参以清泄相火。滋肾阴宜甘润壮水之剂，以补阴配阳，使虚火降而阳归于阴，所谓“壮水之主，以制阳光”。在用药方面忌辛燥，温补之品。常选用知柏地黄丸、大补阴丸、化阴煎等加减。

阴虚火旺常见病证有：内伤发热、肺癆、眩晕、不寐、咳血、衄血、尿血、血淋、便血、下消、遗精、盗汗、月经

先期、经行发热、经期延长、崩漏、胎漏、胎动不安、妊娠小便淋痛、产后发热、阴痒等。

(一) 内伤发热

阴虚火旺内伤发热，多因素体阴虚，或温病、热证经久不愈，热盛伤阴，或因久泄伤阴，或因用燥药过多，导致阴液亏损，不能制火，虚火亢盛，从而引起发热。《素问·调经论》指出：“阴虚生内热”。

阴虚火旺所致发热的主要临床表现是：午后或夜间骨蒸潮热，手足心热，两颧潮红，心烦盗汗，失眠多梦，口干咽燥，腰膝酸软，形体消瘦，或见遗精，大便秘结，小便短赤，舌质红少津，或见裂纹，无苔或少苔，脉象细数。

阴精亏虚则阳热内盛为本证的主要病机。阴虚生内热，以其病在阴分，故于午后或夜间发热，手足心热，虚火上炎，则见两颧潮红；扰动心神，则心烦，失眠多梦；内热逼津液外泄则盗汗；腰为肾之府，肾阴亏损则腰膝酸软；阴虚火旺，扰动精室则遗精；口干咽燥、大便秘结、小便短赤、舌红少津、无苔或少苔、脉细数均为阴虚有热之象。

本证应与血虚发热、气郁发热相鉴别。血虚发热系因血虚阳盛，阳气外浮而引起发热。兼见头晕眼花，身倦乏力，心悸不宁，面白无华，唇甲色淡，舌淡脉弱等血虚失养，血脉不充之证。并多有慢性出血的病史。而气郁发热，多因肝气不舒，郁而化火而引起发热，热势常随情志变化而起伏。且兼见急躁易怒，胸胁闷胀，口苦，苔黄、便秘，舌红，脉弦数等症，临证不难区分。

本证的治疗法则应采用滋阴清热法。方选鳖甲散加减。本方由鳖甲、柴胡、知母、青蒿、秦艽、当归、乌梅、地骨

拔组成。方中鳖甲、知母、当归、乌梅以滋阴养血，地骨皮、柴胡、秦艽、青蒿以清虚热。临床使用时还可以加生地、元参、首乌等以加强其滋阴的作用。盗汗者可加煅牡蛎、浮小麦、麻黄根以固表敛汗。失眠者可加炒枣仁、夜交藤以养心安神。若患者口干口渴，心烦不安，两颧潮红，为虚火上炎，可改用大补阴丸以滋阴降火。若患者除见上述阴虚火旺症状外，又兼见头晕乏力，气短懒言等气虚症状，为气阴两虚，可在鳖甲散基础上再加太子参、北沙参、麦冬、五味子等以益气养阴。

(二) 肺癆

肺脏因虚损而受癆虫侵蚀的疾病就称为肺癆。是一种具有传染性的慢性虚弱性疾病。临床上以身体逐渐消瘦，咳嗽咯血，潮热盗汗，面白颧红，五心烦热为特征。其发病主要原因为正气不足、气血虚弱、癆虫传染。由于素日体质薄弱，或长期忧愁思虑，或过度劳倦，或嗜酒房劳太过，或大病久病之后失于调养，或外感久咳不愈等原因，耗伤了气血精液，导致正气虚弱，癆虫乘虚侵入而发为本病。本病初起，病变部位主要在肺，由于癆虫蚀肺，出现肺阴亏损，进一步发展可以表现为阴虚火旺、气阴两虚、阴阳两虚等证候。

肺癆的病位虽然主要在肺，但与其他脏腑关系密切，特别在发病机理上与肾阴虚损、阴虚火旺有着十分密切的联系。若先天禀赋不足，加以后天姿情纵欲，或青年早婚多育，斫伤太过，消耗肾精，阴虚火旺，虚火上乘于肺，肺为灼炼，阴液受损，久而不愈，复为癆虫传染而发为肺癆。

肺癆的阴虚火旺证，主要临床表现是：干咳少痰，痰黄粘稠，或咳血反复发作，量多色鲜，面色枯槁，失眠多梦，

急躁易怒，头晕耳鸣，胸胁疼痛，男子梦中遗精，女子月经不调，舌质红绛，无苔或少苔，脉象细数。

上述症状的产生系因肺肾阴伤，水亏火旺，虚火内灼，耗伤阴精所致。多见于肺病的中期或晚期。此时不但证见肾阴亏虚，阴虚内热，相火妄动之证，亦兼见水不涵木，心肝火炎及阴虚不复，肺燥火盛的证候。

本病的诊断可根据与肺病病人的密切接触史，及典型的咳嗽、咳血、潮热、盗汗、胸痛、消瘦等主证，一般不难作出诊断。

阴虚火旺是肺病发展过程中的一个阶段，临床上应与肺阴亏损，气阴两虚，阴阳两虚相鉴别。肺阴亏损为肺病初期，以肺阴虚与肺失清肃为突出表现。证见干咳少痰或痰中带血，咳则胸痛，潮热颧红、口燥鼻干等。气阴两虚系阴伤气耗，肺脾同病，致使肺失清肃，脾失健运，多为肺病中期或晚期。症状表现除肺阴虚外，又出现肺气不足之咳声无力，气短声低，自汗恶风等症，以及脾不健运之神疲乏力，食少，腹胀，便溏等症。阴阳两虚系阴损及阳，肺病进入晚期。除“阴虚生内热”之见证外，又出现“阳虚生外寒”的恶寒肢冷等症，以及元气衰败的形体羸弱，面浮肢肿，五更泄泻，咳逆喘息，男子遗精，阳痿，女子经少经闭等症。临证不难鉴别。

本证的治疗原则是滋阴清火。方剂选用秦艽鳖甲散加减。本方由秦艽、鳖甲、知母、当归、柴胡、地骨皮、青蒿、乌梅等药物组成。方中以鳖甲、知母滋阴清热；当归补血和血；秦艽、柴胡、地骨皮、青蒿清热除蒸；乌梅酸涩敛阴止汗。若盗汗甚者加浮小麦、五味子、煅龙骨、煅牡蛎以滋阴敛

汗。烦躁失眠者加栀子、枣仁、夜交藤以清热安神。痰黄粘稠者加蛤粉、瓜蒌仁、桑白皮、马兜铃、黄芩等以清热化痰。急躁易怒者加黛蛤散以清肝热，化痰止咳。男子梦遗滑精者加龟版、山茱萸、煅龙牡、金樱子以滋肾涩精。咳血不止者加服十灰散以凉血止血。

肺癆患者除积极治疗外，要保持乐观情绪，做到生活有常，饮食有节，富于营养，忌辛辣，慎起居，避风寒，戒烟酒、房事，劳逸适度，呼吸新鲜空气，方能提高疗效，逐步恢复健康。

（三）咳血

咳血是肺络受伤所引起的出血病证。其血液来源于喉以下的呼吸道，多伴随咳嗽经气道而咳出。临床上咳血又称嗽血。亦有不咳而一咯即出的称为咯血；鲜血与唾液混杂而出的称唾血。名称虽然不同，均属咳血范畴。咳血的发病原因很多，如外感风温、风燥之邪；或内伤七情，肝气郁结，暴怒伤肝；或饮食不节，损伤脾气；或素体阴虚，房劳伤肾等，常可导致风热伤肺，肝火犯肺，阴虚火旺，脾不统血等不同咳血证候的出现。

阴虚火旺咳血是由房劳太过，纵欲竭精，致肾阴亏耗，虚火上炎，火盛则刑金，金病则肺燥，肺燥则络伤而咳血。或因痨虫蚀肺，动热伤阴，或其他疾病日久伤肾，以致肾阴亏虚，虚火内炽，灼伤肺络而导致咳血。咳血虽病位在肺，但与肾关系密切。明·张景岳就曾提出：“咳嗽咯唾等血无不关于肾也。……其病标固在肺，而病本则在肾也。”（《景岳全书·卷三十血证》）。

阴虚火旺所致咳血的主要临床表现是干咳少痰、痰中带

血，血色鲜红，常反复发作，身体消瘦，两颧红赤，午后潮热，口干咽燥，手足心热，心烦失眠，睡眠中盗汗，耳鸣，腰膝酸软，舌质红少津液，无苔或少苔，脉细数。

上述症状的产生系因肾水不足，以致肺失滋润，肺燥火盛，清肃无权，故干咳少痰，口干咽燥；水亏火旺，灼伤肺络，则痰中带血，血色鲜红；水亏不能济火，火热扰动，逼津液外泄而见盗汗；虚火扰动神明则心烦失眠；阴虚生内热，阳气拂郁于外而致两颧红赤，午后潮热；肾开窍于耳，腰为肾之外府，肾阴亏虚则见耳鸣、腰膝酸软等症。舌质红少津液、无苔或少苔、脉细数，为阴虚火旺之象。

本证的诊断，可根据咳血患者多有咳嗽、喘证或肺病等肺系疾患的病史。咳血前常有胸闷、喉痒等症状。以及血由肺来，经咳嗽而出，或纯血鲜红，兼夹泡沫，或痰血相兼，或痰中带有血丝的特点，一般不难作出诊断。

阴虚火旺咳血应与燥气犯肺，肝火犯肺咳血相鉴别。燥气犯肺咳血多发于秋季，燥气当令，风燥伤肺而引起。病程短，证见周身燥热，干咳，咳血，鼻燥咽干，口渴欲饮，苔薄白而燥，脉浮数等。肝火犯肺咳血，多有情志不遂，暴怒伤肝的病史，咳血因恼怒而诱发或加重，兼见胸胁疼痛，头痛眩晕，面红目赤，烦躁易怒，口苦而干，便秘溲赤，舌红苔黄，脉弦数等肝火炽盛之证，临证不难鉴别。

本证的治疗法则，应采用滋阴降火，凉血止血法。方剂选用加减一阴煎。本方由生地、熟地、芍药、麦冬、炙甘草、知母、地骨皮组成。方中生地、熟地滋养肾阴，麦冬养肺阴，芍药养血，知母、地骨皮清热降火。临床使用时加旱莲草、白芨、茅根、藕节、茜草根等以凉血止血。反复咳血量

多者加阿胶、三七粉以养血止血。午后潮热、颧红者加青蒿、银柴胡、鳖甲、白薇等以清虚热。盗汗加浮小麦、五味子、煅牡蛎等以收敛止汗。胸闷胸痛者加瓜蒌皮、郁金、橘络以理气通络止痛。

（四）齿衄

凡不因外伤而血自齿缝牙龈中出者称为齿衄，又称“牙宣”。轻者量少而点滴渗出，重者量多势如涌泉。本证发生与手阳明、足阳明及足少阴三经关系密切。手阳明大肠经经脉入下齿中。足阳明胃经经脉入上齿中。若过食辛辣，素嗜甘肥，饮酒无度，胃肠中热邪郁结，循经上行，胃火上升，血随火动，发为齿衄。或久病体虚，饮食不节，脾虚气弱，脾不统血，气不摄血，也可导致齿衄。另外肾阴不足，虚火上炎亦可引起齿衄。

阴虚火旺齿衄是由房劳过度，劳伤精血，营阴内伤，或失志伤肾，肾阴暗耗，或久病及肾，热病伤阴，均可导致肾阴亏虚，肾火内动。肾主骨，齿为骨之余。肾虚则齿不固，火动则血妄行，故成齿衄。

阴虚火旺所致齿衄的临床表现是齿衄，出血淡红，时发时止，多无牙龈红肿，但觉齿摇而浮，牙齿酸痛，兼见头晕目眩，耳鸣，心烦不寐，腰酸乏力，舌红，脉细数。

阴虚火旺齿衄属衄血虚证，故血色淡红，齿根浮动，牙齿酸痛，时发时止；肾阴亏虚，虚火上扰，则见头晕目眩，耳鸣；扰动心神则心烦不寐；腰为肾之府，肾虚则腰酸乏力；舌红，脉细数为阴虚火旺之象。

本证应与胃火炽盛之衄血相鉴别。胃火炽盛之衄血属实热证，多因饮酒过度，恣食辛辣甘肥而发。证见齿衄红肿疼

痛，出血鲜红，口臭，口渴喜饮，大便秘结，舌红苔黄，脉滑数等，临证不难区分。

齿衄阴虚火旺证的治疗法则，应采用滋阴降火，凉血止血法。方剂选茜根散加减。本方由茜根、侧柏叶、生地、阿胶、黄芩、甘草组成。方中以生地、阿胶滋阴止血；茜根、侧柏叶、生地、黄芩清热凉血止血；甘草和中。临床亦可用六味地黄丸滋养肾阴，加知母清泻相火，再加藕节、茅根、侧柏叶、旱莲草等以凉血止血。有潮热者加青蒿、地骨皮以清虚热。

（五）便血

血液由肛门或随粪便而出谓之便血。或血便夹杂而下，或血在大便之前，或在大便之后或单纯下血，均称为便血，临床上亦称为下血、泻血、血便等。引起便血的原因主要有饮食不节，感受外邪，情志失调及年老久病等。其主要病机是火热薰灼，胃肠络脉受损，或中气不足，脾胃虚寒，血失统摄而溢入肠道，以致发生便血。临床常见证型有湿热蕴蒸、胃中积热，肝胃郁热、热毒内陷、阴虚火旺、气滞血瘀、脾胃虚寒、中气不足等。初病多属实证，日久则可转为虚证。

阴虚火旺便血是指肾阴不足，虚火妄动，灼伤络脉而致。发病原因多为久病不愈，营阴内耗；或年老体衰，肾阴素亏；或醉饱房劳，肾阴亏损；或忧思郁怒，五志化火，耗伤阴血等，致使水亏火旺，扰动阴络。或因阴液亏少，大肠热盛，便燥难下，用力过度，肠道破裂出血。

阴虚火旺所致便血的临床表现是先便后血，血色深红，点滴而下，血量不多，或见先血后便，血色鲜红，肛门疼痛，大便秘结，同时兼见眩晕耳鸣，口燥咽干，五心烦热，颧红

盗汗，失眠多梦，梦中失精，腰酸乏力，形体消瘦等症，舌红苔少，脉弦细或细数。

阴虚火旺便血属虚热证，多见先便后血，血色晦暗的“远血”，病在小肠和胃，是由肾阴不足，虚火妄动，扰动阴络而成；亦有因素体阴虚，大肠热盛，津液不足，润便下行，致使便燥难下，用力过度，直肠或肛门破裂出血，则又属“近血”范畴。致于眩晕耳鸣等兼症，以及舌苔脉象均属阴虚火旺之象。

本证应与脾胃阳虚便血相鉴别，两者均属虚证，具有病程长，遇劳频发的特点。然脾肾阳虚便血，多由素体阳虚，劳倦过度，大病不复等因素，损伤脾肾阳气所致。脾气虚则失统摄之力，肾气损则失封藏之本，阴络血溢，发为便血。阳虚便血虽也多见“远血”，但质清稀、色暗淡，或黑腻如柏油。兼见面色苍白，气短懒言，恶寒肢冷，脘腹隐痛，溲清便溏，舌淡体胖，苔白滑，脉沉细无力等证。

阴虚火旺便血的治疗，应以滋阴降火，养血宁血为主。方剂选三地汤加减。本方由生地、熟地、地榆、当归、木耳末组成。方中二地、当归，滋养肾阴，养血润肠；地榆清热凉血止血；木耳末凉血止血。临床使用时可加生首乌、阿胶、白芍、旱莲草、女贞子、知母、黄柏等滋肾阴、泻相火，凉血止血之品。

（六）尿血

尿血是指血液随小便排出的病证。尿中所混血液，有的肉眼可见，严重的伴有血块，夹杂而下；轻者仅能借助显微镜观察，出现镜下血尿。小便因出血量多少的不同，可呈淡红色、鲜红色或淡酱油色。引起血尿的原因很多，但以热伤

脉络为主。热有实热、虚热的不同。若因外邪化热入里，热结膀胱；或火毒内壅，侵入营血，迫血妄行；或心火亢盛，移热小肠；或肾阴亏虚，阴虚火旺，损伤脉络而形成尿血。此外，部分患者可因气血亏虚，脾肾两虚，或气滞血瘀，络阻血溢而成本证。

阴虚火旺尿血是尿血中常见类型，多因房室不节，相火妄动或因烦劳过度而伤肾阴，阴虚则生内热。肾与膀胱相表里，虚火灼伤肾与膀胱血络，则血随尿而出，导致尿血。

本证的临床表现是，小便色赤带血，头晕目眩，口干咽燥，潮热盗汗，颧红失眠，五心烦热，腰酸乏力，耳鸣心悸，舌红少苔，脉细数等。

上述症状的产生，系因肾阴不足，虚火内动，灼伤血脉，则见尿血；上扰清室，则头晕目眩；耳为肾窍，肾虚失于濡养，则耳鸣；虚火扰动心神，则心悸失眠；阴虚生内热，故见潮热盗汗，五心烦热，颧红；腰为肾府，肾虚故见腰酸乏力；舌红少苔，脉细数，均为阴虚火旺之象。

临床上本证应与热迫膀胱尿血症相鉴别。热迫膀胱尿血，发病急，病程短，初起多见恶寒发热，遍身骨节疼痛，口渴喜饮，小腹作胀，尿血颜色鲜红，舌红苔黄，脉数等证。一虚一实不难鉴别。

本证的治疗原则，是滋阴清火，凉血止血。常用代表方剂可选大补阴丸合阿胶汤加减。前方由黄柏、知母、熟地、龟版、猪脊髓组成。后者由阿胶、黄芩、生地黄、甘草组成。方中生地、熟地、阿胶、龟版滋养肾阴；知母、黄柏、黄芩清肾火而保真阴；甘草和中。临床使用时，可再加旱莲草、茅根、小蓟以凉血止血。如有低热，可加银柴胡、地骨皮、

鳖甲以滋阴退热。盗汗者，加浮小麦、煅牡蛎、山茱萸以滋阴敛汗。心烦少寐者，加夜交藤、远志、酸枣仁以养心安神。

(七) 消渴

消渴是临床常见病证，其“消”字有消谷、消耗、消瘦之意，“渴”乃口渴欲饮也。以多饮、多食、多尿、形体消瘦，或尿有甜味为特征的一类病证。本病多发于中年以后，若青少年即患此病，一般病情较重。引起本病的原因，可因饱食不节，恣食肥甘，醇酒厚味，积热伤津；或因情志失调，五志化火，郁火伤阴；或素体阴虚，肾精亏损所致。其病理变化，以阴虚燥热为主，但以阴虚为本，燥热为标，并且互为因果。病变脏腑虽然与五脏有关，但以肺、胃（脾）、肾为主，其中以肾最为重要。消渴的辨证，古今医家根据本证多饮、多食、多尿症状的轻重主次不同，把消渴分为上、中、下三消。以口渴多饮为主者称为上消；以消谷善饥，多食为主者称为中消；以多尿，尿如脂膏者称为下消。

阴虚火旺消渴证，多因先天禀赋不足，五脏柔弱，尤其是肾脏素虚。五脏主藏精，肾又受五脏六腑之精而藏之。若五脏脆弱，精液微薄，肾精亏竭；或年老阴衰，人年四十而阴气自半，故凡年老之人，肾阴亏损；或房室不节，劳伤过度，早婚多育，盛壮之时，不知慎惜，恣情纵欲，乃致肾水枯竭；或过服温燥药物，耗伤阴津，均可导致水虚不能制火，虚火上炎，上蒸肺胃，终至肾虚肺燥胃热，而发为消渴。

阴虚火旺消渴证，多属下消。其临床表现，在多饮、多食、多尿三多中以多尿为主，尿频重多，混浊如脂膏，或尿甜，口干舌燥，头晕耳鸣，潮热盗汗，五心烦热，多梦遗

精，腰膝酸软，皮肤干燥，全身瘙痒，舌红少苔，脉细数。

上述脉证产生的机理在于肾为先天之本，主藏精而寓元阴元阳。肾阴亏损则阴虚阳盛，肾之开阖失司，固摄无权，则水谷精微直趋下泄，随小便排出体外，故尿频重多，尿多味甜，或混浊如脂膏；阴虚生内热，虚火上燔心肺则口干舌燥而多饮，中灼脾胃则胃热消谷而多食；髓海不足，脑失濡养则头晕耳鸣；肾府失养则腰膝酸软；阴亏火旺，扰动精室则遗精；精微不能濡润肌肤，故皮肤干燥而瘙痒；潮热盗汗，五心烦热，舌红少苔，脉细数为阴虚火旺之象。

阴虚火旺证消渴，在治疗上当以滋养肾阴，清热润燥法。方剂可选加减一阴煎。本方由生地、熟地、芍药、麦冬、炙甘草、知母、地骨皮组成。方中生地、熟地、白芍、麦冬以滋阴润燥，知母、地骨皮以清热，炙甘草益气升津。临床应用时可再加枸杞子、沙苑子、桑螵蛸以增强滋阴固肾之功。加龟版、元参、黄柏以养阴清热。腰痛甚者，加续断、怀牛膝、寄生以补肾强腰。遗精者，加龙骨、牡蛎以涩精。阴虚火旺证消渴亦可用知柏地黄丸加减。

本证除药物治疗外，还应注意节制房事和饮食，避免七情内伤，禁忌辛辣醇酒甘肥之品，这对本病防治有重要意义。正如《备急千金要方·消渴》篇所说：“其所慎有三，一饮酒，二房室，三咸食及面。能慎此者，虽不服药而自可无他，不知此者，纵有金丹亦不可救，深思慎之。”

(八) 遗精

阴虚火旺而遗精多因烦劳过度，多思妄想，所欲不遂，以致肾精暗耗，相火妄动，火动于中，必摇其精，扰动精室而致遗精；或青年早婚，恣情纵欲，肾精不藏，肾阴虚则相

火偏盛，干扰精室，以致封藏失职而精液自遗。

本证主要临床表现是睡梦中遗精，或因梦交而遗泄，阳事易举，或兼早泄，睡眠不实，梦多，面红，头晕目眩，耳鸣如蝉，面红心烦，心悸，精神不振，体倦乏力，腰膝酸软，小便短赤，大便干，舌质红，无苔或少苔，脉象细数。

肾阴亏损，相火妄动，触动精关，而精液自遗；相火妄动，则阳事易举；肾阴不足，心火偏亢，耗伤营血，营血虚不能养心，则见心悸心烦，睡眠多梦；外不能充养肌体，则体倦无力，精神不振；水亏则火浮，虚火上炎，则面红，头晕目眩，耳鸣；肾与膀胱相表里，相火亢盛，移热膀胱，则见小便短赤等证。舌质红，脉细数为阴虚火旺之象。

阴虚火旺所致遗精应与肾阳虚精关不固，肾虚不藏之遗精，以及湿热下注，扰动精室之遗精相鉴别。阳虚不固之遗精，遗精频作，多无梦而遗，甚至滑精，昼夜流精，精液少而清冷，面白少华，畏寒肢冷，舌质淡，脉沉细。湿热下注之遗精，遗精频繁发作，或有梦或无梦，多兼见小便时有精液外泄，小便黄赤，热涩不爽，舌苔黄腻，脉濡数或滑数等，临床不难区分。

本证治疗当以滋养肾阴，清泻相火，收敛固精法。方剂选知柏地黄丸合水陆二仙丹加减。前者由六味地黄丸加知母、黄柏组成，后者由金樱子、芡实组成。方中六味地黄丸滋养肾阴，知母、黄柏清泻相火，金樱子、芡实涩精止遗。临床使用时可再加女贞子、旱莲草、枸杞子等以加强滋养肾阴的作用。加龙骨、牡蛎、五味子、桑螵蛸以收敛固精。若失眠多梦，加夜交藤、枣仁以定神。舌尖红、心烦，加黄连、栀子以清心除烦。若心有妄想，所愿不遂，心神不安，

君相火动而遗精者，可用安神定志丸以养心清热安神。若久病遗精，阴虚火动，而气虚体衰者，改用三才封髓丹加减。治疗同时要精神调养，排除杂念，避免过度紧张的脑力劳动，丰富文艺生活，注意饮食起居，参加适当的体育锻炼，消除过多的情欲冲动，禁忌房事过度。此外，临睡时用温水洗脚，睡眠时宜侧卧，衬裤不宜紧，避免刺激，脚部不宜盖的太暖等，对预防遗精均有一定帮助。

（九）淋证

阴虚火旺淋证，多见血淋虚证。发病原因多为久淋不愈，湿热伤阴，或禀赋不足，素体阴虚，年老久病，房劳多产，夙患癆瘵等肾阴不足，虚火亢盛，损伤阴络，溢入膀胱，则为血淋。

血淋虚证的临床表现是小便频急，尿色淡红，小便有灼热感，但涩痛不甚，病程较长，兼见头晕耳鸣，咽干颧红，五心烦热，腰膝酸软。神疲乏力，甚至潮热盗汗。舌红少苔，脉细数。

血淋虚证应与实证相鉴别，血淋实证多由下焦湿热所致。辨别血淋虚实的主要依据有，病程的长短，尿道涩痛的轻重，小便色泽的深浅及其他兼证。一般病程较长，尿血涩痛不甚，小便颜色淡红，兼见头晕，腰酸，五心烦热，舌红少苔，脉细数等肾阴虚、虚火亢盛表现的为血淋虚证；而病程短，小便灼热涩痛较甚，尿色鲜红，甚至挟有血块，小腹胀痛，兼有烦躁口苦，舌红苔黄，脉滑数有力等湿热下注表现的为血淋实证。

血淋虚证的治疗原则，应以滋阴补肾，清热止血为主。方剂选知柏地黄丸加减。本方由知母、黄柏、熟地、山茱

萸、山药、丹皮、泽泻茯苓组成。方中以熟地、山茱萸、山药滋养肾阴，固涩肾精；以知母、黄柏、丹皮、泽泻清泻相火；茯苓配泽泻淡渗利湿。临床使用时再加阿胶、龟版、旱莲草、小蓟等滋阴凉血、止血之品。若兼见干咳少痰，午后潮热，夜寐盗汗等症，酌加青蒿、地骨皮、银柴胡以养阴清热。若阴虚而湿热未尽，尿痛明显者，可改用阿胶散以育阴止血，清利湿热。

(十) 眩晕

阴虚火旺眩晕多因先天不足，肾阴素亏，或年老肾精不充，或房事不节，早婚多育，阴精亏耗，皆可导致肾阴不足，阴虚火旺，虚火上扰清空，发为眩晕。或肾阴不足，肾精虚少，髓海空虚，不能上充于脑。使眩晕加重。

阴虚火旺眩晕的临床表现是，眩晕耳鸣，头痛颧红，五心烦热，咽干，失眠，盗汗，精神萎靡，腰膝酸软，或见遗精，形体消瘦，舌质嫩红，无苔或少苔，脉细数。

肾为先天之本，主藏精生髓，髓聚而成脑。阴精不足，脑髓失充，阴虚火旺，上扰清窍，发为眩晕耳鸣，头痛；肾阴不足，阴不维阳，虚热内生，故颧红，五心烦热，咽干，失眠，盗汗，形瘦；精髓不足，则见精神萎靡；肾主骨，腰为肾之府，肾虚则腰膝酸软；阴虚火旺，扰动精室，故遗精；舌质嫩红，无苔或少苔，脉细数，均属阴虚火旺之象。

本证应与肾阳虚衰，肝阳上亢眩晕相鉴别。肾阳虚衰眩晕，兼见面色苍白或黧黑，形寒肢冷，阳痿滑精，舌淡嫩，苔白，脉沉细等证。肝阳上亢眩晕，兼见头胀痛，心烦易怒，面红目赤，口干口苦，便秘溲赤，舌红苔黄，脉弦数或弦细数等证，临证不难区分。

阴虚眩晕火旺的治疗，应采用滋阴补肾，清热降火法。方剂选左归丸加知母、黄柏。方中熟地、山药、山茱萸、枸杞、牛膝、龟版滋养肾阴，鹿角胶、菟丝子填精补髓；知母、黄柏清热降火。眩晕较甚者，可加生龙骨、生牡蛎、鳖甲、珍珠母等，以潜浮阳。遗精较频者，可加金樱子、莲子须、桑螵蛸等以固肾涩精。耳鸣者，加磁石以潜阳聪耳。五心烦热者，加地骨皮、丹皮、白薇以清虚热。

（十一）不寐

不寐乃不眠之意。是指经常不能获得正常的睡眠而言。轻者不易入睡，或寐而不甜，寐而易醒，时寐时醒，醒后不能再度入睡，严重者可彻夜不眠。或称“不得眠”、“目不瞑”等。引起不寐的病因病机大致可分为外感和内伤两方面。由外感引起者，主要见于各种热病过程中；由内伤引起者，则多由七情所伤，五志化火，扰动神明，魂不能藏；或因饮食不节，劳倦太过，大病久病之后，心脾两虚，气血不足，心神失养，神不守舍；或因宿食痰火，胃气不和，上扰神明；或阴虚火旺，心肾不交；或心胆气虚，神摇善惊等，均可影响心神而致不寐。一般说来，除外感者外，脏腑机能紊乱，气血、阴阳相对平衡失调，是发生不寐的基本原因。

阴虚火旺证不寐发生的原因，主要在于先天不足，肾阴素虚；或久病之人，肾阴耗伤；或少年之时误犯手淫，或至成年房劳过度，伤及肾脏，致真阴亏损，水亏火旺，孤阳上浮，火主乎动，气不得宁，发为不寐。另外肾主水，心主火，肾水上升，心火下降，水火既济，心肾交通，睡眠不能正常。现肾阴匮乏于下，不能上奉心火，水不济火，心肾不交；或肾水亏损，肝火失其涵养，肝阳上越，神魂不安，亦

可导致不寐。

阴虚火旺不寐证的临床表现是心烦不寐，入睡困难，甚则彻夜不眠，头晕目眩，咽干耳鸣，潮热盗汗，手足心热，腰膝酸软，精神萎靡，遗精，舌红少苔，脉细数。

上述脉证产生的机理在于水亏于下，火炎于上，虚火扰神，则心烦不寐，入睡困难，甚至辗转反侧，彻夜不眠；阴精不足，髓海空虚，阴虚火旺，虚火上炎，上扰清窍，则头晕目眩，咽干耳鸣，精神萎靡；阴虚津液不能内守，则盗汗；肾府失养，则腰膝酸软；阴虚火旺，精关不固则遗精；午后潮热，手足心热，舌红少苔，均属阴虚火旺之象。

阴虚火旺不寐有肾阴虚火旺和心阴虚，心火偏旺的不同。心阴不足，心阳偏旺，阴不恋阳，心神不宁而致不寐。阳不入阴，故不易入睡，多梦易醒。兼有心悸健忘，心烦盗汗，口燥咽干等心阴不足之证。肾阴虚火旺不寐，一般较心阴虚火旺不寐严重，甚至彻夜不眠。兼见头晕耳鸣，腰膝酸软，遗精等肾阴虚损之征，临证应予区别。另外，本证还应与心脾两虚，心胆气虚和血虚肝旺不寐相鉴别。如患者虽能入睡，但睡易醒，醒后不易再睡者，多系心脾两虚；入睡后易于惊醒，平时善惊胆怯心悸，易怒，常叹息者，多为心胆气虚或血虚肝旺之不寐。

阴虚火旺不寐的治疗法则，当以滋阴降火安神为主。方选黄连阿胶汤加减。本方由黄连、黄芩、生地、白芍、阿胶、鸡子黄组成。方中黄连、黄芩降火；生地、白芍、阿胶、鸡子黄滋阴。滋阴降火而收安神之功。临床使用时，可再加龟版、龙骨、牡蛎、酸枣仁、夜交藤等，以育阴潜阳、安神镇静。并可常服朱砂安神丸以缓图功效。

（十二）汗证

汗证是指人体阴阳失调，营卫不和，腠理开合不利而引起汗液外泄的病证。汗是人体的生理现象，又是驱邪外出的一种方法。但由于汗液是由水谷精微所化生，是津液的重要组成部分，所以不可过泄。无论因为什么原因，只要引起经常汗出过多，当属病理现常，应积极治疗。

根据汗出的临床表现，一般可分为自汗、盗汗、脱汗、战汗、黄汗等。在平静状态下，时时汗出，动则益甚者自汗；睡中汗出，醒来即止者为盗汗；大汗淋漓或汗出如油，肢冷息微者为脱汗；急性外感热病中突然恶寒战栗而后汗出者为战汗；汗色黄而染衣者为黄汗。

汗证产生的原因很复杂，有因营卫不和，风邪外袭，腠理开泄而致者；有因里热炽盛，迫津外泄而生者；或因湿热薰蒸肝胆，胆汁随汗液外渍而见黄汗者；或阴虚火旺，阴津被扰而外泄者；或因阳气大虚，卫外不固，汗液大泄而见脱汗者；或在急性热病中，正邪相争，寒战汗出而见战汗者。

阴虚火旺汗证，多因大病之后，阴气未复；或恣情纵欲，早婚多育，亡血失精；或肺癆久咳；或因饮食辛辣醇酒、长期服用温燥药物，积成内热，伤损阴血等等，均可导致阴精不足，虚火内生，津液被扰，不能敛藏而外泄作汗。

阴虚火旺汗证，多见盗汗，睡则汗出，醒则汗止，潮热颧红，虚烦不眠，五心烦热，形体消瘦，女子月经不调，男子梦遗失精，舌红少苔，脉细数。

上述脉症产生的机理，不外肾阴不足，虚火内炽，迫津外泄，而见盗汗、潮热颧红、五心烦热；阴虚火旺，热扰神明，则虚烦不眠；阴精衰少，故形体消瘦；阴虚相火妄动，

则女子月经不调、男子梦遗失精；舌红少苔，脉细数为阴虚火旺之象。

阴虚火旺证盗汗，应与心血不足所致盗汗相鉴别。两者均属虚证，但心血不足盗汗，多由劳心过度、或久病血虚使心血耗伤。汗为心液，心血不足，则心气浮越，心液不藏而外泄，故盗汗频作。证见睡则头身汗出，醒则汗出即止，心悸少寐，面色不华，气短神疲，舌淡苔白，脉象虚弱。临证不难区分。

阴虚火汗证盗汗的治疗，应以滋阴降火为主。方剂选当归六黄汤加减。本方由当归、生地黄、熟地黄、黄连、黄芩、黄柏、黄芪组成。方中当归、生地、熟地滋阴养血，取“壮水之主，以制阳光”之意；黄连、黄芩清泄心肺之火，阴虚甚时，用量宜小；黄柏泻相火而坚阴；黄芪益气固表实卫。诸药合用，使阴复而热退，卫强而汗止。本方养阴泻火之力甚强，对于阴虚火旺，中气未伤者甚宜。临床使用时，可加糯稻根、浮小麦以敛汗。如潮热甚者，可加知母、地骨皮、龟版、鳖甲，以滋阴退热。虚烦不眠者，加夜交藤、酸枣仁、知母以清热安神。遗精者加煅龙骨、煅牡蛎以涩精。

（十三）阳强

阳强又称强中或强阳不倒。是指阴茎易举，甚至久举不衰为主要临床表现的病证。本证常与遗精、早泄、消渴等证同时并见。

阳强虽可由肝火内炽、败精瘀阻等引发，但阴虚火旺亦属常见之病因。盖房劳过度，或过服温燥之品，耗劫肾阴，阴虚于内，虚火炽盛，亢阳失制，宗筋过于亢奋，失于柔合而引发是证。

阴虚火旺所致阳强的脉症为，阴茎易举，举而难倒，经交媾即精泄而痿，口干咽燥，五心烦热，腰膝酸软，失眠盗汗，夜寐不宁，遗精早泄，舌红苔少，脉象细数。

以上脉症形成病机是，阴液亏虚，阳气失制，宗筋失柔，过于亢奋，则阳强不倒；精气外泄，则精泄即痿；肾阴不足，虚火内生，则口干咽燥，五心烦热；腰府失养，则腰酸腿软；虚热熏迫，扰动心神，津液外泄，则失眠盗汗，夜寐不宁；阴虚火旺，扰动精室，精关不固，则遗精早泄。舌红苔少，脉象细数为阴虚火旺之征。

本证在临床中应与肝火内炽、败精瘀阻证作出鉴别。前者多表现为阴茎坚举，久久不衰，面红目赤，烦躁易怒，口干口苦，溲赤便干，舌质红，苔黄腻，脉弦数；后者多表现为阳强不倒，交媾之时精不泄出，少腹拘急，苔薄腻，脉弦细。二者均与阴虚火旺者截然不同，不难区分。

阴虚火旺阳强的治疗，当以滋阴补肾，泻火敛阳为法。方用知柏地黄丸、大补阴丸等加减。以使肾水复壮，亢阳有制，相火得以清泻，宗筋亢奋得以消除而病告霍然。否则，单滋其阴，不制其阳，难获速效；只泻其火，不益其阴，病本不除，甚至过用苦燥，再伤阴液，病亦难瘳。若兼欲念无穷，劳心太过者，则加莲子心、炒枣仁、麦冬、黄连以及小量肉桂以清心安神，导龙入海。除药物治疗外，调养也属重要，要断妄想，远房帏，忌食辛辣燥热等。

(十四) 月经先期

月经先期是指月经周期提前七天以上，甚至一月两至者，亦称为“经行先期”，或“经期超前”，古人称为“经早”。如仅超前2~3天，又无其他不适的感觉，不属病

态，若偶而提前七天以上，不作先期论，不必进行调治。本病的产生，主要是因血中实热、气虚不摄及肾阴虚火旺所致。血中实热多因患者素体阳盛，热蕴于内，或过食辛辣，燥热内炽，或过服壮阳之品，热扰冲任，或性情抑郁，肝郁化火以致热伤血络，迫血妄行，经血先期而下。气虚不摄者，多因饮食失调或劳倦过度，以致脾气虚弱，中气不足，失于统摄，月经超前而至。肾阴虚火旺者，多因禀赋素弱或房室不节，肾阴亏损，阴虚火旺，虚火扰动，血海不宁，冲任受损，导致月经先期而行。

肾阴虚火旺所致月经先期，主要症状是经行先期，经量不多，色鲜红，质粘稠，兼有颧红，手足心热，舌红少苔，脉细数等证。

本证因肾阴不足，精血亏耗故经量不多；肾阴虚，阴虚生内热，血得热则妄行，故月经先期；血为热灼，故色鲜红；虚火上炎，故颧红，掌心发热；肾主骨生髓，脑为髓之海，肾虚相髓海不足，故腰酸肢软，头晕耳鸣，足跟痛；舌淡红，少苔，脉细数均为阴虚火旺之象。

肾阴虚火旺所致月经先期应与血分实热，迫血妄行及肝郁化热，火迫血行而致的月经先期相鉴别。血分实热所致月经先期，常常是经量多，质粘稠，并兼有面红口干，脉滑数等证。肝郁化热的月经先期，经量或多或少，色红或紫，挟有瘀块，经行不爽，并兼有乳胀及胁肋胀痛，脉弦数等证，临证当辨之。

治疗本病宜采用滋清热法，以壮水制火。多选用两地汤加减。本方由生地、地骨皮、玄参、麦冬、阿胶、白芍组成。方中生地清热养血，地骨皮清虚热，玄参、麦冬滋阴壮

水，阿胶、白芍养血柔肝。全方达到滋阴清热、壮水以制阳光之效，使阴平阳秘，冲任得以相资，经事如期。临床应用时还可以加侧柏叶、地榆炭、丹皮、旱莲草、龟版等以增强滋阴清热之力。若心烦口干，加知母清热生津。腰膝酸痛，加杜仲、川断、熟地补肾养血。

（十五）经期延长

经期延长是指月经周期基本正常，带经时间比素日延长七天以上，甚至淋漓不净达半月之久，又称“经水不断”或称“经事延长”。若偶尔经期延长，又无所苦，不必治疗。本病的产生，主要是因气虚统血无权及肾阴虚火旺所致。气虚多因素体中气不足，或劳倦伤脾，脾虚失于统摄，冲任不固，而出现经血淋漓不断。经期延长临床上以肾阴虚火旺者多见。肾阴虚火旺者多因素体阴虚或房室不节，或孕育过多，精血耗损，阴虚生内热，血得热则妄动，热扰冲任导致经水不断。

肾阴虚火旺所致经期延长，证见经期延长一周以上，淋漓不净，量少，色红，颧红，手足心热，咽干口燥，舌红少苔，脉细数。

本证的出现是因肾阴亏损，精血匮乏，阴虚火旺，热扰冲任，血海不宁，则经行淋漓难净；阴虚则血少故经量少；火有余则经色红；阴虚阳浮，则两颧潮红，手足心热。阴虚津液不能上承，故见咽干口燥，舌红少苔，脉细数，均为阴虚火旺之象。

本证应与实热而致经期延长及肝郁化火所致经期延长相鉴别。属实热者，往往出现经期延长，经色深红或紫红，质粘稠，或有臭味，并兼有面红心烦，脉滑数。肝郁化热者，

经期延长，经色红或挟有血块，经行不畅，兼有乳胀，心烦易怒等证，脉弦数。临证上易于分辨。

治疗本病宜采用养阴清热之治疗原则，可选用固经丸。本方由黄柏、白芍、龟版，黄芩、椿根皮、香附组成。方中龟版滋肾养血；白芍和营敛阴；黄柏、黄芩清热降火；椿根皮固涩止经；香附行气止痛。全方具有滋阴清热，益肾固经之效。临床运用时可减去香附以防香燥动血。减黄芩苦燥伤阴之品。加生地、地骨皮以养阴清热。加熟地以滋肾养血。亦可加地榆、侧柏炭、旱莲草等清热凉血止血之品。

(十六) 经行发热

经行发热是指月经期间或经行前后有一般性发热（不是高热），有的经净后热退，有的经后仍发热，患者的发热是周期性发作。本证包括在“月经前后诸证”中。凡经行前后及经期出现的一些全身症状，如头痛头晕、烦躁失眠、胸胁胀痛、浮肿腹泻、身痛发热等症，统称为“月经前后诸症”。本名称在古代医籍中未有记载，仅根据不同的症状，分别称为“经行头痛”、“经行身痛”、“经行浮肿”、“经行泄泻”、“经行发热”等。现代医学称为“经前期紧张综合征”。

本病的产生原因很多，归纳起来不外阴虚火旺、肝郁化火、气虚血亏及营卫不和等。阴虚火旺者多因素体阴虚，经行量多，或淋漓不净而致阴血愈感不足，阴虚而生内热则出现经行发热。肝郁化火者多因情绪抑郁，肝失条达，日久化火引起发热。气虚血亏者多因素体气虚，久病或经行量多，导致气血更虚，出现经行发热。营卫不和者因经期阴血下注胞宫，气血失调，营卫不和。卫外不固，感受外邪，邪正相

争而致经行发热。

肾阴虚火旺所致经行发热，患者多形体消瘦，素日低热缠绵，身有微热，经期加重，经量多或淋漓不净，兼有口干咽燥，头晕耳鸣，舌质红或中剥少津，苔薄，脉弦细数。

本证因素体阴虚，阴精不足，阴虚生内热，故平素低热缠绵，经行体温升高；虚热迫血妄行，则经量多或淋漓不断；精血空虚，以致形体日渐消瘦；阴虚津液不足，则口干咽燥；阴虚火旺，虚火上炎故头晕耳鸣；舌质红或中剥少津，苔薄，脉弦细数均为阴虚火旺之征。

肾阴虚火旺所致经行发热当与营卫不和所致的经行发热，以及肝郁化火经行发热相鉴别。营卫失和经行发热多现形寒自汗，头痛身痛，或见咳嗽，流涕，脉浮等证。而肝郁化火经行发热，多见月经量多或淋漓不断，性情抑郁，胸胁胀痛，烦躁口苦，脉弦等证，临证不难区分。

本病的治疗原则宜采用滋阴清热法，选方一阴煎。本方由生地、熟地、麦冬、芍药、甘草、牛膝、丹参组成。方中生地、熟地、麦冬滋阴清热；芍药滋阴柔肝；丹参养血调经；牛膝益肾；甘草调和诸药。本方适用于真阴不足，虚火发热及阴虚动血等证。若阴虚火旺证明显者，去丹参加龟版、元参以滋阴清热。若失眠者，加炒枣仁、夜交藤以安神。经血量多者，加旱莲草、女贞子、生地等以凉血止血。

(十七) 崩漏

阴虚火旺所致崩漏，常常出现不在行经期间，阴道出血量多或淋漓不断，色鲜红，五心烦热，失眠盗汗，腰膝酸软，头晕耳鸣，舌红少苔或无苔，脉细数等证。

本证出现以上症状，是因肾主藏精，肾阴不足，阴虚火

旺，虚热内扰，冲任失调，故出血量多，或淋漓不断，阴虚生内热，血被热灼，故血色鲜红；阴虚不能敛阳，阳浮于外，则见五心烦热，失眠盗汗；肾精不足，则腰膝酸软，头最耳鸣，舌红，少苔或无苔，脉细数，均为阴虚火旺之征。

本证的治疗原则，宜采用滋肾固阴清热法，选方左归丸加减。方中熟地、龟版胶滋肾养阴清虚热，山药、枸杞、菟丝子、山茱萸补肾涩精，鹿角胶补肾填精。临床运用本方时可去川牛膝以防活血、引血下行之弊。加生地、女贞子、旱莲草、白芍以滋肾退虚热。

(十八)胎漏、胎动不安

胎漏是指妇女在怀孕以后，阴道不时少量出血，或时下时止，或淋漓不断，但无腰酸、腰痛、小腹胀坠等现象者。亦称为“漏胎”、“漏胞”。若先感胎动下坠，继而出现腰酸腹胀，或阴道有少许出血者，称为“胎动不安”。现在医学称为“先兆流产”。

本病的产生主要是因血热迫血妄行，或气虚冲任不固，或血虚胎失所养，或肾虚冲任不固，胎失所系，或外伤及冲任，胎元不固不能摄血载胎，或肾阴虚火旺，虚热扰冲任，损伤胎气所致。血热者多因素体肝火旺，或过食辛热之品，以致血分有热，热迫血妄行。气虚者多因素体气虚，中气不足，胎元不固不能载胎而致。血虚者多因平素血虚，胎失血养，不能濡养胎元出现胎漏或胎动不安。肾虚者多因素体肾虚或房劳伤肾，肾气虚不能系胞，则胎不安。或因孕后不慎跌仆损伤直伤冲任。或误服药石毒物，以致冲任受损，胎元不固。亦可导致本病。因肾阴虚火旺而导致胎漏、胎动不安者，多因素体阴虚，受孕之后，阴血下聚血海而养育胎

元，使阴血愈虚。或孕后纵欲过度，或产育众多，肾阴亏损，虚火妄动，下扰血海而导致胎元不固。

阴虚火旺所致胎漏、胎动不安的临床表现是，妊娠后胎漏下血，色鲜红，或胎动下坠，小腹作痛，口干舌燥，头晕耳鸣，腰膝酸软，舌红苔薄而干，脉滑细数。

本证是因肾阴不足，虚火扰动血海，胎元不固，而致妊娠胎漏下血，色鲜红，或胎动下坠，小腹作痛，津液不能上承则口干舌燥，肾阴虚，虚火上炎则头晕耳鸣；肾虚则腰膝酸软，舌红苔薄而干，脉滑细数，均为阴虚火旺之象。

阴虚火旺而致胎漏、胎动不安应与气虚所致胎漏、胎动不安相鉴别。气虚者多见胎动下坠或阴道有滴滴下血，面色萎黄、神疲乏力。甚则腹痛加重，出血量多，其胎欲坠，舌质淡，脉浮滑无力。与阴虚火旺所致胎漏、胎动不安截然不同，临床易于辨别。

本证的治疗原则是滋阴清热，摄血载胎。选方保阴煎加减。本方由生地、山药、芍药、川断、黄芩、黄柏、甘草组成。方中生地、黄芩、黄柏滋阴益肾、清热凉血；芍药和血敛阴；续断止血安胎；山药、甘草健脾益气。全方具有滋阴清热，益肾安胎之效。出血量多者，加贯众炭、棕榈炭、旱莲草、阿胶、仙鹤草等养阴止血之品。可加苧麻根凉血止血并兼有安胎作用。胎动甚者加菟丝子、桑寄生固肾安胎。若腹痛逐渐加剧，阴道出血量增多，应做妇科检查。如已有小产的征象，应立即行清宫术，以防出现大出血，甚至会出现脱证而危及生命。

（十九）妊娠小便淋痛

妊娠期小便频数，淋漓涩痛，甚则点滴难下。小便时有

急迫或涩痛感，为“妊娠小便淋痛”。古称“子淋”，又称“妊娠小便难”。

本证产生的原因很多，主要是膀胱气化不行，因为“膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。”由实热、湿热、阴虚、气虚等因素导致膀胱气化不行，水道不利，则可引起小便淋沥涩痛。实热多因素体阳盛，孕后血以养胎，阴不上承，心阳偏亢，移热于小肠，传入膀胱，或因过食肥甘辛热之品，热蕴于内，引动心火，灼伤津液，则小便淋沥涩痛。湿热多因肝经郁火，湿热下移膀胱，或因摄生不慎，湿热内侵，蕴结下焦，热灼津液，膀胱气化不行，水道不利，则小便淋沥涩痛。阴虚者多因素体阴虚，肾水不足，孕后肾精养胎，阴精愈亏，阴虚火旺，移热于膀胱，灼伤津液，气化不行，水道不利，则小便淋漓涩痛。气虚者多因体质较弱，中气素虚，子宫因孕逐渐增大，胎儿下压膀胱，膀胱受迫，气虚不能约制其水，则小便淋沥不尽。

阴虚火旺所致妊娠小便淋痛，临床上常常出现小便淋沥而痛，量少，色深黄，大便不畅，颧红，心烦不寐，潮热，五心烦热，舌红苔薄黄而干，脉细滑数等证。

阴虚内热，津液亏耗，膀胱不利故小便淋沥而痛，量少，色深黄；津伤肠道失于濡润则大便不畅；虚火上炎故颧红；虚火上扰心神则心烦不寐；阴虚内热，故见潮热、五心烦热。舌红苔薄黄而干，脉细滑数，均为阴虚内热之象。

本证应与实热、湿热、气虚妊娠小便淋痛相鉴别。实热妊娠小便淋痛症见尿少色黄，灼热涩痛，面色垢黄，口干不欲饮。气虚妊娠小便淋痛证见小便淋沥而下，欲解不能控制，解后疼痛，尿量不减，色白，有时淡黄，短气不足以

息。临证当仔细辨认之。

本证的治疗应滋阴、清热、通淋。方用知柏地黄汤加减。方中以六味地黄丸滋养肾阴，知母、黄柏清泻相火。临床使用时，再加麦冬、五味子以滋肾补肺，加车前草以利尿通淋。诸药合用，使肾阴充足，虚火下降，津液来复，膀胱通利，淋痛自愈。

（二十）产后发热

产褥期内产妇持续2天高热，体温至38℃以上，或突然高热，伴有其他症状者，称为“产后发热”。由于产妇在分娩时的创伤和出血，使元气受损，阴血亏耗，腠理不密，营卫失调，易引起各种疾病而导致发热。若产后一、二日，因阴血骤虚，不能敛阳，阳气浮越于外，常有轻微的发热，不属于病态，不必治疗，即可自愈。

本证的产生原因，主要是感受外邪而致发热；或瘀血停留，则为瘀血发热；或失血过多，则为血虚发热；或感染邪毒，营卫失调发热；或饮食不慎，伤食发热；或乳汁蕴结，蒸乳发热以及阴虚火旺，虚火外越而致发热。外感发热多因产后失血伤气，百脉空虚，腠理不密，卫阳不固，以致外邪乘虚而入，邪正相争所致。瘀血发热，多因产后恶露不下，瘀血内阻，脉络不宜，阻碍气机，营卫不调，阴阳不和故乍热乍寒，所谓“败血为病，乃生寒热”。血虚发热，多因平素血虚，分娩时出血过多，阴血暴虚，阳无所附，以致阳浮于外而发热。食滞发热，多因产后饮食不慎，过食油腻，饮食停滞于胃，阳明经气不得宣泄，郁而化热，邪热熏蒸外泄则出现肌肤发热。蒸乳发热，多因乳汁不通，气机失宣，脉络受阻，乳汁蕴结而化热。阴虚发热，多因产时元阴受损，

肾阴不足，虚火外浮而致发热。

阴虚火旺所致产后发热，临床上多见身有微热，无恶寒，午后热甚体温达38℃两天以上，兼见两颧红赤，口渴喜冷饮，大便干燥，小便短赤，舌质红，苔薄黄而干，脉细数等证。

产妇因素自阴虚，产时又失血，元阴亏损，虚火外浮，故见身有微热，午后热甚，因无外邪故无外寒，阴虚火旺，虚火上炎则两颧红赤，口渴喜冷饮，阴虚津少故大便干燥，小便短赤，舌质红，苔薄黄而干，脉细数，均为阴虚火旺之征。

本证应与瘀血发热及外感发热和感染邪毒发热相鉴别。瘀血发热多有恶露紫暗，量少有块，小腹疼痛拒按，口燥不欲水。外感发热多见恶寒发热，身痛头疼，脉浮。感染邪毒发热可见高热寒战，小腹疼痛拒按，恶露量或多或少，色紫暗发黑，有臭味，临证不难辨别。

治疗本证宜采用滋阴养血，清热退蒸之法，选方一阴煎。可加银柴胡，青蒿，鳖甲增强其滋阴清热之功。

（二十一）阴痒

阴痒是妇科常见的一种症状，是指妇女外阴及阴道内瘙痒，甚则痒痛难忍，坐卧不安，有时波及到肛门周围，或伴有不同程度的带下，严重地影响了妇女的工作和生活。亦称为“阴门瘙痒”、“阴蠹”、“阴蚀”等。现代医学称为“外阴瘙痒症”。如患外阴炎、阴道炎因分泌物刺激或因患糖尿病，维生素甲、乙缺乏症，卵巢功能低下，外阴白斑等均可引起阴痒。祖国医学认为本症的原因与风和虫有关。因为“风盛则痒”、“虫动则痒”。而引起风盛的原因主要在

肝，因肝藏血，如情志抑郁，肝郁化火，火盛伤阴，致会血燥生风，或是平素肾阴不足，水不涵木，精血两亏，血虚生风，致血燥风动，肌肤失濡，因而瘙痒无度；如嗜食辛辣肥甘，湿热偏盛，湿热下注前阴，久则因湿热蒸腐而生虫，虫动则外阴瘙痒；也有因忽视前阴卫生，感染病虫，虫蚀作痒。

阴虚火旺所致阴痒，临床上常出现阴部干涩，灼热瘙痒，夜间加剧，五心烦热，口干不欲饮，时有烘热汗出，头晕耳鸣，腰酸痛，舌红少苔，脉细数等症。

肾阴亏虚，水不涵木，而致精血不足，血虚生风化燥，外阴脉络失濡则阴部干涩，灼热瘙痒，夜间加剧，病程日久，皮肤干燥或粗糙；阴虚阳亢则五心烦热，口干不欲饮，时有烘热汗出；精血不足，清窍失养，则头晕耳鸣；肾虚则腰酸痛，舌红少苔，脉细数，均为肾阴虚火旺之象。

阴虚火旺所致阴痒应与湿热阴痒相鉴别。湿热阴痒往往表现为外阴瘙痒，甚至疼痛，坐卧不安，带下量多，色黄如米泔，或为黄水，其气臭秽，兼有头晕心烦，口苦胸闷，二者临证不难鉴别。

本证的治疗宜采用滋肾降火，调补肝肾之法。选方知柏地黄汤加减。方中生地、丹皮、知母、黄柏滋阴降火；山茱萸、山药调补肝肾；茯苓、泽泻利湿。可酌加当归、白藓皮、防风、苡乌等，以养血祛风。兼有湿毒内侵，带下量多，色黄而秽臭者，可加土茯苓、白花蛇舌草、蒲公英、败酱草等，以清热解毒。为了提高疗效，可配合应用外阴薰洗剂，如用蛇床子、川椒、百部、苦参、白藓皮、蝉退等水煎，先熏后洗一日2~3次。

在治疗过程当中，要保持外阴干燥，清洁，避免用刺激性强的药物及碱性强的肥皂洗浴外阴。忌食辛辣香燥，及醇酒厚味。均有利于本症的治疗。

八、阴 阳 两 虚

肾为先天之本，藏真阴而寓元阳。若肾中元阳不足，命门火衰与肾中元阴不足，阴精亏乏并见，即为肾阴阳两虚证。临床上可由肾阴先虚，阴损及阳发展而来；或由肾阳不足，阳损及阴，日久而成。凡能引起肾阳虚、肾阴虚的病因，皆能发展成为阴阳两虚，常见的原因如：禀赋不足、久病不愈、房劳所伤、年老体衰等。其症候特点是虚证与热证、寒证同时并存。

阴阳两虚的临床表现更加复杂，其中包括肾虚的共有脉症，如腰膝酸软、腰痛、耳鸣失聪、健忘、性功能改变、牙齿松动、发焦脱落、尺脉无力等。同时兼见肾阴虚之潮热颧红、五心烦热、口干咽燥、盗汗、梦遗、眩晕耳鸣、失眠多梦、舌红少苔、脉细或细数等；肾阳虚之恶寒肢冷、性欲衰退、阳痿早泄、遗精滑精、小便频数、夜尿增多，小便失禁，或尿少、浮肿，动则气喘、五更泄泻、男子不育、女子不孕、舌淡胖嫩、苔白、脉沉细、沉迟等。以上脉证的产生，不外肾失温煦、功能衰退；阴失滋润、濡养不足；甚至出现肾气不固、肾不纳气、肾虚水泛、阴虚火旺所致。

肾阴阳两虚证的诊断，除根据伤肾的病史，以及能确定病位的症状外，还应同时见有阴虚有热和阳虚寒盛的症状，方可确诊。

在治疗上，因精气两伤，故阴阳并补。一方面“益火之源，以消阴翳”，一方面“壮水之主，以制阳光”。方剂可用左归丸合右归丸、地黄饮子、龟鹿二仙胶等加减。

肾阴阳两虚常见病证有：消渴、腰痛、肺癆、水肿、痿证、遗精、眩晕、月经不调、崩漏、绝经前后诸症等。

（一）肺癆

肺癆是一种具有传染性的慢性虚弱疾病。肾阴阳两虚是肺癆发展的最后阶段，为少见证候。肺癆在发病的初期，由于癆虫侵蚀肺系，耗伤阴血，肺失滋养表现为肺阴不足。继则肺虚不能输布津液，肾失滋生之源，则病及于肾，即母病及子。肾阴亏损，表现为阴虚火旺之证。或肺虚在发展过程中，耗夺母气以自养，即所谓子夺母气，出现气阴两虚的证候。最后肺癆日久不愈，元气耗损，阴损及阳，出现阴阳两虚的证候。虽然肺癆在整个过程中，以阴虚为主，但晚期是可以出现阴阳两虚证候的。临床上不可忽视。

肺癆的阴阳两虚证主要临床表现是，咳嗽无力，咳声低微，反复咳血，声音嘶哑，甚至失音，劳热骨蒸，面色苍白，形体骨瘦如柴，恶寒肢冷，形寒畏风，面目虚浮，四肢浮肿，自汗盗汗，喘息气短，神疲体倦，饮食减少，夜尿频频，大便溏薄，五更泄泻，男子滑精、阳痿，女子经少、经闭，舌质淡，舌体胖大，有齿痕，舌苔白，脉象虚弱或微细或沉迟。

上述诸症的产生多因肺癆日久，阴损及阳，出现阴阳两虚，肺脾肾三脏俱损的证候。癆热骨蒸、盗汗为阴虚生内热之证；咳嗽咯血，耗伤肺阴，声道失润，则金碎不鸣而声音嘶哑，甚至失音；肾阳不足则恶寒肢冷，五更泄泻，夜尿频

频，脾肾阳虚则见面目虚浮，四肢浮肿，神疲体倦，饮食减少，大便溏薄；肺肾气虚则见喘息气短，自汗出，形寒恶风，元气衰败则见形体羸瘦，男子滑精、阳痿及女子经少、经闭等证。

本证的治疗应采用温补元阳，填补精血，阴阳并补之法。方剂选用拯阳理劳汤加减。原方由人参、黄芪、白术、肉桂、五味子、当归、陈皮、生姜、大枣等组成。方中肉桂温补肾阳，五味子滋肾纳气，人参、黄芪、白术、甘草、陈皮、当归、生姜、大枣等健脾益气养血。临床使用时可以再加炙附子、巴戟天以增强温补肾阳的功能。如精血亏甚者，可酌加紫河车、龟版胶、鹿角胶、冬虫夏草等血肉有情之品以填补精血。五更泄泻者，加肉豆蔻、吴茱萸、破故纸以温补脾肾，固肠止泻。如阴阳两虚而偏于阴虚，舌尖红少津者，可改用保真汤加减。方中人参、黄芪、白术、甘草补阳益气，调理脾胃，以滋后天之化源；麦冬、天冬、生地、熟地、当归、白芍、五味子以育阴养荣，填补精血；柴胡、地骨皮、黄柏、知母、莲子心以滋阴退热。

（二）水肿

水肿或称浮肿，是指体内水湿潴留，泛滥肌肤，引起头面、眼睑、四肢、腹背甚至全身浮肿的一类病证。人体水液的运行，有赖于脏腑的气化，特别是肺气的通调，脾气的转输，肾气的温化，以及三焦的决渎，膀胱的气化共同完成。若因风邪外袭，肺气不宣，不能通畅水道，下输膀胱；或水湿内侵，脾不健运，水湿不得运行；或劳倦太过，饮食不节，脾气亏虚，水湿停聚；或生育不节，房劳过度，肾气内伤，不能化气行水，均可导致水湿潴聚于肌肤，而发为水

肿。

在水肿的形成过程中，就脏腑而言，与肺、脾、肾三脏功能的不足和失调密切相关。其中以肾为本，以肺为标，以脾为制。肾者主水，又主气化，为人体调节水液的主要脏器。若肾阳不足，阳衰阴盛，气化不行，开合不利，阳虚水泛，溢于肌肤而为肾阳衰微的阴水证。若久病阳虚未复，阳损及阴，或过用辛燥渗利之品伤阴，均可导致肾阴阳两虚之水肿证。

阴阳两虚水肿证的临床表现，一方面证见全身浮肿，腰以下为甚，两侧足跗尤剧，按之凹陷不起，面色灰滞或苍白，四肢不温，甚至厥冷，畏寒神疲，腰部冷痛酸重，尿少色清，或夜尿频频，阴囊冷湿，舌淡胖，苔白，脉沉细或沉迟等肾阳衰微，水湿内盛之证。又兼见精神疲倦，头晕耳鸣，腰痛遗精，牙龈出血等阴虚不能敛阳，虚阳扰动之证。

阴阳两虚水肿证的治疗法则，当以补肾阳，滋肾阴，兼利小便以去水湿为主。方剂选大补元煎合济生肾气丸同时并进。方中以附子、桂枝（或用肉桂）、杜仲、人参温阳益气；地黄、山茱萸、山药、枸杞、当归、牛膝滋阴养血；茯苓、泽泻、车前子利水消肿；丹皮清热凉血；甘草调和诸药。共同起到并补肾中阴阳，利水消肿的作用。

（三）消渴

消渴是以多饮、多食、多尿、身体消瘦或尿有甜味为特征的病证。其发病因素多与饮食不节、情志失调、房劳伤肾、先天禀赋不足，或过食温燥药物有关。本病的基本病理，在于阴津亏损，燥热偏盛。消渴辨证，古今医家多采用三消分证。根据多饮、多食、多尿轻重主次不同分为上、中、

下三消。对于三消之间的关系，认为上轻、中重、下危，**上中不甚，则不传于下**。下消为上中消传变的结果。消渴病变的部位与五脏均有关，但主要在肺、脾（胃）、肾三脏，其中以肾最为重要。《石室秘录·卷六·内伤门》说：“消渴之证，虽分上中下，而以肾虚致渴，则无不同也。”

肾虚所以导致消渴的发生，是因肾主一身之元阳元阴，三焦脏腑皆囿乎天一真水之中。若先天禀赋不足，肾阴素亏，或后天房室不节，阴精亏损，或年老阴衰，或过食温燥药物，均可导致肾水衰少，元阴不足，水不济火，虚火上炎，则为消渴。或下焦命火不归元，游于肺则为上消，游于胃则为中消，固摄失权、精微下泄，则为下消。若肾中命门火衰，肾阳不足。无以化气上升，津液不布，则口渴多饮。肾气虚，摄纳不固，约束无权则多尿，肾阳不升，不能上蒸谷气，而尽下为小便，故尿甜或如脂如膏。

肾阴阳两虚消渴证，属下消范畴。一般病程较久，多由肺胃燥热，肾阴亏虚之证演变而来。其临床表现比较复杂，主要症状有：小便频数量多，尿混浊如脂膏，甚至饮一溲一，手足心热，咽干舌燥，面容憔悴，耳轮干枯，面色黧黑，腰膝酸软乏力，四肢欠温，畏寒怕冷，甚至阳痿，舌淡苔白而干，脉沉细无力。

本证之所以出现上述脉症，总括病机概为肾阴亏虚，肾阳虚衰。消渴日久，阴损及阳，或因治疗失当，过用苦寒伤阳，终成阴阳两亏之证。既见手足心热，咽干舌燥，面容憔悴等阴亏之证，又有四肢欠温，畏寒怕冷，甚至阳痿等阳虚之证。水谷精微随尿液下注，无以薰肤充身，故面色黧黑，耳轮焦干，舌淡苔白而干，脉沉细无力，为肾阴阳两虚之

象。

消渴阴阳两虚证的治疗法则，以温阳滋阴补肾为主。方剂选用《金匱》肾气丸加减。本方以六味地黄丸滋阴补肾，并用附子、桂枝温阳暖肾，意在微微生火，以鼓舞肾气，取“少火生气”之义。方中补阳药与补阴药并用，即《景岳全书·新方八阵略》所说：“善补阳者，必于阴中求阳，则阳得阴助而生化无穷；善补阴者，必于阳中求阴，则阴得阳升而泉源不竭。”临床使用时多去掉凉血之品丹皮，加补骨脂、肉苁蓉以补肾阳，或加制首乌、怀牛膝以滋阴补肾，或加五味子、复盆子、桑螵蛸、金樱子等补肾涩精。若手足厥冷，体温下降，可加鹿茸粉、黄芪、人参以温阳益气救逆。若精神恍惚，加菖蒲、远志以醒神开窍。若阳痿明显者，可加胡芦巴、巴戟天等以壮阳。若阴阳气血俱虚，亦可改用鹿茸丸加减。

（四）遗精

肾阴阳两虚证遗精，一般为久病遗精，先肾阴不足，遗精无度，阴损及阳，发展为阴阳两虚。临床表现除遗精频作，头晕耳鸣，精神萎靡，形瘦气弱，疲倦乏力，腰膝酸软等肾气不足证外，同时见精滑无度，精冷清稀，阳痿早泄，恶寒肢冷，面白少华，口鼻气清，唇淡口和，舌淡胖润，脉沉细无力，或沉迟等肾阳虚衰之证；以及滑泄不禁，潮热骨蒸，虚烦不眠，五心烦热，骨蒸无力，颧红面赤，口燥咽干，舌红少苔，脉细数无力等肾水不足，真阴亏损，阴虚火旺之证。阴阳两虚遗精患者，不必悉具上述所有症状。只要有一，久病的病史；二，遗精频作，甚至滑精；三，兼一般肾阴、阳两虚的证候，即可确诊。证之临床，肾阴阳两虚遗

精者，可有偏于肾阴虚或肾阳虚的不同。

阴阳两虚遗精证的治疗，当滋阴壮阳，补肾固精。方刻选用右归丸合六味地黄丸，并送服金锁固精丸。以右归丸温补肾阳，六味地黄丸滋养肾阴，金锁固精丸收涩固精。金锁固精丸由沙苑蒺藜、芡实、莲须、龙骨、牡蛎、莲子等组成。方中沙苑蒺藜补肾益精，莲须、芡实、龙骨、牡蛎固肾涩精，莲子养心宁神。

(五) 腰痛

肾虚腰痛多因患者素体禀赋不足，加之劳累太过，或久病体虚，或因年老肾气衰减，或房劳过度，以致肾阴耗伤，无以濡养经脉而发生腰痛。或肾阳虚衰，腰府失于温养，也可造成腰痛。

肾虚腰痛的常见证候，虽可单独出现肾阴虚证，或肾阳虚证，但日久不论是阴损及阳，还是阳损及阴，最终导致肾阴阳两虚腰痛。

阴阳两虚腰痛的临床表现是，腰部酸痛，喜按喜揉，腿膝乏力，劳累后疼痛加重，卧则减轻，经常反复发作，偏阳虚者，兼见面色苍白，腰部觉冷，四肢不温，少腹拘急，小便频数，大便溏薄，舌淡胖，苔薄白，脉象沉细等证；偏阴虚者，兼见头晕，目眩，耳鸣，口燥咽干，面色潮红，心烦失眠，手足心热，舌红少苔，脉象弦细数等。

上述症状产生的主要机理，在于肾虚。腰为肾府，肾主骨髓，肾精亏虚，骨髓不充，故腰酸痛而腿膝乏力；病属虚证，故喜按喜揉，劳则气耗，故遇劳更甚，卧则减轻；阳虚不能营筋，则少腹拘急；阳虚不能温养四肢及肾府，故腰部觉冷，四肢不温，面色苍白，下元不固，则小便频数；肾阴

虚衰，不能温养脾胃，运化失常，故大便溏薄，舌淡胖，苔薄白，脉沉细皆为阳虚有寒之征。肾阴不足，虚火上炎，则头晕，目眩，耳鸣，心烦失眠，口燥咽干，面色潮红，手足心热，舌红少苔，脉弦细数，为阴虚有热之征。

阴阳两虚腰痛的治疗法则，当以补肾为主，肾阳虚者治以温肾壮阳，肾阴虚者治以滋肾益阴，肾阴阳两虚者，则阴阳并补。常用代表方剂，偏阳虚者，可用右归丸加减；偏阴虚者，可用左归丸加减；阴阳两虚者，病情复杂，可选用杜仲丸加减。本方由杜仲、破故纸、枸杞子、龟版、黄柏、知母、五味子、芍药、当归、黄芪等组成。方中以杜仲、破故纸温肾，温而不燥；枸杞、龟版滋养肾阴，润而不膩；五味子、芍药养肝肾；黄芪、当归补气血；知母、黄柏清相火。面面俱到，是治疗阴阳两虚腰痛之佳方。

(六) 眩晕

肾阴阳两虚眩晕，多在肾精不足、阴虚火旺、肾阳衰微的基础上，进一步发展而成。发病原因不外先天不足、年老肾衰、房劳过度等。发病机理是由肾精不足，髓海空虚与阴虚火旺上扰清空和肾阳虚衰，脑失温养共同形成。

阴阳两虚眩晕是比较少见的一种证候，其临床表现为眩晕，精神萎靡，耳鸣健忘，发落齿摇，腰膝酸软，遗精滑泄，头痛失眠，颧红咽干，形体消瘦，五心烦热，面色苍白或黧黑，形寒肢冷，阳痿早泄，舌质或嫩红或淡嫩，少苔或苔白，脉细数或沉细尺弱。

阴阳两虚眩晕证的表现比较复杂，肾精不足、阴虚火旺、肾阳衰微证同时并见。除眩晕主症外，肾精不足则精神萎靡、腰膝酸软、牙齿动摇、耳鸣健忘；肾其华在发，肾精

亏虚，故发易脱落；肾虚封藏不固或阴虚火旺，扰动精室，故遗精滑泄；肾阴不足，虚热内生，故头痛失眠、颧红咽干、形体消瘦、五心烦热、舌嫩红少苔、脉细数；肾阳衰微，故面色黧黑或㿗白、形寒肢冷、阳痿早泄、舌淡嫩苔白、脉沉细无力。

本证的治疗，以滋阴助阳、补肾益精为主。方剂选左归丸合右归丸加减。方中肉桂、附子、杜仲、菟丝子温补肾阳；熟地、山茱萸、山药、枸杞、龟板胶、牛膝补益肾阴；鹿角胶填精补髓，当归养血。临床使用时因附子、肉桂辛热刚燥，不可久服，可改用巴戟天、仙灵脾等温润之品，助阳而不伤阴。眩晕较甚者，加龙骨、牡蛎、磁石以潜浮阳。

（七）月经先后无定期

月经不按周期来潮，有时提前，有时错后，临床称为“月经先后无定期”，又叫“月经愆期”，是一种常见的月经病。本病的产生归纳为脾虚、肾虚、肝郁、血瘀四种类型。脾虚者多因中气不足，或劳倦过度，耗伤中气，使脾虚不能化生气血、血海不能按时满盈，或满溢失度则致本证。肾虚者多因先天肾气不足，或后天房室不节，或产孕过多，损伤肾气，致使闭藏失职，血海蓄溢失常，而致经期或前或后。肝郁者因情志抑郁，或忿怒伤肝，使肝气逆乱，冲任失调，血海蓄溢失常而致本证。血瘀者多因在经期或产后，感受寒凉，或情志抑郁，气机不畅，气滞则血瘀，胞脉阻滞，出现经血不能如期而至，或前或后而致月经先后无定期。

肾阴阳两虚所致月经先后无定期，主要临床症状是月经量少、色淡、头晕耳鸣、手足心热、口干咽燥、腰酸如折，或小便空坠、夜尿多、大便不实、舌淡苔薄白，脉沉弱等。

本证因肾阴两虚，肾精不足，封藏失职所致。肾精不足，血海空虚则月经后期，闭藏无能则月经先期；肾气虚，腰为肾之府，则腰酸如折，并见小便空坠、夜尿多；肾阴虚则命门火旺，出现头昏耳鸣，手足心热，口干咽燥；肾阳虚则命门火衰故大便不实、舌淡苔薄白，脉沉弱。

本证应与肝郁所致月经先期或后期鉴别。肝郁者精神抑郁，时时叹息，胸闷不舒，乳房、小腹、两胁胀痛，而且胀甚于痛。临床不难区分。

本证的治疗宜采用滋阴壮阳、调补冲任之法。方选用固阴煎加肉桂、补骨脂。本方由人参、五味子、熟地、山药、山茱萸、菟丝子、炙甘草、远志组成。方中熟地、山药、山茱萸养肾阴；菟丝子、肉桂、补骨脂温肾阳；人参、甘草益气健脾；五味子、远志交通心肾。

(八) 崩漏

肾阴阳两虚所致崩漏，在临来或来后为出血量可多可少，色较淡，腰酸膝软，形寒畏冷，手足心热，口干心烦，舌淡红少苔，脉细无力等征。

以上诸证的出现是因肾阴阳两虚，肾阳虚，命门火衰，不能温养冲任，使精血不得固摄，则冲任经量增多；肾阴虚火旺，精亏液耗，精血枯涸，则经量减少，故本证多见出血量可多可少、色较淡；又因肾虚冲任不固，多伴有肾虚髓海不足，外府失荣则为头晕耳鸣、腰膝酸软等证；形寒畏冷，手足心热，口干心烦，舌淡红少苔，脉细无力均为肾阴阳两虚之征。

本证的治疗宜采用补阳益阴之法。方选右归丸与左归丸合方。方中熟附子、肉桂、菟丝子、杜仲、鹿角胶温补肾

阳，熟地、山茱萸、山药、枸杞子、龟版胶、牛膝滋养肾阴；当归补血。临床使用时再加棕榈炭、艾炭、煨龙骨、煨牡蛎以收敛止血。若偏阳虚者，可加巴戟天、仙灵脾以温阳补肾。偏阴虚者，可加生地、旱莲草、阿胶以滋阴补肾。

（九）绝经前后诸症

肾阴阳两虚而致绝经前后诸症在临床上多表现为头晕目眩，潮热多汗，五心烦热，口干便秘，尿少色黄或量多色淡、懒言气短，畏寒怕冷，纳谷不香，大便溏薄，小溲清长，神疲倦怠，月经紊乱，量少色紫红或量多色淡。偏肾阴虚者舌质偏红少苔，脉细数。偏于肾阳虚者舌质偏淡，体胖边有齿痕，苔薄，脉沉细。

上述诸症的出现总归肾阴阳两虚所致。头晕目眩，潮热多汗，五心烦热，口干便秘，尿少色黄，经量少色紫红均为肾阴虚，虚火上炎，精液亏损而致；懒言气短，畏寒怕冷，纳谷不香，大便溏薄，小溲清长，神疲倦怠，月经量多色淡均为肾阳虚衰，经脉失于温煦，脾阳不振而致。

本证的治疗宜选用调补阴阳之法。选方二仙汤加减。本方由知母、黄柏、仙茅、仙灵脾、当归、巴戟天组成。方中仙茅、仙灵脾、巴戟天温补肾阳；知母、黄柏滋阴降火，当归养血。

九、肝 肾 阴 虚

肾阴虚证与肝阴虚证同时并见症，称为肝肾阴虚证。肾属水，肝属木。根据五行学说，肾水与肝木之间是母子关系。肾藏精，肝藏血，肝之阴血有赖于肾中阴精的滋养；肾

之阴精也不断得到肝血所化生阴精的填育。在病理上，两者关系也很密切，肾阴与肝阴之间亦互相影响。若肾阴亏损，母病及子，肾水不能涵养肝木，导致肝阴(血)不足。相反，肝阴不足，子盗母气，肝病及肾，使肾阴亦亏。由于肝肾两脏常是盛则同盛，衰则同衰，故有“肝肾同源”之称，又称“乙癸同源”，肝肾阴虚证常见头晕目眩，头胀头痛，视物不清，两目干涩，耳鸣健忘，咽干口燥，五心烦热，遗精，腰肢酸软，肢体麻木，抽搐，痿软无力，月经不调，经行腹痛，舌红无苔，脉细等。多见有阴虚内热的病变特点。治疗当肝肾同治，滋水涵木，滋肾养肝。常见病证如眩晕、头痛、耳鸣耳聋，中风、痫证、痿证、痹证、痛经、绝经前后诸症等。临床上肝肾阴虚证，有因肝病及肾和肾病及肝的不同，本篇重点讨论肾病及肝者。

(一) 痫证

痫证是一种发作性神志异常的疾病，其典型发作的特征为突然仆倒，昏不知人，口吐涎沫，两目上视，四肢抽搐，或喉中发出如猪、羊等叫声，移时苏醒，醒后除疲乏无力外，饮食起居如常人。时发时止，发无定时。非典型轻症患者，仅表现为瞬间的神志模糊，或短暂目睛直视，一时性失神，或口角牵动，吮嘴等动作。又称“癫痫”、或“羊痫风”。

痫证发生的原因，有先天因素和后天因素的不同。先天因素主要指胎儿在母腹中时，母体突受惊恐；后天因素与七情失调、饮食不节，房劳过度、感受外邪有关。以上诸因，导致肝脾肾功能失调，产生风、火、痰、气等病理改变，其中以痰为主。影响到心，蒙闭心神，闭塞清窍，壅塞经络，发

为痛证。

肝肾阴虚为痛证产生的常见原因，亦是久患痛证的归宿之一。先天禀赋不足，肝肾阴血亏虚；或胎儿在母腹中，突受惊恐，“恐则精却”，导致精伤而肾亏；或后天房室不节，使肾阴不足。肝肾阴虚，水不涵木，虚阳上浮，肝风内动，水不济火，心火亢盛，炼液成痰，肝风挟痰火，上扰神明，阴闭心窍，发为本证。久患痛证，风阳扰动，耗伤肝肾之阴，使痛证发作更趋频繁。

肝肾阴虚所致痛证的脉症为，痛证发作频繁，日久不愈，发作以后或平素神思恍惚，头晕耳鸣，健忘，腰膝酸软，足跟痛，或遗精阳痿早泄，或大便秘结，甚或智力减退，舌红少苔，脉细数。

以上脉症形成的病机是，肝肾阴虚，阴虚阳亢，肝风内动，挟痰火上蒙清窍，发为痛证；痛证频发，风阳扰动，肝肾更亏，肾精不足髓海失养，可见神思恍惚，健忘；肝血不足，血虚肝旺故头晕耳鸣；肾虚精亏，故腰膝酸软、足跟痛，遗精阳痿早泄，智力减退；阴液既亏，大肠失润则便秘；舌红少苔，脉细数，为肝肾阴虚，阴虚内热之征。

本证在临床中应与肝风痰浊、肝火痰热证相鉴别。前者痛证发作时，口吐白沫或清涎，发作前常有眩晕，胸闷，乏力等症，舌苔白腻，脉弦滑；后者痛证发作时，口吐粘涎，发作前性情急躁，心烦失眠，咯痰不爽，口苦而干，便秘，舌红苔黄腻，脉弦滑数。两者均与肝肾阴虚者截然不同，不难区分。

肝肾阴虚痛证的治疗，当以滋养肝肾，潜阳安神为法。方用左归丸加减。方中熟地、山药、山茱萸、枸杞、龟版

胶、牛膝滋补肝肾、菟丝子、鹿角胶补肾填精。临床使用时再造加牡蛎、鳖甲以滋阴潜阳，柏子仁、酸枣仁、磁石、朱砂以宁心安神，贝母、天竺黄、竹茹以清热除痰。如心中烦热者，加山栀子、莲子心以清心除烦。大便秘结者，加元参、火麻仁以滋阴润便。痛证日久，阴精气血俱虚者，常服河车大造丸以大补精血，益气养神，减少发作。

（二）痿证

痿证是指肢体筋脉弛缓，软弱无力，日久因不能随意运动而致肌肉萎缩的一种病证。临床上以下肢痿弱，较为多见，故有“痿躄”之称。根据发病原因、部位及临床表现不同，又有皮痿、肌痿、筋痿、肉痿、骨痿等“五痿”之称。

痿证的发生，多见于温热病中或热病后期，邪热灼伤津液，筋脉失于濡养；或因湿热浸淫筋脉肌肉，而弛缓不用；或因体虚久病，肝肾阴虚，肌肉筋骨失养；或瘀阻脉络等因而成。临床亦有因脾胃素虚，或饮食不节，劳倦太过，或因病致虚，运化失常，气血不足，肌肉筋脉失养，而成痿证者。

肝肾阴虚是痿证发生的常见病因，肝藏血，主筋，为罢极之本；肾藏精，主骨，为作强之官。肝肾功能正常，精血充足旺盛，则筋骨坚强，活动自如。如久病体虚，肝肾不足，或房劳太过，伤及肝肾，或情志所伤，肝肾亏耗，均可导致精血亏损，精亏则不能灌溉，血虚则不能营养，复因阴虚内热，更加灼液伤津，筋骨经脉失其濡养，发为痿证。

肝肾阴虚所致痿证的临床表现为，起病缓慢，双侧或一侧下肢感觉障碍，或痛觉消失，腿胫大肉渐脱，膝胫痿弱不能久立，甚至步履全废，腰脊酸软，并有眩晕，耳鸣，遗精或遗尿，或月经不调，舌红少苔，脉细数。

以上脉症形成的病机是，肝肾阴虚，精血不能濡养肌肉筋骨，故渐成痿证；腰为肾之府，肾主骨，精髓不足，腰脊失养，故见腰脊酸软；肝肾阴虚，水亏木旺，故眩晕耳鸣；肾虚不藏，故见遗精；肾与膀胱相表里，肾虚则膀胱不约而遗尿；肝肾亏虚，冲任失调，故见月经不调；舌红少苔，脉细数，为阴虚内热之象。

肝肾阴虚痿证应与脾胃虚弱痿证相鉴别。二者同属痿之虚证，但证候表现不同。脾胃虚弱者，肢体痿软无力，逐渐加重，甚至肌肉萎缩，纳呆，腹胀，便溏，面浮而色不华，神疲乏力，舌淡苔白，脉细无力，临证应注意予区分。

肝肾阴虚痿证的治疗，当以补益肝肾，滋阴清热为法。方用虎潜丸加减。本方由龟版、黄柏、知母、熟地、当归、白芍、锁阳、陈皮、虎骨、牛膝组成。方中虎骨、牛膝壮筋骨，锁阳温肾益精，当归、白芍养血柔肝，熟地、龟版、知母、黄柏滋阴清热，陈皮理气醒脾，干姜辛温，温通行气。本方为肝肾阴虚痿证而设，其中锁阳、干姜意为阳中求阴，以阳生阴长，如热邪偏盛，当减去不用，并加入元参、山药以养阴清热。若兼见面色萎黄，心悸怔忡，舌淡红，脉细弱等气血两虚证者，酌加黄芪、党参、鸡血藤以补养气血。若久病阴损及阳，证见恶寒肢冷，阳痿，小便清长，舌淡，脉沉细无力者，去知母、黄柏，酌加鹿角片、补骨脂、仙灵脾、巴戟天、肉桂等以补肾壮阳。

（三）痹证

痹是闭阻不通之意。痹证是指气血被病邪阻闭而引起的疾病。凡人体肌表经络遭受风寒湿邪侵袭后，使气血运行不畅，引起筋骨、肌肉、关节等处的疼痛、酸楚、麻木、重着

和关节肿大屈伸不利等症，统称为痹证。临床上具有渐进性或反复发作的特点。根据发病部位的不同，而有“皮痹”、“脉痹”、“肉痹”、“筋痹”、“骨痹”等五痹之称。根据发病原因不同，又有“行痹”、“着痹”、“痛痹”、“热痹”之称。痹证日久不愈，可进一步发展，侵入五脏，形成五脏痹证。

痹证发生原因为素体虚弱，卫阳不固，风寒湿热之邪，乘虚侵袭人体，流注经络关节，气血运行不畅，筋脉阻滞；或痰浊瘀血，阻于经隧，深入关节筋脉；或素体阳盛，或肝肾阴虚复感外邪，皆可发病。其主要病机是气血痹阻不通，筋脉关节失于濡养所致。

肝肾阴虚是本病重要的内在因素。七情六欲，房室不节，精血耗伤，或久病阴虚，肝肾不足，或长期过用温燥，损伤肝肾之阴，使筋骨失于濡养而发为本病。

肝肾阴虚所致痹证属虚痹范畴。其临床表现为，痹证日久不愈，骨节疼痛，筋脉拘急牵引，活动时加重，头晕耳鸣，面赤火升，五心烦热，或持续低热，日晡潮热，盗汗，口干，神疲乏力，腰膝酸软，关节或见红肿灼热，或变形，不可屈伸，日轻夜重，舌红少苔，脉细数。

以上脉症形成的病机是，肝主筋，肾主骨，肝肾阴虚，筋骨失养，则骨节疼痛，日久不愈；血虚生风，则筋脉拘急牵引；阴虚阳亢，则头晕耳鸣，面赤火升；阴虚生内热，则见五心烦热，低热缠绵，口干，盗汗，关节红肿灼热；肝肾精血不足，则腰膝酸软，神疲乏力；舌红少苔，脉细数均为肝肾阴虚，阴虚火旺之象。

肝肾阴虚痹证的治疗，以滋养肝肾为主。方用独活寄生

汤加减。本方由独活、桑寄生、秦艽、防风、细辛、当归、白芍、川芎、地黄、杜仲、牛膝、人参、茯苓、甘草、桂心组成。方中以地黄、杜仲、寄生、牛膝补益肝肾，强壮筋骨；当归、白芍、川芎养血和营；人参、茯苓、甘草益气扶脾；独活、防风、秦艽祛风胜湿；细辛、桂心温经散寒。本证阴虚内热，故临证减细辛、桂心之温燥，加枸杞、石斛、续断、木瓜、首乌以增强补益肝肾之功。兼阴虚阳亢者，加石决明、牡蛎、钩藤以平肝潜阳。关节疼痛者，加鸡血藤、丹参以活血通络。

（四）痛经

痛经是妇女在行经前后，或正在行经期间，发生小腹部疼痛，或牵及腰、胁肋等部位疼痛不适，甚至剧痛难忍，常伴有恶心呕吐，甚至面色苍白，头面冷汗淋漓，手足厥冷，这些症状多伴随月经周期而持续发作。又称为“经行腹痛”。如只感小腹部或腰部轻微胀痛，一般属正常现象，不属本病。

本症的产生原因很多，归纳起来不外寒凝血瘀、肝郁气滞、气血虚弱、肝肾亏损等。发病机理是经行不畅，脉络不通，不通则痛；或阴虚血少，胞络失养，不荣则痛；寒凝血瘀多因经期冒雨涉水，感寒饮冷，经血遇寒凝结，运行不畅而致；气血虚弱多因素体虚弱或大病久病之后，气血两亏，运行乏力，经行不畅，血虚不荣，导致痛经；肝郁气滞多因情志不舒，肝气郁结，气机不利，运血不畅而致。肝肾亏损多因先天不足，或房室不节，以及早婚多孕，肾精亏损，肝肾虚衰，精血不足，胞脉失养而致痛经。

（一）痛经因肝肾亏损所致者，临床上多见行经腹痛，经色量少，行经后期，小腹隐痛有冷凉感，头晕耳鸣，腰脊酸痛，

舌质淡红，苔薄，脉沉细等症。

上述诸症的出现，是因肝肾亏损，肾精不足，冲任俱虚，以致经血量少、色淡；经行后血海空虚，胞脉失养，故行经后期，小腹隐痛有冷凉感；肾虚则头晕耳鸣，腰膝酸痛；舌质淡红苔薄，脉沉细，均为肝肾亏损之候。

本证应与气滞血瘀痛经及寒凝血瘀所致痛经相鉴别。气滞血瘀者，多出现经前或经期小腹胀痛拒按，经色紫黑挟有血块，血块排出后则疼痛稍减，兼有胸胁乳房作胀。寒凝血瘀者，多表现经前或经期疼痛，小腹冷痛或绞痛，遇寒痛甚，得热痛减，经色有时黯红并夹有血块。以上两型均属实证。而本证属于虚证，临证不难鉴别。

治疗肝肾亏损痛经宜采用补益肝肾，温宫止痛法。方选调肝汤加减。本方由山药、阿胶、当归、芍药、山茱萸、巴戟天、甘草组成。方中山药、阿胶滋阴补肾；当归、芍药养血柔肝；山茱萸补肝肾、益精气；巴戟天温肾暖宫；甘草调和诸药。临床使用时，可再加桑寄生、菟丝子、杜仲、续断等以增强补肾之功。疼痛甚者加元胡、川楝子、小茴香、橘核，以理气活血，温经止痛。

（五）绝经前后诸症

肝肾阴虚而致绝经前后诸症，临床上多表现头晕耳鸣，潮热多汗，五心烦热，口干便结，尿少色黄，月经量少，色紫红，行经期延长而周期紊乱，舌红少苔，脉细数等证。

上述诸症的出现是因肾阴偏虚，精亏髓减，以致头晕耳鸣；阴虚生内热则见潮热汗出；阴虚津液亏损，则见口干便结，尿少色黄；肾精亏虚，天癸将竭，则经行紊乱，量少，五心烦热，经色紫红，量少，舌红少苔，脉细数，均为阴虚

火旺之象。

本证应与肾阳虚及阴阳两虚所致绝经前后诸症相鉴别。肾阳虚者，症见精神萎靡，面色晦暗，形寒肢冷。肾阳不能温运脾土，脾土健运，则出现腹胀、饮食减少、大便溏薄等症。阴阳两虚者，症见头晕目眩，耳鸣，腰酸无力，有时心烦失眠，手足发热，潮热汗出，有时又觉两足欠温，怕冷。临证不难区分。

本证的治疗宜采用滋阴柔肝，育阴潜阳之法。方选左归饮加减。本方由熟地、山药、枸杞、山茱萸、茯苓、炙甘草组成。方中熟地、枸杞、山茱萸滋肝肾、补精血；山药、茯苓、炙甘草健脾和中，补后天以养先天。临床使用时加龟版、龙骨育阴潜阳，补益冲任。如肝肾阴虚，肝气郁滞，神情抑郁，悲伤欲哭者，加合欢皮、川楝子、浮小麦等以疏肝达郁，养心安神。若肝胃不和，胸脘闷胀，暖气者，加玫瑰花、佛手以舒肝和胃。肝阳上亢，头晕目眩较甚者，加天麻、钩藤、石决明平肝息风。阴虚血燥生风，皮肤瘙痒，或如蚁行者，加丹皮、赤芍、刺蒺藜以凉血润燥祛风。

临证还应注意使患者了解本病是更年期生理上的改变，不必惊慌。过这段时间症状自然会缓解或消失。患者应保持精神愉快，要调情志，少思虑，勿动怒，会有利于疾病的恢复。还应节制饮食，少食肥甘厚味，并应定期做妇科检查，及早排除癌症的出现，防患于未然。

十、肺 肾 阴 虚

肾阴虚证与肺阴虚证同时并见者，称为肺肾阴虚证。肺

属金，肾属水。根据五行学说，肺金和肾水是母子关系，故又称“金水相生”。两者在生理上互相滋生，在病理上互相影响。临床上肾阴虚与肺阴虚之间密切相关。肾阴虽为人体阴液的根本，但需要肺的阴津不断补充和滋养。当肺阴虚损，不能正常地布达精微时，可导致肾阴不足；而肾阴虚损，肾精不能上滋于肺，亦可导致肺阴虚。肺肾阴虚证常见咳嗽痰少、痰中带血、咽燥咽干、声音嘶哑、颧红、潮热、盗汗、腰膝酸软等症。常见病证如咳嗽、咳血、肺癆、经行吐衄、妊娠咳嗽等。临床上肺肾阴虚证，有因肺病及肾者属肺病证治内容；有因肾病及肺者，属本病范畴。治疗须肺肾同治才能获得满意疗效。

（一）经行吐衄

月经来潮前一二天，或正在经期，或在行经后，出现有规律的吐、衄血，伴随月经周期发作，常可引起月经量少或不行，称为“经行吐衄”，似乎是经血倒行逆上，故又称“逆经”、“倒经”。本症的产生原因不外肝经郁火与肺肾阴虚两种，导致血热气逆，经血妄行。肝经郁火，多因情志抑郁，郁久化热，经行之时，冲气较盛，冲脉附于肝，冲气随肝热之气上逆，气升则血升，上溢而为吐衄。肺肾阴虚，多因素体阴亏，阴亏则内热，虚火上炎致迫血妄行。或偏食辛香燥烈之品，冲任蕴热，经行之时，冲任较盛，血随热上逆，灼肺伤津，损伤血络，而致吐衄。

肺肾阴虚所致经行吐衄的临床表现是，经期或经前、经后，出现吐血、衄血，量少，色暗红，伴有头晕目眩，手足心热，两颧潮红，月经先期量少，咽干口渴，时有咳嗽，舌红降，苔花剥或无苔，脉细数。

肺肾阴虚，虚火上炎，损伤肺络，故出现吐血、衄血，量少，色黯红；阴虚生内热，故头晕目眩、手足心热、两颧潮红、月经先期、量少，灼肺伤津，则咽干口渴，时有咳嗽；舌红绛，苔花剥或无苔，脉细数，均为阴虚内热之象。

本症的治疗宜采用滋阴润肺，清热凉血法。方选顺经汤加减。本方由当归、熟地、沙参、白芍、黑荆芥、茯苓、丹皮组成。方中熟地滋补肾阴，当归、白芍养血调经，沙参润肺，丹皮清热凉血，茯苓健脾宁心，黑荆芥入血中止血。临床使用时，可加牛膝引血下行。加侧柏炭、白茅根、藕节清热凉血止血。

（二）妊娠咳嗽

妊娠期出现咳嗽，且日久不愈，甚至伴有五心烦热、胎动不安者称为“妊娠咳嗽”，亦称“子咳”、“子嗽”。本病的产生，主要因为患者素体阴亏，受孕后血聚养胎，阴血更感不足，阴虚火旺，虚火上炎，灼肺伤津，肺失清肃，发为咳嗽。

肺肾阴虚咳嗽证的临床表现是，妊娠数月，咳嗽不已，干咳无痰，甚至痰中带血，口干舌燥，颧红潮热，头晕目眩，手足心热，小便频数，腰酸腹坠，舌红少苔，或苔薄黄而干，脉细滑数。

妊娠期阴液亏损，虚火内生、灼肺伤津，肺失濡润，则出现妊娠咳嗽，干咳无痰，或久咳不止，甚者痰中带血，津液伤耗，故口干舌燥，阴虚火旺，故颧红潮热，头晕目眩，手足心热；肾虚则小便频数，腰酸腹坠，舌红少苔或苔薄黄而干，脉细滑数，皆为阴虚火旺之征。

本病的治疗原则。宜采用滋肾润肺，止嗽安胎法。方选

百合固金汤加減。本方由生地、熟地、麦冬、贝母、百合、当归、芍药、生甘草、玄参、桔梗组成。方中百合、麦冬润肺止咳，玄参、白芍、生地、当归、熟地滋阴养血，贝母化痰止咳，桔梗、甘草宣肺利咽。痰涎壅盛时再加五味子、山茱萸以增强滋肾之功，使壅水归壑。若兼有外感风热者，加桑叶、银花、连翘等疏风清热。咳嗽甚者，亦可加款冬花、紫菀、杏仁、炙杷叶等宣肺止咳化痰。痰咳甚小便不能控制者，加缩泉丸，以涩小便。

十一、肾虚痰盛

肾虚痰盛是指肾气亏虚与痰浊上壅并见的病证。本病的形成，多系喘咳日久，病势不愈，渐则累及于肾，肾虚摄纳失司，气不归根，另则肾中阳气不足，水湿不化，积而成痰，痰浊上壅于肺，从而导致上实下虚的病证，临床上以喘证最为多见。

肾虚痰盛作喘，是指由于肾脏虚，痰涎上壅所致呼吸困难，张口抬肩，甚至不能平卧为特征，以症状为名的一种疾患。它多并发于各种急慢性疾病中，常为某些疾病的主要症状。喘证分实喘、虚喘两大类，虚喘之中，因病变部位不同，则有肺虚、肾虚之别，由于肾虚作喘的病理转归各异，故分为肾阳虚、肾阴虚、肾虚水泛、阳虚欲脱和肾虚痰盛等几种类型。

肾虚痰盛作喘，属于痰气壅实在上，肾气亏损于下的病理改变，因此出现一系列“上实下虚”的证候。所谓上实，是指寒痰上壅于肺，肺气不得肃降所致的喘咳短气，痰涎壅

盛，胸膈满闷等症状。所谓下虚，是指肾阴不足，不能纳气形成的呼多吸少，咳喘短气，动则喘甚等症状。由于肾虚日久，往往兼见腰酸肢冷，汗出心悸，小便频数。苔白滑，脉沉细或濡滑无力。治疗这种虚实夹杂的喘证，适宜化痰降逆与温肾纳气二法并用，苏子降气汤常为代表性方剂。本方由苏子、半夏、橘红、厚朴、前胡、肉桂、当归、甘草、生姜、大枣等药组成，方中苏子、半夏、厚朴、前胡降气化痰平喘，以治上实；肉桂温肾纳气，以治下虚。汪詠庵《医方集解》关于本方有“一方无桂，有沉香”的记载，若以沉香易肉桂，虽温肾之力减弱，但降气平喘之功效可显著增强，因此临证时可酌情加入。当归治喘，不仅本经早有“主咳逆上气”的记载，而且临床实践也屡试有验，此点不当忽视。

十二、肾虚血瘀

肾虚血瘀病证，是指某些疾患在发病过程中出现肾阴亏虚，兼有瘀血阻络的病理变化。本病多系患病日久，阴液耗伤，损及肝肾，肾阴不足，阴无阳升，津液失布，水液停聚，血瘀不行所致。临床表现以肾阴亏虚与瘀血结聚并见为特点，其治疗宜用滋补肾阴，活血化瘀之法，常用方剂为六味地黄丸、二至丸与膈下逐瘀汤合方加减。常见病证为臌胀。

臌胀是指腹部胀大，青筋显露，皮色苍黄，四肢不肿为特征的病证，因其腹部臌胀如鼓而得名。本病或因情志不舒，气滞血瘀而致；或因嗜酒过度，湿浊壅滞而发；或因感染虫毒，脉络瘀阻而成；或因黄疸、积聚，伤及肝脾而得。

但不论哪种原因，其发病都有一个较长过程，而且多是肝、脾、肾三脏受累，气、血、水积于腹内，从而渐渐引起腹部胀大。胀病日久，不仅肝脾受损，还可伤及肾脏，肾阴亏虚，肝失滋濡，疏泄无力，血行迟滞，壅阻络脉。

肾虚血瘀臌胀的病机，主要是由肾虚膀胱气化不利，水湿不行，致瘀血、水湿壅结在腹而成，因此可见胀部胀满，甚则青筋暴露，面色晦滞，口唇紫暗，时或鼻齿衄血，口燥心烦，小便短少，舌质红绛少津，脉象弦细而数。

本证的治疗，宜用滋阴补肾，活血化瘀之法，●常用方剂为六味地黄汤与膈下逐瘀汤合方加减，六味地黄汤组成见前肾阴虚各证，膈下逐瘀汤由桃仁、丹皮、赤芍、延胡索、乌药、当归、五灵脂、红花、香附、枳壳等药组成。六味地黄汤意在滋养肾阴，复其本源；膈下逐瘀汤功能活血化瘀，消除壅滞。此外尚可酌情加入猪苓、滑石等利湿之品，有利于鼓胀症状的减轻。如兼见鼻齿衄血频发不止，原方加仙鹤草、白茅根、三七粉，以凉血止血；如肝脾肿大不消，可加炙鳖甲、三棱、莪术等消坚散结。上述消散通利药物，多有耗正伤阴之弊，临床使用时，或间断服用，或与扶正之剂并施，方不致造成顾此失彼的错误。

十三、膀胱湿热

膀胱位于少腹，经脉循行络肾，其生理功能主要是贮存津液，化气行水，小便由此排出，故《素问·灵兰秘典论》有“膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣”之说。由于膀胱有化气行水的功能，其病理变化主要为气化无权，

小便不利，淋漓不爽，或频数失禁等虚实两类表现。因膀胱与肾为表里之脏，且肾又主水液，膀胱气化失常所致虚证主要是肾气虚衰。有关肾气不充、肾气不固、肾不纳气等虚证内容前已述及；此处仅讨论膀胱本腑湿热蕴结，或他脏移热于膀胱所致的淋证、癃闭等实热病证。

（一）淋证

淋证的名称，除通常所说的气、血、石、膏、劳五淋外，还有冷淋、热淋等名称，从临床看，特别是淋证初起，多属湿热淋。

湿热淋是因湿热蕴结膀胱而成。湿与热由何而来？恼怒伤肝，气郁化火，火郁下焦；心中火盛，下移小肠；脾失健运，中焦积湿化热，下注膀胱；多食辛热甘肥之品，或嗜酒太过，酿成湿热，注于下焦。这些因素形成了湿热，湿热蕴结膀胱，气化不利，则淋证随之发生。

湿热淋的主要脉症是，小便短少、频急，排尿时涩痛难忍，小腹拘急，腰痛不舒，或有发热，苔黄，脉数。治疗湿热淋，以清热利湿通淋法为宜，常用方剂为八正散加减，本方由木通、车前子、萹蓄、瞿麦、滑石、大黄、栀子、甘草梢等药组成，方中木通、车前子、萹蓄、瞿麦、滑石可利水通淋；大黄、山栀、甘草梢清热泻火，另可加入金钱草、海金沙以增强清热利湿之功。身热甚者，可加银花、公英以解毒退热；心火偏亢，烦躁失眠者，可加黄连、竹叶、灯芯清心火，除湿热。如兼尿血，可加小蓟、仙鹤草、白茅根凉血止血。

（二）癃闭

膀胱湿热伤及肾阴之癃闭，在见到小便点滴不通或尿量

极少短赤灼热、小腹胀满等症状的同时，也兼见口干咽燥，潮热盗汗，手足心热，舌红苔黄，脉数等证。

治疗这一淋证宜用滋补肾阴，潜降虚火之法，常用方剂为《兰室秘藏》的滋肾通关丸加味。本方由知母、黄柏、肉桂等药组成，方中知母、黄柏、生地可滋肾阴降虚火，少佐肉桂、牛膝温阳化气利水；另加车前子、滑石等利湿清热。

附篇：常见病证

一、遗 精

遗精是指不因性交，精液自行外泄为主要临床表现的病证。其中因梦中交合而引起者为梦遗；以无梦而遗，甚至清醒时精液自出者为滑精。一般成年未婚男子，或婚后夫妻分居久旷，一月遗精一二次而无明显症状者不属病态，乃为生理现象。若因缺乏生理知识，心理恐惧，以致出现头晕，乏力，心悸等症，或遗精过频，每周二次以上，或清醒之时亦见流精，并伴有头昏失眠，精神萎顿，腰膝酸软等症者，则属病态。

遗精病位在肾，病机总属肾失封藏，精关不能固守。因其具体引发病因较多，非独肾虚所致，故临证之时必须审病求因，因证而治。

（一）阴虚火旺

【主证】梦中遗精，夜寐不安，头目昏晕，心悸，精神不振，体倦乏力，或兼小便短黄而有热感，舌质红，脉细数。

【治法】滋阴清火，安神固精。

【方剂】知柏地黄丸或三才封髓丹加减。

（二）肾虚不藏

【主证】遗精频作，甚至滑精，头昏目眩，耳鸣腰酸，面

白少华，畏寒肢冷，舌质淡，脉沉细，或舌质红，脉细数。

【治法】补肾固精。

【方剂】偏阳虚者，用右归丸加减；偏阴虚者，用六味地黄丸加减。并可吞服金锁固精丸或水陆二仙丹。

（三）湿热下注

【主证】遗精频作，或尿时有精液外流，心烦少寐，口苦或渴，小便热赤或不爽，舌苔黄腻，脉象濡数。

【治法】清热化湿。

【方剂】程氏萆薢分清饮或猪肚丸加减。

（四）肝火偏盛

【主证】多为梦中遗泄，阳物易举，烦躁易怒，胸胁不舒，面红目赤，口苦咽干，小便短赤，舌红苔黄，脉象弦数。

【治法】清肝泻火。

【方剂】龙肝泻肝汤加减。

二、阳 痿

阳痿又称阴痿。是指未到性欲衰退年龄，阴茎痿弱，不能勃起，或临房举而不坚为主要临床表现的病证。病机总属宗筋弛纵，阳道不兴；病变每多涉及肝、肾、阳明三经。

（一）命火衰微

【主证】阳事不举，精薄清冷，面色苍白，头晕目眩，精神萎靡，腰酸觉冷，腿膝无力，四肢欠温，舌淡苔白，脉沉细尺弱。

【治法】补肾壮阳。

【方剂】赞育丹或扶命生火丹、右归丸加减。

(二) 心脾受损

【主证】阳事不举，精神不振，面色萎黄，心悸气短，夜寐不安，倦怠乏力，胃纳欠佳，舌淡苔白，脉细。

【治法】补益心脾。

【方剂】归脾汤或七福饮加减。

(三) 恐惧伤肾

【主证】阳痿不用，或举而不坚，精神苦闷，胆怯多疑，易惊善恐，心悸时作，夜寐不宁，舌质淡，苔薄腻，脉弦细。

【治法】益肾宁神。

【方剂】大补元煎酌加枣仁、远志等治疗，或以宣志汤加减。

(四) 湿热下注

【主证】阴茎痿软，阴囊潮湿臊臭，口苦，心烦，饮食欠佳，下肢酸重，小便短赤，舌苔黄腻，脉象濡数。

【治法】清化湿热。

【方剂】二妙散或龙胆泻肝汤加减。

三、水 肿

水肿是指体内水液滞留，泛滥肌肤所引起的，以头面、眼睑、四肢、腹背甚至全身浮肿为主要临床表现的病证。本病辨治，常在分辨阳水、阴水的基础上进而分别证型，因证论治。其治法有发汗、利水、逐水、健脾、温肾、理气、降浊种种，且既可一法独用，也可数法相合，但贵在合于病

机。

(一) 阳水

1. 风水泛滥

【主证】眼睑浮肿，继则四肢及全身皆肿，来势迅速，关节酸重，小便不利，多有恶寒、恶风、发热等证，或咳嗽而喘，舌苔薄白，脉浮滑或紧，或咽喉红肿疼痛，舌质红，苔薄黄，脉浮滑数。如水邪泛滥，肿势较重，亦可见沉脉。

【治法】疏风宣肺利水，风水偏寒者佐以散寒；风水偏热者佐以清热。

【方剂】越婢加术汤加减。

2. 水湿浸渍

【主证】全身水肿，按之凹陷，小便短少，身体沉重，困倦，胸闷，纳呆，泛恶，苔白腻，脉沉缓。起病一般较为缓慢，病程较长。

【治法】健脾祛湿，通阳利水。

【方剂】五苓散合五皮饮加减。

3. 湿热壅盛

【主证】遍体浮肿，皮色润泽光亮，胸腹胀闷，烦热口渴，小便短赤，或大便干结，苔黄腻，脉沉数。

【治法】分利湿热。

【方剂】疏凿饮子加减。

(二) 阴水

1. 脾阳不足

【主证】身肿腰以下为甚，按之凹陷不易恢复，脘闷腹胀，纳减便溏，面色萎黄，神倦肢冷，小便短少，舌质淡，苔白滑，脉沉缓。

【治法】温运脾阳，以利水湿。

【方剂】实脾饮加减。

2. 肾阳衰微

【主证】面浮身肿，腰以下尤甚，按之凹陷不起，心悸气促，腰部冷痛酸重，尿量减少，四肢厥冷，怯寒神疲，面色灰滞或苍白，舌质淡胖，苔白，脉沉细或沉迟。

【治法】温肾助阳，化气行水。

【方剂】真武汤加减。

四、癃 闭

癃闭是指排尿困难，甚至点滴不通为主要临床表现的病证。其中起病较缓，小便不爽，仅点滴而下，尿量极少者为癃；病势较急，小便完全闭塞，点滴皆无者为闭。

本病病位在膀胱，病机总属气化失调。发病脏腑可为肾、脾、肺、肝诸脏，尿路阻塞者也可引发之。癃闭治疗根据“腑以通为补”的原则，常着重于“通”，但究其病因不同，具体治法也当有异。

（一）湿热壅积

【主证】小便点滴不通，或量极少而短赤灼热，小腹胀满，口苦口粘，或口渴不欲饮，或大便不畅，舌质红，苔黄腻，脉沉数。

【治法】清利湿热，通利小便。

【方剂】八正散加减。

（二）肺热壅盛

【主证】小便不畅，或点滴不通，咽干，烦渴欲饮，呼吸

急促，或有咳嗽，舌苔薄黄，脉数。

【治法】清肺热，利水道。

【方剂】清肺饮加减。

（三）中气下陷

【主证】小腹坠胀，时欲小便而不得出，或量少而不爽利，精神疲乏，食欲不振，气短懒言，语声低细，舌质淡，苔薄白，脉沉弱。

【治法】升清降浊。

【方剂】补中益气汤加肉桂、通草、车前子。

（四）肝郁气滞

【主证】小便不通，或时有点滴而下，但不能完全尽出，精神忧郁，或心烦易怒，胁腹胀满，苔薄白或薄黄，脉弦。

【治法】疏利气机，通利小便。

【方剂】沉香散加减。

（五）肾气不充

【主证】小便不通，或点滴不爽，排出无力，面色苍白，神气怯弱，腰膝冷而酸软无力，舌质淡，脉沉细而尺弱。

【治法】温补肾阳，化气利水。

【方剂】《济生》肾气丸加减。

（六）尿道阻塞

【主证】小便点滴而下，或时而通畅，时而阻塞不通，小腹胀满疼痛，舌紫暗，或有瘀点，脉涩或细数。

【治法】行瘀散结，清利水道。

【方剂】抵当丸加减。

五、内伤发热

内伤发热是指脏腑气血阴阳虚损或失调所引起的发热。该发热既可表现为体温升高，且以低热比较多见；也可表现为体温不高，仅感自觉发热，或五心烦热。内伤发热与外感发热在表现上迥不相侔。本病一般起病缓慢，病程较长，发热多不恶寒，或感到怯冷，但得衣被则减，其热时作时止，或发有定时，且多伴手足心热，同时常兼气血、阴阳失调的症状。本病引发原因较多，证候也较复杂，其常见者概有：

（一）阴虚内热

【主证】午后或夜间潮热，或手足心发热，或骨蒸颧红，心烦盗汗，失眠梦多，口干咽燥，大便干结，尿少色黄，舌红而干，或有裂纹，无苔或少苔，脉细数。

【治法】滋阴清热。

【方剂】清骨散或知柏地黄丸、大补阴丸加减。

（二）血虚发热

【主证】发热或低或高，头晕眼花，身倦乏力，心悸不宁，面白无华，唇甲色淡，舌淡苔薄，脉弱。

【治法】养血益气。

【方剂】归脾汤或补中益气汤加减。

（三）气虚发热

【主证】发热或高或低，常在劳累以后发作或加重，体倦乏力，气短懒言，食少便溏，自汗，易于感冒，舌质淡，苔薄白，脉弱。

【治法】益气健脾，甘温除热。

【方剂】补中益气汤加减。

(四) 阳虚发热

【主证】发热而欲近衣被，形寒怯冷，四肢不温，头晕嗜卧，腰膝酸痛，舌质淡胖，或有齿痕，苔白润，脉沉细或浮大无力。

【治法】温补肾阳。

【方剂】《金匱》肾气丸或右归丸加减。

(五) 肝经郁热

【主证】时觉身热心烦，热势常随患者的情绪好坏而起伏，平时性情急躁易怒，胸胁闷胀，喜叹息，口苦，舌苔黄，脉弦数。妇女常见月经不调，经来腹痛，或乳房发胀。

【治法】疏肝解郁清热。

【方剂】丹栀逍遥散加减。

(六) 瘀血内结

【主证】下午或夜晚发热，口干咽燥而不多饮，肢体常有固定痛处或肿块，甚则肌肤甲错，面色黯黑或萎黄，唇舌青紫，或见紫斑，脉象细涩。

【治法】活血祛瘀。

【方剂】血府逐瘀汤加减。

六、痹 证

痹证是指外邪侵袭肌表、经络，气血运行不畅而引起的，以筋骨、肌肉、关节等处疼痛、酸楚、重着、麻木和关节肿大，屈伸不利为主要临床表现的病证。一般可分为风寒湿痹与风湿热痹两种。在风寒湿痹中，以其感邪轻重的不同和

症状表现的差异又分为风（行）痹、寒（痛）痹、湿（着）痹。

（一）风寒湿痹

1. 行痹

【主证】肢体关节疼痛，游走不定，关节屈伸不利，或见风发热等表证，苔薄白或腻，脉多浮。

【治法】祛风通络，散寒除湿。

【方剂】防风汤加减。

2. 痛痹

【主证】肢体关节疼痛较剧，痛有定处，遇寒增重，屈伸不利，痛处皮色不红，触之不热，苔薄白，脉弦紧。

【治法】散寒止痛，祛风除湿。

【方剂】乌头汤加减。

3. 着痹

【主证】肢体关节疼痛重着，或肿胀，痛有定处，手足沉重，活动不便，肌肤麻木不仁，舌苔白腻，脉象濡缓。

【治法】除湿通络，祛风散寒。

【方剂】薏苡仁汤加减。

（二）热痹

【主证】关节疼痛，局部灼热红肿，得冷则舒，痛不可触，关节游走疼痛，不能屈伸，动则痛甚，可涉及一个或多个关节，多兼有发热，汗出、恶风、口渴、烦闷不安等全身症状，舌质红，苔黄燥，脉滑数。

【治法】清热通络，疏风胜湿。

【方剂】白虎加桂枝汤、宣痹汤、三妙丸等加减。

（三）顽痹

【主证】痹久不愈，反复发作，关节僵硬变形，附近其色深黯，疼痛剧烈，固定不移，难以屈伸，或兼见肢体麻木，肌肉痿软，舌质紫暗或有瘀斑，苔白腻，脉细涩。

【治法】活血化瘀，祛痰通络，兼以养血扶正。

【方剂】身痛逐瘀汤，大、小活络丹，益肾蠲痹丸加减。

七、消 渴

消渴是以口渴多饮，尿频量多，形体消瘦或尿有甜味为特征的一种病证。祖国医学所说的“消渴”有两种含义：其一是指口渴多饮的症状，如《伤寒论》厥阴病提纲中的消渴二字，即指此意；其二是指以多饮、多食、多尿、身体逐渐消瘦为特征的病证，本篇所述消渴系属后者。消渴病变的脏腑在肺、胃、肾，病理关键是燥热偏盛、阴津亏耗，证候特点是“三多一少”。某一患者的三多症状，可同时并见，但有轻重主次之分，通常把口渴多饮为主者称为上消，多食易饥为主者称为中消，尿频量多或尿如脂膏者称为下消。临床上每以三消的主次轻重为本证辨证治疗的着眼点。

（一）上消

【主证】烦渴多饮，口干舌燥，尿频量多，舌尖边红，苔薄黄，脉洪数。

【治法】清热润肺，生津止渴。

【方剂】消渴方加味，或玉泉丸。

（二）中消

【主证】多食易饥，形体消瘦，大便秘结，舌苔黄燥，脉滑实有力。

【治法】清胃泻火，养阴保津。

【方剂】玉女煎加减。

(三) 下消

【主证】肾阴偏虚者，尿频量多，混浊如脂膏，或尿甜，口干舌燥，舌质红，脉沉细数。阴阳两虚者，小便频数，混浊如膏，甚则饮一溲一，面色黧黑，耳轮焦干，腰膝酸软，甚则阳痿，舌淡苔白，脉沉细无力。

【治法】肾虚偏虚治宜滋阴固肾，阴阳两虚者治宜滋肾温阳固肾。

【方剂】前者选六味地黄丸加味，后者施《金匱》肾气丸加减。

八、淋 证

淋证，是指小便频数短涩，滴沥刺痛，欲出未尽，小腹拘急或疼痛牵引腰腹为特点的一种病证。这是一个总的名称。根据本证发病原因、机理和症状表现的不同，中医学又将淋证分为石淋、气淋、血淋、膏淋、劳淋等五种，合起来称作“五淋”。此外，尚有湿热下注膀胱或下阴不洁，浊秽之邪侵入下焦形成的湿热淋也属常见。

(一) 石淋

【主证】尿中有时挟有砂石，小便艰涩，或排尿时突然中断，尿道刺痛窘迫，少腹拘急，或腰腹绞痛难忍，甚则尿中带血，舌质偏红（久则舌质淡），苔薄黄，脉略带数。

【治法】清热利湿，通淋排石。

【方剂】八正散或石苇散加减。

（二）气淋

【主证】肝郁气滞者证见小便涩滞，少腹胀痛，舌质带青，脉多沉弦。中气不足者证见小腹坠胀，迫切作痛，尿有余沥，面色苍白，舌质淡，脉虚无力。

【治法】肝郁气滞者治宜利气疏导，中气不足者治宜补益中气。

【方剂】前者选沉香散加减，后者施补中益气汤加减。

（三）血淋

【主证】小便热涩刺痛，尿色紫红，甚则挟有血块，小腹疼痛满急，或见心烦，舌苔黄，脉滑数。

【治法】清热利湿，凉血止血。

【方剂】小蓟饮子加减。

（四）膏淋

【主证】属实者小便混浊如米泔水，或有滑腻之物，尿道热涩疼痛，舌质红，苔腻，脉数。属虚者多见淋证日久不愈或反复发作的患者，淋出如脂，涩痛虽见减轻，但形体日渐消瘦，头昏无力，腰膝酸软，舌淡苔腻，脉细弱无力。

【治法】实者清热利湿，分清泌浊；虚者补肾固涩。

【方剂】实证用程氏萆薢分清饮加减，虚证选六味地黄丸加减。

（五）劳淋

【主证】小便不甚涩痛，但淋漓不已，时作时止，遇劳即发，精神困倦，舌质淡，脉虚弱。

【治法】健脾补肾。

【方剂】无比山药丸加减。

九、虚 劳

虚劳是虚损劳伤的简称，是由脏腑亏损，元气虚弱所引起的多种慢性疾病的总称。虚劳的症状表现虽然很多，但其损伤总不外五脏，而五脏的损伤，又不外乎气血阴阳四个方面，因此，虚劳的辨证，是以气血阴阳为纲，以五脏虚候为目，提纲挈领，最为便当。

(一) 气虚

1. 肺气虚

【主证】短气自汗，时寒时热，声音低怯，或兼咳嗽，平时易于感冒，面白，舌质淡，脉软弱。

【治法】补益肺气。

【方剂】补肺汤加减。

2. 脾气虚

【主证】饮食减少，食后胃脘不舒，倦怠乏力，大便溏薄，面色萎黄，舌淡苔薄，脉软弱。

【治法】健脾益气。

【方剂】参苓白术散加减。

(二) 血虚

1. 心血虚

【主证】心悸怔忡，健忘，失眠多梦，面色不华，舌淡，脉细或结代。

【治法】养血宁心安神。

【方剂】养心汤加减。

2. 肝血虚

【主证】头晕，目眩，耳鸣，胁痛，惊惕不安，妇女月经不调，甚则经闭，肌肤甲错，面色白，舌质淡或青紫，脉弦细或细涩。

【治法】补养肝血为主，兼用活血化瘀。

【方剂】四物汤加味。

（三）阳虚

1. 心阳虚

【主证】心悸自汗，神倦嗜寐，形寒肢冷，心胸憋闷疼痛，面色苍白，舌淡或紫暗，脉细弱、结代或虚大无力。

【治法】温通心阳。

【方剂】桂枝甘草汤加味。

2. 脾阳虚

【主证】面色萎黄，食少形寒，神疲乏力，少气懒言，腹中冷痛，肠鸣泄泻，甚则完谷不化，舌淡苔白，脉虚弱。

【治法】温中健脾。

【方剂】理中汤加味。

3. 肾阳虚

【主证】畏寒肢冷，面色苍白，五更泄泻，下利清谷，腰脊酸痛，遗精阳痿，多尿或不禁，舌淡体胖有齿痕，舌苔白，脉沉迟。

【治法】温补肾阳，兼养精血。

【方剂】右归丸加减。

（四）阴虚

1. 肺阴虚

【主证】干咳咽燥，甚则失音，潮热盗汗，面色潮红，舌

红少津，无苔或少苔，脉象细数。

【治法】养阴润肺。

【方剂】百合固金汤加减。

2. 心阴虚

【主证】心悸失眠，烦躁不宁，潮热盗汗，或舌痛生疮，面色潮红，舌红少津，脉细数。

【治法】滋阴养心。

【方剂】天王补心丹加减。

3. 脾胃阴虚

【主证】口干唇燥，不思饮食，大便燥结，甚则干呕呃逆，面潮红，舌光红少津，脉细数。

【治法】养阴和胃。

【方剂】益胃汤加味。

4. 肝阴虚

【主证】头痛，眩晕耳鸣，目干畏光，视物昏花，或视力减退，急躁易怒，或肢体麻木，筋惕肉瞤，面潮红，舌干红，脉弦细数。

【治法】滋养肝阴。

【方剂】补肝汤加减。

5. 肾阴虚

【主证】发脱齿摇，眩晕耳鸣，甚则耳聋，口干咽痛，潮热颧红，或遗精腰酸，两足痿弱，舌红少津，脉沉细。

【治法】滋补肾阴。

【方剂】六味地黄丸加减。

十、痿 证

痿证是指肢体筋脉弛缓，软弱无力，日久因不能随意运动而致肌肉萎缩的一种病证。临床上以下肢痿弱者多见，故有“痿躄”之称。痿证多由肺热伤津，湿热浸淫，脾胃虚弱和肝肾亏虚等因素引发。其病有实证，也有虚证。有突然出现肢体痿弱者，也有逐渐形成的，辨证治疗时必须注意到这种情况。

（一）肺热伤津

【主证】起病发热，或热退后突然出现肢体软弱无力，心烦口渴，咳呛咽干，小便短黄，大便偏干，舌质红，苔黄，脉细弱而数。

【治法】清热润燥，养阴生津。

【方剂】清燥救肺汤加减。

（二）湿热浸淫

【主证】肢体困重，痿弱无力，或兼微肿，麻木，尤以下肢为常见，或有发热，胸脘痞闷，小便赤涩热痛，苔黄腻，脉濡数。

【治法】清热利湿。

【方剂】加味二妙散。

（三）脾胃虚弱

【主证】肢体痿弱无力逐渐加重，食少便溏，面浮而色不华，神疲乏力，舌苔薄白，脉细。

【治法】健脾益气。

【方剂】参苓白术散加减。

(四) 肝肾亏虚

【主证】起病较缓，下肢痿软无力，腰脊酸软，并有眩晕耳鸣，遗精或遗尿，或月经不调，舌红少苔，脉细数。

【治法】补益肝肾，滋阴清热。

【方剂】虎潜丸加味。

十一、耳 鸣、耳 聋

耳鸣、耳聋都是听觉异常的症状。耳鸣是指病人自觉耳内鸣响，如闻蝉声，或如风声，或如汽笛，或如潮声，妨碍听觉；耳聋是指不同程度的听觉减退，轻者听而不真，称为“重听”重者听觉丧失，不闻外声，称为耳聋。耳鸣可以伴有不同程度的听觉障碍；而耳聋除气闭暴聋者外，亦可由耳鸣发展而来。耳鸣、耳聋的发生，多因肾虚，中气不足，不能上充于清窍；或因风邪、肝火、痰火、瘀血使耳窍气闭不通而致。在发病机理上肾虚是本，风火痰瘀是标。病变部位在肾，又与肝脾密切相关。临床上耳鸣、耳聋有虚实之分，一般新病多实，久病多虚。凡耳暴鸣声大者多实；渐鸣而声细者多虚。大怒、大醉后耳鸣耳聋者属肝火，痰火；中年或大病后体虚者多为虚证。更有虚中挟实者。

(一) 风邪外袭

【主证】卒然耳鸣、耳聋，耳内作痒，头痛咽痛，发热恶风，骨节酸痛，舌苔薄白，脉滑数。或耳聋连耳根及牙龈肿痛，或见寒热，咳嗽，口干，耳中疼痛、出血，流脓等症。

【治法】疏风清热解表通窍。

【方剂】清神散加减。

(二) 肝胆火盛

【主证】突然耳鸣或耳聋，其鸣声如潮声，如风声，声大而响，多发于郁怒之后，兼见耳内堵塞感，面赤头痛，口苦咽干，烦躁失眠，胸胁胀痛，便秘溲赤，舌红苔黄，脉象弦数。

【治法】清肝泻火通窍。

【方剂】龙胆泻肝汤加减。

(三) 痰火郁结

【主证】两耳蝉鸣，或轰轰作响，有时闭塞如聋，头昏头重，胸闷痰多，口苦，舌苔薄黄而腻，脉象弦滑或滑数。

【治法】化痰清火，和胃降浊。

【方剂】二陈汤加黄芩、黄连、菖蒲、竹沥水等。

(五) 瘀阻宗脉

【主证】耳鸣、耳聋如塞，面色黧黑，耳流陈血，或见耳聾与陈血胶结，舌质紫暗或有瘀斑，舌苔薄，脉涩。

【治法】通窍活血。

【方剂】通窍活血汤加减。

(五) 中气不足

【主证】耳鸣、耳聋，或如蝉鸣，久则耳聾，遇劳累后症状加重，兼见面色萎黄，神疲乏力，腹胀纳呆，便溏，舌淡苔白，有齿痕，脉虚弱。

【治法】健脾益气，升提中气。

【方剂】益气聪明汤加减。

(六) 肾精亏损

【主证】耳鸣，初如蝉声，由轻渐重，终至耳聾，兼有头晕目眩，腰酸遗精，舌红少苔，脉弦细或细弱。或兼见怯寒

怕冷，夜尿频频，阳痿早泄，舌淡苔白，脉沉细等证。

【治法】补肾益精。肾阳虚者，温补肾阳。

【方剂】耳聋左慈丸加减。若肾阳虚，方用补骨脂丸加减。

十二、尿 血

尿血是小便中混有血液，甚至伴有血块夹杂而下的一种病症。随出血量多少的不同，小便可呈淡红色、鲜红色或淡酱油色。临床上又称为溺血、溲血、小便血或小便出血。本证应与血淋相鉴别。二者同为小便中混有血液，但血淋以小便短涩频数，滴沥刺痛，小腹拘急为特征。其鉴别要点在于小便时痛与不痛。如《证治要诀·小便血》所说：“痛者为血淋，不痛者为尿血”。尿血的发病部位在肾与膀胱，发病原因多为热伤血络。如外邪入侵，太阳受之，传经入里，或心、小肠、肝等脏腑之火热，或火毒内壅，侵入营血，或肾阴不足虚火旺动等，热邪蓄结肾与膀胱，损伤脉络，血溢水道而成尿血。另外，部分尿血是由气血亏虚，脾肾两虚，气滞血瘀，络阻血溢而致。

（一）热迫膀胱

【主证】尿血，血色鲜红，小便短赤，有热涩感，口渴喜饮，小腹作胀，或兼腰痛，初起可见恶寒发热，骨节酸痛，舌红苔黄，脉数。

【治法】清热利湿，凉血止血。

【方剂】小蓟饮子加减。

（二）火毒迫血

【主证】尿血，血色鲜红，发病急骤，初起恶寒发热，继则高热烦渴，头痛身痛，神疲乏力，兼见衄血、便血，皮肤紫斑，舌红苔黄脉洪数。

【治法】泻火解毒，凉血止血。

【方剂】黄连解毒汤合犀角地黄汤加减。

（三）心火炽盛

【主证】小便热赤，带血鲜红，点滴而出，面赤心烦，口舌生疮，口渴，夜寐不安，舌尖红，苔黄，脉数。

【治法】清心泻火，凉血止血。

【方剂】导赤散加味。

（四）阴虚火旺

【主证】小便色赤带血，头晕目眩，口干耳鸣，潮热盗汗，颧红失眠，五心烦热，神疲易怒，腰酸乏力，舌红少苔，脉细数。

【治法】滋阴清火，凉血止血。

【方剂】大补阴丸合阿胶汤加减。

（五）脾肾两虚

【主证】久病尿血，血色淡红，小便频数，面色苍白，气短懒言，神疲乏力，饮食减少，头晕目眩，心悸耳鸣，腰膝酸软，或兼衄血，便血，皮肤紫斑，舌质淡，苔白，脉虚弱。

【主法】健脾益气，补肾固涩。

【方剂】补中益气汤合无比山药丸加减。

（六）气滞血瘀

【治证】尿血，血色较暗，或见血块，小腹刺痛拒按，或可触到积块，舌质紫暗，或有瘀斑，苔薄白，脉细涩或沉

细。

【治法】活血化瘀，养血止血。

【方剂】茜根散合蒲黄散加减。

十三、便 血

血液由肛门或随大便而出者谓之便血。临床又称下血、泻血。血或在粪便之前，或在粪便之后，或便血夹杂而下，或单纯下血。先血后便为近血，先便后血为远血。血清色鲜者为肠风，血色污浊而暗红者为脏毒。便血的病位在胃与大肠。便血多因胃中积热，湿热蕴肠，肝郁化火，横逆犯胃，热伤血络，迫血妄行而成。或老年肾阴不足，大便热盛津涸，而致便燥出血。或因脾胃虚寒，脾不统血，气不摄血，血液下渗而致便血。初病多以邪实为主，日久则转为正虚。

（一）胃中积热

【主证】便血，血色紫黑，大便不爽，胃脘胀满疼痛，并有灼热感，口渴喜冷饭，或兼口苦烦躁，头晕目眩，舌红，苔黄而燥，脉滑数。

【治法】清胃泻火，化瘀止血。

【方剂】泻心汤合十灰散加减。

（二）肝胃郁热

【主证】便血，血色紫黑，或量多血鲜，口苦胁痛，胃脘灼痛，心烦易怒，饮食减少，舌质红，苔薄黄，脉弦数。

【治法】泻肝清胃，凉血止血。

【方剂】龙胆泻肝汤加减。

（三）气滞血瘀

【主证】便血紫暗，脘腹疼痛，部位固定，拒按，或腹中症积，饮食减少，消瘦乏力，舌质紫暗，或有瘀斑，脉弦细或涩。

【治法】行气化瘀，养血止血。

【方剂】膈下逐瘀汤加减。

(四) 湿热蕴蒸

【主证】大便下血，血色鲜红或紫黑污浊，多数是先血后便，大便秘结或不爽，或见肛门灼热疼痛，腹部不适，烦热溲赤，饮食减少，舌质红，苔黄腻，脉濡数或滑数。

【治法】清热利湿，凉血止血。

【方剂】赤小豆当归散合地榆散加减。

(五) 肠热津涸

【主证】便血鲜红，肛门疼痛，大便秘结，头昏耳鸣，腰膝乏力，舌红少津，脉弦细或细数。多见于老年人或肾阴不足者。

【治法】养阴生津，润肠止血。

【方剂】三地汤加味。

(六) 中气不足

【主证】便血，血色紫暗或黑便，肛门下坠，脘腹不适，面色萎黄，头晕目眩，心悸气短，神疲乏力，饮食减少，舌淡苔白，脉沉细。

【治法】健脾益气，升提止血。

【方剂】补中益气汤加减。

(七) 脾胃虚寒

【主证】便血，血色紫暗或为黑便，脘腹隐隐作痛，喜温喜按，面色萎黄，心悸气短，神疲体倦，恶寒肢冷，纳呆便

溏，舌淡苔白，脉沉细。

【治法】健脾温中摄血。

【方剂】黄土汤加味。

十四、闭 经

闭经，有原发与继发之分。女子年过18岁，月经尚未来潮者，属于前者；如果月经曾来潮而又中断达三个月以上者，归属后者，这些都是病理现象。临床上所见先天性无子宫，无卵巢，无阴道或处女膜闭锁等器质性病变所致闭经，非药物治疗所能奏效，故在此将不予讨论。至于妊娠期、哺乳期及绝经期以后的停经，是属生理现象，而不是“闭经”病证。闭经多由肝肾不足，气血虚弱，气滞血瘀和痰湿阻滞所引起，病性有实有虚，临证治疗时，切不可一见闭经，即施通利之法，此点应牢记勿忘。

（一）肝肾不足

【主证】月经超龄未至，或初潮较迟，量少色红或色淡，渐至闭经，兼见头晕耳鸣，腰膝酸软，口干咽燥，五心烦热，潮热汗出，两颧潮红，舌质红，或舌淡苔少，脉细弦或细涩。

【治法】滋补肝肾，养血调经。

【方剂】归肾丸加味。

（二）气血虚弱

【主证】月经由后期量少而渐至停闭，面色苍白或萎黄，头晕目眩，心悸怔忡，气短懒言，神疲肢软，纳少便溏，唇舌色淡，脉细弱，或细缓无力。

【治法】益气扶脾，养血调经。

【方剂】八珍汤加味。

(三) 气滞血瘀

【主证】月经数月不行，精神抑郁，烦躁易怒，胸胁胀满，少腹胀痛或拒按，舌边紫暗，或有瘀点，脉沉弦或沉迟。

【治法】活血祛瘀，理气行滞。

【方剂】血府逐瘀汤加味。

(四) 痰湿阻滞

【主证】月经停闭，形体肥胖，胸胁满闷，呕恶痰多，神疲倦怠，带多色白，苔腻脉滑。

【治法】燥湿祛痰，活血通经。

【方剂】苍附导痰汤加味。

十五、绝经前后诸症

绝经前后诸症，亦称断经前后诸症。是指妇女临近经断前后，即四十九岁左右，所出现的经行紊乱，头晕耳鸣，心悸失眠，烦躁易怒，烘热汗出，五心烦热，或浮肿便溏，腰酸乏力，甚至情志异常等为主要临床表现的病证。以上诸症常三三两两，且轻重不一的出现，并有延续二三年者。

(一) 肾阴虚

【主证】头晕耳鸣，失眠多梦，心烦易怒，烘热汗出，五心烦热，腰膝酸软，或皮肤感觉异常，口干便结，尿少色黄，舌红少苔，脉细数。

【治法】滋阴柔肝，育阴潜阳。

【方药】左归饮加制首乌、龟版、龙骨等治疗。

（二）肾阳虚

【主证】面色晦暗，精神萎靡，形寒肢冷，纳差腹胀，大便溏薄，或面浮肢肿，尿意频数，甚至小便失禁，舌淡胖，苔薄白，脉沉细无力。

【治法】温肾扶阳。

【方药】右归丸加党参、补骨脂、仙茅、仙灵脾等治之。

十六、胎漏、胎动不安

胎漏，是指怀孕以后，阴道不时少量下血，或时下时止，或淋漓不断，但无腰酸腹痛，小腹坠胀等症状的病证。如果先感胎动下坠，继而有轻微的腰酸腹胀，或阴道有少许出血的症状，称为“胎动不安”。胎漏、胎动不安的发生，主要是因气血虚弱、肾虚、血热、外伤等原因所引起，在治疗上总的原则是以安胎为主。

（一）气血虚弱

【主证】妊娠初期，胎动下坠，阴道少量下血，色淡红，质稀薄，神疲肢倦，面色苍白，心悸气短，或腰酸腹胀，舌质淡，苔薄白，脉细滑。

【治法】补益气血，固肾安胎。

【方剂】胎元饮。

（二）肾虚

【主证】妊娠期腰酸腹坠，或见阴道下血，头晕耳鸣，小便频数，甚至失禁，或曾屡次坠胎，舌淡苔白，脉沉弱。

【治法】固肾安胎。

【方剂】寿胎丸或泰山盘石散。

(三) 血热

【主证】妊娠胎漏下血，色鲜红，或胎动下坠，心烦不安，手足亦热，口干咽燥，或有潮热，小便短黄，大便秘结，舌质红，苔黄而干，脉滑数或弦滑。

【治法】滋阴清热，凉血安胎。

【方剂】保阴煎加味。

(四) 外伤

【主证】妊娠之后受有外伤，胎动下坠，腰酸腹胀，甚或胎漏下血，舌正常，脉滑无力。

【治法】益气养血，固摄安胎。

【方剂】圣愈汤合寿胎丸加减。

十七、妊娠失音

妊娠失音，古称“子暗”，是指妊娠末期出现声音嘶哑，甚至不能出声的病证。由于声音出于肺而根于肾，发于舌本。妊娠后期，胎儿增大，胞脉受阻，肾脉不通，若此时肾阴不足，不能上荣舌本，即可导致失音。

【主证】妇人怀孕八九个月后，出现声音嘶哑，甚至不能出声，咽喉干燥，有时颧红，头晕耳鸣，掌心灼热，心悸而烦，小便短赤，大便干燥，舌质红，苔花剥，脉细数。

【治法】滋肾益阴，壮水制火。

【方药】六味地黄丸加蝉衣、木蝴蝶。

十八、妊娠肿胀

妊娠肿胀是指怀孕期间肢体面目浮肿而言。因其肿胀部位和程度可有不同，故古人又有子满、子气、子肿、皱脚、脆脚之称。如在妊娠七、八月以后只见足肿而无其它不适，则多属怀孕晚期常见现象，一般产后可自行消失，不必治疗，其子肿、子满主要证候为：

(一) 脾虚

【主证】妊娠数月，面目四肢浮肿，或遍身皆肿，肤色淡黄或苍白，皮薄光亮，胸闷纳呆，口淡无味，气短懒言，周身乏力，大便溏薄，舌质淡胖，边有齿痕，苔薄白或薄腻，脉缓滑无力。

【治法】健脾行水。

【方药】白术散加砂仁。

(二) 肾虚

【主证】孕后数月，面浮肢肿，下肢尤甚，按之没指，心悸气短，下肢逆冷，腰膝酸软，舌淡苔白润，脉沉细。

【治法】化气行水。

【方剂】真武汤加减。

(三) 气滞

【主证】妊娠三四月后，先由脚肿，渐及于腿，皮色不变，随按随起，头晕胀痛，胸闷胁胀，食少，苔薄腻，脉弦滑。

【治法】理气行滞，佐以健脾行水。

【方剂】天仙藤散合四苓散加减。

十九、妊娠小便不通

妊娠小便不通，又称“转胞”或“胞转”，是指怀孕期间，小便不通，甚至小腹胀急疼痛而言。

(一) 气虚

【主证】妊娠期间，小便不通，或频数量少，小腹胀急疼痛，坐卧不安，面色苍白，精神疲倦，头重眩晕，短气懒言，大便不爽，舌质淡，苔薄白，脉虚缓滑。

【治法】补气，升陷，举胎。

【方剂】益气导溺汤加减。

(二) 肾虚

【主证】妊娠小便频数不畅，继则闭而不通，小腹胀满而痛，坐卧不宁，畏寒肢冷，腰腿酸软，舌质淡，苔薄润，脉沉滑无力。

【治法】温肾扶阳，化气行水。

【方药】《金匱》肾气丸减丹皮、附子，加巴戟天、菟丝子。

二十、妊娠小便淋痛

妊娠期间小便频数不畅，出现尿频、尿急、淋漓涩痛等症状者，称为“妊娠小便淋痛”。关于本病，古代又有“子淋”、“妊娠小便难”之称。

本病的产生，主要是膀胱气化不行，因水液藏于膀胱，赖气化才能排出体外。若因心火偏亢，湿热下注，阴虚，气虚等因素，导致膀胱气化不行，水道不利，则出现小便淋漓而

痛。

(一) 实热型

1. 心火偏亢

【主证】妊娠数月，小便频数而短，色黄赤，艰涩不利，有灼热或刺痛感，兼有面赤心烦，或口舌生疮，舌红少苔，脉数而滑。

【治法】泻火通淋。

【方剂】导赤散加味。

2. 湿热下注

【主证】妊娠期间，小便频数而急，尿色黄赤，涩滞不利，灼热刺痛，面色垢黄，口干不欲饮，舌苔黄腻，脉滑数。

【治法】清热利湿通淋。

【方剂】加味五淋汤或八正散加减。

(二) 阴虚型

【主证】妊娠数月，小便频数淋漓，灼热刺痛，量少，色深黄，形体消瘦，两颧潮红，午后潮热，手足心热，心烦不寐，舌质红，苔薄黄而干，脉细数而滑。

【治法】滋阴润燥通淋。

【方剂】知柏地黄汤加减。

(三) 气虚型

【主证】妊娠数月，小便频数淋漓，欲解不能控制，解后疼痛，尿量不减，色白，有时淡黄，短气不足以吸，舌淡，苔正常，脉虚缓而滑。

【治法】益气止淋。

【方剂】益气止淋汤加减。

二十一、产后排尿异常

产后排尿异常是指分娩后发生小便不通，或尿意频数，甚至小便失禁而言。

(一) 气虚

【主证】产后小便不通，小腹胀急，少气懒言，四肢无力，面色少华，舌淡苔薄，脉缓而弱。

【治法】益气通利。

【方药】补中益气汤去升麻，加桔梗、通草、茯苓。

(二) 肾虚

【主证】产后小便不通，小腹胀满而痛，面色晦暗，腰膝酸软，舌淡苔润，脉沉细而迟。

【治法】补肾温阳，化气利水。

【方剂】《金匱》肾气丸加减。

(三) 产伤

【主证】排尿淋漓不断，或挟有血丝，舌正常，脉缓。

【治法】补气固脬。

【方剂】黄芪当归散加减。

二十二、不孕症

不孕症是指夫妇同居三年以上，或生育或流产后超过三年，未经避孕而不受孕者。前者属“原发性不孕”，古代医籍中称为“全不产”或“无子”；后者属“继发性不孕”，古代医籍称为“断绪”。本病引发原因较多，有因先天性生

理缺陷所致者，如古人所说“五不女”等，一般皆非药物所能治；有属病理性引发者，是属中药适应范围，常见证型有：

（一）肾虚

【主证】婚久不孕，月经后期，量少色淡，面色晦黯，腰酸腿软，性欲淡漠，小便清长或频数，大便不实，舌淡苔白，脉沉细或沉迟。

【治法】温肾养肝，调补冲任。

【方药】毓麟珠加紫河车、丹参、香附。

（二）肝郁

【主证】婚久不孕，经期先后不定，经来小腹胀痛，经行不畅，量少色黯，或带有血块，月经来前两乳胀痛，精神抑郁，烦躁易怒，舌质正常或暗红，苔薄白，脉弦。

【治法】舒肝解郁，养血理脾。

【方剂】开郁种玉汤加减。

（三）痰湿

【主证】婚后久不受孕，形体过胖，月经后延，甚至闭经，带下量多，质地粘稠，面色苍白，头晕心悸，胸闷泛恶，苔白腻，脉滑。

【治法】燥湿化痰。

【方药】启宫丸加海藻、昆布、菖蒲。

二十三、小儿泌尿系感染

泌尿系感染是由病原体感染尿路而引的尿路炎症，包括尿道炎、膀胱炎、输尿管炎和肾盂肾炎。临床以发热、尿

频、尿急、尿痛及排尿困难为主要表现。婴幼儿发病率较高，女孩多于男孩。根据临床表现和病程分为急性慢性两种，慢性患者常伴有先天畸形。

本病属于祖国医学“淋证”范畴。其发病原因以膀胱湿热为主，湿热多感受于外，亦可由内而生，如外阴不洁，秽浊之邪上犯膀胱；或心经火热，传入小肠，热移膀胱；或脾胃湿热，蕴积中焦，下注膀胱；或肝胆郁热，气火伤及下焦，均可导致膀胱气化不利，从而引发本症。本病的病位在肾与膀胱，初起以邪气实为主，正邪相搏，表现为实热证，是本病急性阶段。湿热久稽，则耗伤气阴；或因先天畸形，禀赋不足，肾气虚弱，复感湿热，表现为脾肾两虚，肾阴不足，同时兼有湿热之邪者，属正虚邪恋的慢性阶段。

（一）急性期

1. 膀胱湿热

【主证】尿急，尿频，尿痛，小便短赤，少腹胀痛，或伴腰痛，婴儿则在小便时哭闹不安，或见发热寒战，恶心呕吐等，舌苔黄腻，脉濡数。

【治法】清热利湿。

【方剂】八正散加减。

2. 肝胆郁热

【主证】发热恶寒，小便短赤，频急涩痛，脐腹胀满疼痛，或口苦纳呆，恶心呕吐，烦躁不安，腰酸胁痛，舌苔黄腻，脉弦数，指纹紫。

【治法】清利肝胆，泻火解毒。

【方剂】龙胆泻肝汤加减。

（二）慢性期

1. 脾肾两虚，湿热未清

【主证】小便频急，艰涩疼痛，淋漓不已，时作时止，兼见面色苍白，气短懒言，纳呆腹胀，倦怠乏力，腰酸便溏，舌淡苔白，脉沉细无力。

【治法】健脾补肾，佐以渗湿。

【方剂】四君子汤合《济生》肾气丸。

2. 肾阴不足，湿热留恋

【主证】小便淋漓涩痛，尿急尿频，日久不已，时作时止，兼见头晕耳鸣，潮热盗汗，咽干唇燥，五心烦热，腰膝酸软，舌红少苔或无苔，脉细数。

【治法】滋阴清热。

【方剂】知柏地黄丸加减。

二十四、小儿急性肾炎

急性肾炎是急性出血性肾小球肾炎的简称，是以两侧肾脏弥漫性肾小球损害为主的反应性疾病。本病为小儿时期常见疾病之一。本病的发生，外因为感受外邪、水湿或疮毒入侵；内因主要是肺、脾、肾三脏功能失常。临床以全身浮肿、少尿、血尿和高血压为主要表现。治疗本病常用发汗、利尿、逐水、清热解毒及益气健脾等法，尤以清热解毒为其主要治法。

（一）急性期

1. 风水型

【主证】眼睑浮肿，继则全身浮肿，肢节酸重，尿少，咳嗽，苔薄白，脉浮或浮数或弦。

【治法】宣肺利水。

【方剂】越婢汤加减。

2. 湿热型

【主证】肢体浮肿，小便短赤，或色如浓茶，发热神烦，皮肤疮毒，舌苔黄腻，脉象沉数。

【治法】清热解毒，利湿消肿。

【方剂】五味消毒饮加减。

3. 寒湿型

【主证】面黄腹胀，肢体浮肿，倦怠乏力，胃纳欠佳，小便短少，舌质淡，苔白腻，脉濡缓。

【治法】渗湿利水消肿。

【方剂】五苓散合五皮饮加减。

4. 变证

(1) 水气上凌心肺

【主证】肢体浮肿，咳呛，气急，心悸，胸闷，烦躁不能平卧，舌苔白或白腻，脉细数无力。

【治法】泻肺逐水，宁心安神。

【方剂】己椒苈黄丸加味。

(2) 邪犯心肝

【主证】头痛，眩晕，烦躁，口苦，尿赤，甚至惊厥，抽搐，昏迷，舌质红，苔黄干糙，脉弦。

【治法】平肝泻水，利湿开窍。

【方剂】龙胆泻肝汤加减。

(3) 水毒内闭

【主证】尿少，尿闭，头晕，头痛，恶心，呕吐，甚至昏迷，舌苔腻，脉滑或数。

【治法】泻水降浊。

【方剂】温胆汤加大黄、牵牛子。

（二）恢复期

此期多表现正虚邪恋证候，一方面脾肾虚弱，另一方面湿热余邪未清。脾虚者证见倦怠乏力，胃纳呆滞，面色苍黄，舌淡苔白，脉缓弱。治宜健脾益气，方选参苓白术散加减。若兼见舌红少苔或无苔，脉细数，此属肾阴不足，治宜补益肾阴，方用六味地黄丸加女贞子、桑寄生，若显微镜下检查血尿不消者，酌加白茅根、旱莲草、小蓟等凉血止血之味。兼见胁肋刺痛，固定不移，舌紫，脉涩等血瘀征象，可合用桃红四物汤活血化瘀。上述各型见有血压升高者，可加夏枯草、石决明平肝潜阳。蛋白尿不消失者，可加黄芪、蝉衣、苏叶等药。

二十五、小 儿 肾 病

肾病，又称肾病综合征。是小儿泌尿系统常见疾病，特别是3～8岁小儿，发病者较多。男孩多于女孩。本病临床特点为：全身显著浮肿，大量蛋白尿，低蛋白血症，血胆固醇增高。依据小儿肾病表现特点，一般多归属于中医“水肿”范畴，故以此指导辨证治疗。

（一）脾虚湿困

【主证】肢体浮肿，按之凹陷，面色萎黄，疲乏无力，精神倦怠，脘闷腹胀，纳食减少，大便溏薄，小便短少，舌质淡，苔白滑，脉沉缓或细弱。

【治法】益气，健脾，利水。

【方药】参苓白术散加减。

（二）脾肾阳虚

【主证】面色苍白或灰黯，神疲畏寒，四肢不温，全身高度浮肿，甚至伴有胸水、腹水，尿少腹胀，食欲减退，恶心呕吐，甚则咳逆上气，不得平卧，舌淡胖，苔白，脉沉细无力。

【治法】温阳利水。

【方药】真武汤加味。

（三）肝肾阴虚

【主证】面色潮红，眩晕头痛，烦躁不安，手足心热，或有微肿，舌红少苔，脉弦细数。

【治法】补肾滋阴，平肝潜阳。

【方药】杞菊地黄丸加减。

二十六、小 儿 遗 尿

小儿遗尿亦称“尿床”，是指3周岁以上小儿，睡眠中小便自遗，醒后方觉的一种病证。3岁以下小儿因智力发育未臻完善，排尿正常习惯尚未养成，或贪玩少睡，过度疲劳，以致暂时遗尿，不属病态，无须药物治疗。若3岁以上仍不能正常控制排尿，甚至每睡即遗，常此以往则属病态，应予治疗。

（一）下元虚寒

【主证】每于睡眠中遗尿，一夜1~2次甚至更多，醒后始觉尿床，面色苍白，智力迟钝，腰膝酸软，小便清长或频数，畏寒肢冷，舌淡苔白，脉沉迟无力。

【治法】温补肾阳，固摄下元。

【方药】桑螺蛸散合巩堤丸加减。

（二）脾肺气虚

【主证】多发于病后，睡中遗尿，频数量少，面色苍白，神疲乏力，食欲不振，大便清薄，舌淡苔白，脉缓或沉细。

【治法】培元益气，佐以固涩。

【方药】补中益气汤合缩泉丸加减。

（三）肝经湿热

【主证】睡中遗尿，尿黄臊臭，性情急躁，或夜间齟齿，面赤唇红，舌苔薄黄，脉象弦滑。

【治法】泻肝清热。

【方药】龙胆泻肝汤加减。

二十七、新生儿不乳

新生儿不乳又称“难乳”，是指小儿出生12~24小时以后尚不能吮乳而言。

（一）元气虚弱

【主证】婴儿未足月，或有难产史，形神虚怯，气息微弱，哭声低沉，面白唇淡，无力吮乳。

【治法】培补元气。

【方药】先予独参汤，继以四君子汤加减治疗。

（二）脾胃虚寒

【主证】生后不乳，面色苍白，四肢欠温，口鼻气冷，腹部冷痛而曲背啼哭，唇舌色淡。

【治法】温中散寒，健脾行气。

【方药】匀气散加减。

(三) 秽热郁积

【主证】生后不乳，腹部胀满，大便不通，小便短赤，或兼呕吐，啼哭声粗，烦躁不宁，气息短促，舌苔黄厚而腻。

【治法】逐秽清热通便。

【方药】先调服一捻金，继用生葛根捣汁或干葛根煎汤灌服。

二十八、新生儿大便不通

新生儿大便不通，又称“锁肚”。婴儿出生后，一般在24小时内即可排出暗绿色粘稠无臭之胎粪。3~4天后逐渐转为婴儿便。如出生2天以上而无大便排出，则属本病。

(一) 胎热壅结

【主证】大便不通，肚腹胀满，甚则呕吐，烦躁多啼，面赤唇红，口舌干燥。

【治法】清热散结，行气通下。

【方药】一般可先用金银花、黄连、甘草煎水调入适量白蜜，多次分服。数小时后无效，继用沆瀣丹治之。

(二) 胎禀不足

【主证】大便不通，面色苍白，神疲气怯，啼声低微，口舌润滑。

【治法】先予培补元气，继用霍脐法和导便法治疗。

(三) 先天性畸形

【主证】肛门闭锁或狭窄等，大便不通，腹部膨胀，呕吐频作，甚至可有胆汁或粪便吐出，烦躁啼哭。

【治法】手术治疗。

二十九、新生儿小便不通

新生儿小便不通，是指出生后48小时无小便排出而言。除先天性泌尿道畸形外，常见症候主要为：

（一）元气虚弱

【主证】生后小便不通，小腹作胀，面白唇淡，形神怯弱，啼哭声低，口舌润滑。

【治法】培补元气，温化利水。

【方药】独参汤调服五苓散。

（二）热蕴膀胱

【主证】小便不通，小腹作胀，唇红口干，烦躁多啼。

【治法】清热利水。

【方药】导赤散加黄连、滑石、车前子等治疗。

三十、解 颅

胎儿出生以后，各颅骨间的骨缝及囟门均未接合。一般在一岁半以内逐渐闭合。囟门闭合的过程，可作为判断小儿生长发育是否正常的依据。若囟门不能应期闭合，反变宽大，头缝开解，头颅逐渐增大，则称为解颅。重症可影响小儿体格和智力发育。本病主要由于胎元禀赋不足，肾气亏损，不能生髓养骨；或生后大病，肾阴耗损，水不胜火，火气上炎，蒸灼脑髓；或后天失调，脾失健运，升降失常，饮邪上犯，停聚颅内，均可导致颅缝逾期不合，颅缝开解而成

解颅。

(一) 肾气亏损

【主证】小儿生后囟门逾期不合，或合而复开，逐渐加宽，头颅明显增大，头皮光急，青筋暴露，眼眶紧小，目珠下垂，白多黑少，目无神采，面色苍白，神老呆钝，头大颈细，头倾偏倒，身体瘦弱，发育迟缓，舌淡苔白，脉细弱无力。

【治法】补肾益髓。

【方剂】补肾地黄丸加减。

(二) 肾虚髓热

【主证】囟门不合，反变宽大，头缝开解，头颅渐大，手足心热，口干唇红，烦躁不安，甚至四肢拘急抽搐，舌红少苔，脉细数。

【治法】滋水制火。

【方剂】六味地黄丸加减。

(三) 脾虚水泛

【主证】囟门宽大，头缝开解，头皮光急，青筋浮露，面色萎黄，精神倦怠，食欲不振，腹胀便溏，或见呃逆，舌淡苔腻，脉缓而弱。

【治法】健脾祛湿，通阳利水。

【方剂】苓桂术甘汤合五苓散加减。

三十一、鸡胸、龟背

患儿的胸廓向前突出，形似鸡胸的，称为鸡胸，脊骨弯曲隆起，状如龟背的，称为龟背。同属小儿生长发育障碍，骨骼

畸形的疾患。可以分别发生，亦可同时并见。鸡胸的形成，主要因婴儿先天禀赋不足，后天调护失宜，以致脾肾亏损，精血两虚，骨髓不充，骨质柔弱而致。鸡胸已成，肺脏受逼，痰涎蕴伏，在风热邪毒相干时，亦可出现痰热壅肺证。龟背的形成亦因婴儿先天禀赋不足，后天调护失宜，肾气亏损，督脉虚而脊柱柔软而致。亦有因风寒湿邪外袭，壅滞经络，气血运行受阻，脊骨失养以致痿弱弯曲而成龟背者。

（一）鸡胸

1. 脾肾亏损

【主证】胸廓突出，状如鸡胸，颅囟迟合，形体羸瘦，精神萎靡，面白自汗，气短乏力，肌肉松弛，腹胀便溏，语言迟缓，舌淡苔白，脉缓无力。

【治法】培补脾肾。

【方剂】补天大造丸加减。

2. 痰热壅肺

【主证】胸廓突出如鸡胸，咳嗽气粗，痰涎壅盛，气喘喉鸣，唇红口干，或见发热，舌苔浊腻，脉滑数，指纹紫滞。

【治法】宣肺理气，清热化痰。

【方剂】宽气散加减。

（二）龟背

1. 肾气亏损

【主证】脊柱弯曲如龟背，行步伛偻，面色苍白，形体羸瘦，神疲乏力，智力呆钝，肢冷汗出，舌淡苔白，脉沉细无力。

【治法】补气益肾，滋补精髓。

【方剂】左归丸合龟鹿二仙胶加减。

2. 风寒入脊

【主证】恶寒，发热，头痛，脊背肿痛，日久则脊骨弯曲不伸，隆起如龟背，舌淡苔白，脉象浮紧或细弱。

【治法】疏风散寒，活血通络。

【方剂】枳壳防风丸加减。

三十二、五迟、五软

五迟、五软均属于小儿发育障碍，成长不足的疾患。五迟，是指立迟、行迟、发迟、齿迟和语迟等。五软，是头项、口、手、足和肌肉痿软无力的病证，本类症候多见于一、二周岁的婴幼儿，往往是因先天不足及后天失养而造成的，若不注意及时调养和治疗，或治疗不当，常常可成为痼疾。

五迟的症候，可由父母气血虚弱，先天胎禀不足，或后天护养失宜，饮食不调，或疾病缠绵，治理不当，均可使小儿肝肾亏损，气血不足而发为本病。因肾主骨，肝主筋，肝肾亏损，则筋骨痿弱，故见“立迟”，“行迟”和“齿迟”等候。言语为智慧的一种表现，为心所主，心气不足，则智力不发达，而语言迟缓，故见“语迟”。发乃血之余，肾之苗，肾气不充，血虚失养则可出现“发迟”。

引起五软的病因，主要由于先天禀赋不足，肝肾亏损，气血虚衰。肾藏精，主骨、生髓，为生长之本。肾亏则精乏、骨弱，髓不充，发育迟缓。亦有因护理不当，或乳食失调，似致脾胃虚弱。脾为后天之本，生化之源，主肌肉四肢口唇。脾虚故四肢痿软无力、肌肉松弛，可出现头软不举，

口软不食，手软不握，足软不立，肌软无力。甚至血不养神，可引起神情呆滞，反应迟钝等软弱症状。

（一）五迟

1. 肝肾亏损

【主证】面色苍白，筋骨痿弱，站立、行步、或长齿均迟缓，目无神采，智力迟钝，平素活动少，容易疲倦，舌苔薄白，舌质淡，脉沉有力，指纹淡。

【治法】培补肝肾。

【方剂】加味六味地黄丸。立迟、行迟者，可与虎骨散交替使用。齿迟者，可与汤氏芎黄散同服。

2. 心气不足

【主证】智力不全，神情呆滞，不哭不闹，数岁不语，言语不清晰，肌肤苍白，发稀萎黄，食少，便秘，苔光，脉迟无力，指纹淡。

【治法】补心养血。

【方剂】菖蒲丸加减。

3. 气血不足

【主证】肌肤苍白，精神不振，疲倦乏力，头发稀疏萎黄，舌质色淡，脉象细弱。

【治法】补益气血，滋养肾阴。

【方剂】胡麻丹加减。

（二）五软

1. 脾肾两亏

【主证】头项软弱倾斜，不能抬举。口软唇薄，咀嚼乏力，常有流涎。手软下垂，不能握举。足软弛缓，不能站立，肌肉松弛，活动无力。唇淡苔少，脉沉有力，指纹淡。

【治法】补肾健脾。

【方剂】补肾地黄丸合补中益气汤加减。

2. 气血虚弱

【主证】肢体软弱，四肢关节柔软，可任意攀翻。神情呆滞，智力迟钝，面色苍白，四末不温，口开不合，舌伸口外。食少不化，唇白苔光，脉沉无力，指纹淡。

【治法】益气养血。

【方剂】调元散加减。